Perfil V3 · código por código

Obstetricia y Ginecología

Los 91 códigos del Perfil de Conocimientos EUNACOM v3 (2026) de Obstetricia y Ginecología, uno por uno: el nivel que exige el examen, dónde se enseña en nuestros libros, lo que hay que saber en resumen y una pregunta.

Niveles del Perfil — Diagnóstico: **Sospecha** (reconocer y derivar) o **Específico** (confirmar). Tratamiento: **Inicial** (estabilizar y derivar) o **Completo**. Seguimiento: **Derivar**, **Completo** o **No requiere**.

Situaciones clínicas 32 códigos

3.01.1.001 Aborto espontáneo

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 19.10 Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030

QUÉ HAY QUE SABER

- Metrorragia del 1.er trimestre con o sin dolor cólico: primero tacto vaginal (OCI abierto o cerrado), luego ecografía transvaginal; siempre beta-hCG y hemodinamia.
- OCI cerrado: embrión con latidos = amenaza de aborto; embrión ≥7 mm sin latidos o saco sin embrión = aborto retenido; cavidad vacía con endometrio fino = aborto completo.
- OCI abierto con restos en la cavidad = aborto incompleto (o en evolución); saco intrauterino descarta el ectópico en la práctica.
- Manejo inicial: amenaza → reposo relativo y control; retenido/incompleto <12 semanas estable → misoprostol 800 μg vaginal o sublingual, o AMEU (preferible al legrado: menos perforación y sinequias).
- Rh negativo no sensibilizada: inmunoglobulina anti-D dentro de 72 h. Banderas rojas: shock hipovolémico (vías gruesas y evacuar), fiebre con flujo fétido (aborto séptico).
- Seguimiento: derivar a ginecología; estudio de aborto recurrente desde 3 pérdidas consecutivas.

PREGUNTAS (6)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 68

Mujer de 28 años con antecedente de 3 abortos espontáneos en primer trimestre y episodio de sangrado vaginal profuso durante el embarazo actual. **¿Cuál es el estudio más adecuado para investigar la causa?**

A) Panel de trombofilias (anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina, anti-β2-glicoproteína I)
B) Cariotipo de los padres
C) Histeroscopia diagnóstica
D) Progesterona en fase lútea
E) TSH y T4 libre

Respuesta A. Abortos recurrentes del primer trimestre: se debe descartar síndrome antifosfolípido con anticoagulante lúpico, anticardiolipina y anti-β2-glicoproteína I. Es la causa tratable más importante.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 97

Paciente de 21 años consulta por fiebre hasta 38,9 grados, dolor hipogástrico intenso y sangrado vaginal de mal olor, iniciado hace 48 horas. Tiene frecuencia cardíaca de 120, presión arterial de 90/60 y temperatura de 38,7 grados. En la especuloscopía se observan sangre y restos ovulares de mal olor. El útero está muy doloroso a la palpación. La ecografía transvaginal muestra contenido uterino irregular de 18 milímetros. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar histerectomía
B) Realizar laparoscopía exploradora
C) Administrar antibióticos endovenosos y realizar evacuación uterina
D) Administrar metotrexato
E) Administrar misoprostol y conducir el trabajo de aborto

Respuesta C. Fiebre, taquicardia, restos ovulares de mal olor y útero muy doloroso: aborto séptico con restos retenidos. Se cubre primero con antibióticos endovenosos de amplio espectro y luego se evacúa la cavidad con AMEU o legrado.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 20

Paciente de 32 años, cursando un embarazo de 6 semanas por amenorrea, consulta por metrorragia de un día de evolución, sin otros síntomas. En la especuloscopía se observa salida de sangre por el orificio cervical externo. La ecografía transvaginal muestra un saco gestacional colapsado a nivel del istmo. La subunidad beta de gonadotrofina coriónica resulta 5.500 unidades internacionales por litro. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Aborto retenido
B) Amenaza de aborto
C) Aborto incompleto
D) Embarazo ectópico
E) Mola hidatiforme

Respuesta C. La visualización de un saco gestacional dentro del útero descarta el embarazo ectópico. Un saco colapsado, migrando hacia el cuello, con beta-hCG que ya no corresponde a un embarazo en curso, define el aborto incompleto.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 159 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 25 años, con antecedente de atraso menstrual de 6 semanas, consulta por metrorragia. Su test de embarazo es positivo. Su especuloscopía confirma metrorragia que proviene del orificio cervical y su tacto vaginal muestra un cuello cerrado, duro y de ubicación posterior. Se solicita una ecografía obstétrica que muestra lo siguiente: FOTO (Ecografía obstétrica con un saco gestacional de 11mm). ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Dar misoprostol
B) Realizar legrado
C) Controlar con nueva ecografía en 7 días
D) Realizar laparoscopía
E) Dar metotrexato

Respuesta C. Tiene una amenaza de aborto, sin modificaciones cervicales, por lo que hay que observar. Además, la ecografía era normal, ya que el saco gestacional era menor a 18mm. Se controla con una EcoTV en 7 días, o antes, si empeoran los síntomas.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 168 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente, primigesta, presenta 4 semanas de atraso menstrual, por lo que se realiza test de embarazo, que resulta positivo. Se realiza una ecografía transvaginal, que muestra un saco gestacional intrauterino, con un embrión de 3 mm, sin latidos. La beta-HCG resulta 6.800 UI/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Repetir la beta-HCG en 48 horas
B) Indicar metotrexato
C) Realizar nueva ecografía en 7 días
D) Realizar legrado en 14 días
E) Realizar legrado inmediatamente

Respuesta C. Para diagnosticar un aborto retenido, se necesita que el embrión tenga más de 5 mm. Como tiene 3, se debe controlar en 7 a 10 días, con una nueva Eco. Si continúa sin latidos, se puede legar u observar por 2 semanas, a espera de que inicie espontáneamente el trabajo de aborto (si no inicia, se legra).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 61 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 23 años, con antecedente de 2 abortos previos de primer trimestr

E) Actualmente cursa un nuevo embarazo de 8 semanas, siendo diagnosticada de aborto retenido, mediante ecografía transvaginal. ¿Cuál es el estudio inicial para esta paciente?

A) Histerosalpingografía
B) Cariograma al padre y a la madre
C) Histeroscopía
D) Estudio de trombofilia

Respuesta C. La alternativa correcta es la C (Histeroscopía). Las lesiones de extremidades inferiores más importantes son la fractura de fémur, la fractura de pierna y la fractura de tobillo. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

3.01.1.002 Anemia y embarazo

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **No requiere**

Dónde se enseña: Tema 19.1 Control Prenatal de Bajo Riesgo: Calendario, Suplementación (Ácido Fólico, Calcio, Fierro) y Exámenes por Trimestre

QUÉ HAY QUE SABER

- Anemia en el embarazo: Hb <11 g/dL en 1.er y 3.er trimestre (<10,5 g/dL en el 2.º); la hemodilución fisiológica baja la Hb pero no bajo esos cortes.
- La causa más frecuente es ferropénica: microcitosis (VCM <80 fL) y ferritina baja (<15–30 ng/mL); hemograma en el primer control y repetir a las 28 semanas.
- Profilaxis: hierro 30–60 mg/día desde las 16–20 semanas; ácido fólico 0,4–1 mg/día preconcepcional hasta las 12 semanas (4–5 mg si alto riesgo de DTN).
- Tratamiento: hierro oral elemental 100–200 mg/día (ej. sulfato ferroso) lejos de comidas, con vitamina C; control de Hb y reticulocitos en 2–4 semanas.
- Hierro endovenoso si hay intolerancia, malabsorción o falta de respuesta; transfusión solo en anemia grave sintomática o hemorragia.
- Macrocítica: sospechar déficit de B12 (veganas) o folato. Seguimiento: no requiere derivación; el médico controla la respuesta hasta normalizar Hb y depósitos.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 53

Embarazada de 20 semanas, asintomática, con hemoglobina de 9,0 g/dL, VCM de 72 fL (microcítica) y ferritina de 8 ng/mL. **¿Cuál es el tratamiento de elección?**

A) Hierro oral elemental 200 mg/día
B) Transfusión de glóbulos rojos
C) Hierro endovenoso
D) Vitamina B12 intramuscular
E) Ácido fólico

Respuesta A. Anemia ferropénica del embarazo (Hb bajo 11 g/dL, microcitosis y ferritina baja) en paciente asintomática: el tratamiento de primera línea es hierro oral en dosis terapéutica. El hierro endovenoso se reserva para intolerancia, malabsorción o falta de respuesta; la transfusión, para anemia grave sintomática o hemorragia.

3.01.1.003 Colestasia gravídica

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 19.8 Colestasia Intrahepática del Embarazo (CIE): Prurito Palmoplantar, Ácidos Biliares y Ácido Ursodesoxicólico

QUÉ HAY QUE SABER

- Colestasia intrahepática del embarazo: prurito palmoplantar de predominio nocturno en el 3.er trimestre, que luego se generaliza, sin lesiones primarias (solo escoriaciones).
- Ictericia en 10–15%, posterior al prurito; transaminasas elevadas en 60–80%. Confirma y estratifica: ácidos biliares séricos totales (≥10 μmol/L).
- Diferencial: hígado graso agudo (falla hepática, hipoglicemia), HELLP (plaquetopenia, HTA), hepatitis viral, erupción polimorfa (con pápulas y placas).
- Tratamiento inicial: ácido ursodesoxicólico 10–15 mg/kg/día VO en 2–3 tomas; antihistamínico para el prurito.
- Riesgo: muerte fetal súbita (arritmia o vasoespasmo) que el monitoreo no predice; la prevención es la interrupción programada según ácidos biliares (≥100 μmol/L: 34–36 semanas; en general 37 semanas).
- Seguimiento: derivar a alto riesgo obstétrico; recurre en embarazos siguientes y con anticonceptivos con estrógenos.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 46

Paciente de 34 años, con embarazo de 32 semanas, inicia prurito de palmas y plantas más intenso en la noche, asociado a astenia y vómitos. Leve ictericia de escleras, sin lesiones cutáneas. Bilirrubina 1,5 mg/dL, fosfatasas alcalinas 411 UI/L, GGT 398 UI/L. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Colestasia intrahepática
B) Colangitis biliar primaria
C) Ictericia por hiperémesis gravídica
D) Hígado graso agudo del embarazo
E) Coledocolitiasis

Respuesta A. Prurito palmoplantar nocturno sin lesiones primarias, con patrón colestásico de laboratorio, en el tercer trimestre, es el cuadro clásico de CIE. El diagnóstico es clínico; los ácidos biliares complementan la sospecha.

Pregunta de práctica

¿Por qué motivo la monitorización fetal electrónica anteparto habitual, el registro basal no estresante semanal, no es suficiente para garantizar la seguridad fetal en una colestasia intrahepática severa? **¿Cuál es la explicación correcta?**

A) Porque los ácidos biliares impiden la transmisión de las ondas Doppler
B) Porque la muerte fetal en CIE ocurre por un evento súbito de arritmia o vasoespasmo, sin hipoxia crónica previa
C) Porque todos los fetos con CIE presentan taquicardia basal fija irreversible
D) Porque la colestasia solo afecta a la madre y el feto nunca tiene complicaciones
E) Porque el ácido ursodesoxicólico altera artificialmente el trazado cardiofetal

Respuesta B. A diferencia de la insuficiencia placentaria crónica que sí se detecta con monitoreo, en la CIE el óbito ocurre de forma aguda e impredecible por toxicidad directa de los ácidos biliares sobre el miocardio fetal. Por eso la única estrategia eficaz es la interrupción programada.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 85 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 25 años, con 33 semanas de embarazo, consulta por prurito de predominio palmo-plantar, pero que en ocasiones es generalizado. Refiere que es más intenso en la noche. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?

A) Transaminasas
B) Ecografía abdominal
C) Ácidos biliares
D) Fosfatasas alcalinas
E) Bilirrubina total y diferenciada

Respuesta D. El diagnóstico de la colestasia intrahepática es clínico y no requiere de exámenes. Sin embargo, las fosfatasas alcalinas se elevan con mucha frecuencia, mientras que la bilirrubina puede ser normal.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 153 · texto original del banco, sin revisar

Mujer cursando embarazo de 37 semanas, consulta por prurito palmo-plantar. En los exámenes destacan ácidos biliares de 110- 112, conducta:

A) Interrupción del embarazo
B) Ácido ursoderxecolico
C) Antihistamínicos 154. Paciente con sd nefrotico y hipergammaglobulinemia policlonal, complemento bajo. Diagnóstico:
A) Lupus
B) Amiloidosis

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Interrupción del embarazo (opción A). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

3.01.1.004 Diabetes y embarazo

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.3 Diabetes y Embarazo: Gestacional (DMG) vs Pregestacional (DMPG) · Tema 2.4 Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante · Tema 19.7 Diabetes Gestacional y Pregestacional: Tamizaje PTGO 75g (24-28 sem), Metas Glucémicas e Insulinoterapia

QUÉ HAY QUE SABER

- Glicemia de ayuno en el 1.er control: <100 normal; 100–125 repetir y si se confirma = diabetes gestacional precoz; ≥126 (o ≥200 al azar) = diabetes pregestacional.
- Si la basal es normal: PTGO 75 g a las 24–28 semanas a todas; glicemia a las 2 h ≥140 mg/dL = diabetes gestacional (139 es normal).
- Riesgos: la pregestacional mal controlada causa malformaciones (cardiopatías, regresión caudal, DTN); la gestacional típica no malforma, pero da macrosomía, distocia de hombros e hipoglicemia neonatal.
- Manejo inicial: dieta fraccionada (4 comidas y 2 colaciones), actividad física y automonitoreo; metas: ayuno <95 (ideal 70–90), 1 h postprandial <140, 2 h <120 mg/dL.
- Insulina (NPH ± rápida) si >20% de controles fuera de meta tras 1–2 semanas de dieta; metformina no es primera línea (cruza la placenta). Suspender antidiabéticos orales y pasar a insulina en la pregestacional.
- Seguimiento: derivar a policlínico de alto riesgo obstétrico; reclasificar con PTGO 6–12 semanas posparto (alto riesgo futuro de DM2).

PREGUNTAS (6)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 9

Una paciente embarazada de 32 semanas, con altura uterina: 38 cm e IMC: 33 se realiza una ecografía obstétrica, que muestra feto creciendo en percentil 93, con ILA: 12. Se solicita test de tolerancia a la glucosa oral, que resulta 92 mg/dl basal y 170 mg/dl a las dos horas postcarga de glucosa. **¿Cuál es la causa más probable de la condición fetal?**

A) Diabetes mellitus gestacional
B) Obesidad materna
C) Diabetes mellitus pregestacional
D) Incompatibilidad de grupo Rh
E) Síndrome hipertensivo del embarazo

Respuesta A. Feto grande para la edad gestacional (sobre p90) con prueba de tolerancia alterada en el tercer trimestre: macrosomía por diabetes gestacional. La hiperglicemia materna provoca hiperinsulinismo fetal, que actúa como hormona de crecimiento.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 60

Mujer de 35 años, con embarazo de 15 semanas, sin síntomas. En exámenes de control destaca VDRL negativo, hemoglobina de 11,5 mg/dL y glicemia de ayuno de 108 mg/dL. Examen físico normal, con altura uterina acorde. **¿Cuál es la conducta más adecuada en este caso?**

A) Solicitar test de tolerancia oral a la glucosa
B) Indicar dieta y mantener el control habitual
C) Solicitar hemoglobina glicosilada
D) Indicar insulina subcutánea
E) Solicitar una nueva glicemia de ayunas

Respuesta E. Glicemia de ayuno entre 100 y 125 mg/dL: se repite el examen, no se salta a la prueba de tolerancia ni se trata todavía. La PTGO se reserva para las 24 a 28 semanas, salvo que la segunda glicemia confirme la diabetes gestacional precoz.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 38

Paciente de 31 años, con embarazo de 28 semanas, se realiza una prueba de tolerancia a la glucosa con 75 gramos, que resulta 75 mg/dL basal y 160 mg/dL a las 2 horas. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Intolerancia a la glucosa
B) Diabetes gestacional
C) Diabetes pregestacional
D) Diabetes mellitus 2
E) Resistencia a la insulina

Respuesta B. La glicemia a las 2 horas de 160 mg/dL, sobre el corte de 140, define diabetes gestacional. No es pregestacional, porque esa se diagnostica con glicemias de ayuno de 126 mg/dL o más, y esta paciente ya está en el segundo trimestre.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 73

Paciente de 37 años, con embarazo de 29 semanas, se realiza una prueba de tolerancia a la glucosa de 75 gramos, con glicemia basal de 86 mg/dL y postcarga de 139 mg/dL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar dieta hipoglucídica y controlar con glicemias seriadas
B) Solicitar hemoglobina glicosilada
C) Iniciar metformina
D) Repetir el examen a las 32 semanas
E) Mantener el control habitual del embarazo

Respuesta E. La glicemia a las 2 horas de 139 mg/dL queda justo bajo el corte de 140 mg/dL: el resultado es normal y no requiere dieta especial ni fármacos.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 9

Una paciente embarazada de 32 semanas, con altura uterina de 38 cm e IMC de 33, se realiza una ecografía obstétrica que muestra feto creciendo en percentil 93, con ILA de 12. Se solicita test de tolerancia a la glucosa oral, que resulta 92 mg/dl basal y 170 mg/dl a las dos horas postcarga de glucosa. **¿Cuál es la causa más probable de la condición fetal?**

A) Diabetes mellitus gestacional
B) Obesidad materna
C) Diabetes mellitus pregestacional
D) Incompatibilidad de grupo Rh
E) Síndrome hipertensivo del embarazo

Respuesta A. Feto grande para la edad gestacional (percentil sobre 90) con PTGO de 2 horas ≥ 140 mg/dL: diabetes gestacional. La hiperglicemia materna produce hiperinsulinismo fetal y macrosomía. No es pregestacional, porque se diagnostica tarde y con valores bajo los de no embarazada.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 23 · texto original del banco, sin revisar

Embarazada de 8 semanas consulta por exámenes. Se realiza PTGO 75g: glicemia ayuno 88 mg/dL y a las 2 horas 140 mg/dL. ¿Cómo se interpreta este resultado?

A) Resistencia a la insulina
B) Normal para el embarazo
C) Diabetes pregestacional
D) Diabetes gestacional
E) Intolerancia a la glucosa gestacional

Respuesta B. PTGO en embarazo (ADA/OMS): diagnóstico de DG requiere glicemia ayuno ≥92, 1h ≥180 o 2h ≥153 mg/dL. Con 2h en 140 mg/dL (< 153), el resultado es NORMAL. Se realiza nueva PTGO a las 24-28 semanas si el riesgo persiste.

3.01.1.005 Embarazo con edad gestacional dudosa

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 19.2 Ecografía Obstétrica: 11-14 Semanas (Aneuploidías y Doppler Uterino) & 20-24 Semanas (Morfológica y Cervicometría)

QUÉ HAY QUE SABER

- Edad gestacional dudosa: FUM no recordada o no confiable (ciclos irregulares, uso de ACO o lactancia en los 3 meses previos, metrorragia del 1.er trimestre).
- El método más preciso es la ecografía precoz: longitud céfalo-nalgas entre 7 y 14 semanas (error ±3–5 días); el saco gestacional, la hCG y la altura uterina no sirven para datar.
- Si FUM y LCN difieren >5–7 días se corrige por la ecografía y esa pasa a ser la fecha oficial; si difieren menos, se mantiene la FUM.
- En el 2.º trimestre: diámetro biparietal, circunferencia craneana y fémur (error ±1–2 semanas); el cerebelo transverso es útil si se sospecha RCF. En el 3.er trimestre la datación es poco confiable (±3 semanas).
- Conducta inicial: solicitar ecografía lo antes posible y no recalcular la EG con ecografías posteriores. Seguimiento: derivar a alto riesgo si la ecografía es tardía, por el riesgo de mal diagnóstico de RCF o postérmino.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 98

Mujer con reglas irregulares y test de embarazo positivo. Recuerda la fecha de su última regla (FUR), pero por sus ciclos irregulares esta no es confiable. Tiene una amenorrea de 10 semanas. **¿Cómo se debe determinar la edad gestacional?**

A) Longitud céfalo-caudal
B) Diámetro del saco gestacional
C) Niveles de β-hCG
D) Según la FUR
E) Interrupción del embarazo

Respuesta A. Cuando la FUR no es confiable, la edad gestacional se establece por ecografía precoz. Entre las 7 y 14 semanas, la longitud céfalo-caudal (LCC) es el parámetro más exacto, con error de unos 5 a 7 días. El saco gestacional es menos preciso y la β-hCG no sirve para datar.

3.01.1.006 Embarazo ectópico no complicado

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 19.11 Embarazo Ectópico: Localizaciones, Diagnóstico con β-hCG Cuantitativa, Manejo Médico (Metotrexato) vs Quirúrgico

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospecha: dolor pélvico, atraso menstrual y metrorragia escasa con test de embarazo positivo; 95% tubárico (ampular el más frecuente).
- Factores de riesgo: ectópico previo (x5–10), PIP o salpingitis, cirugía tubaria, DIU, tabaquismo, fertilización asistida.
- Zona discriminatoria: beta-hCG ≥1.500–2.000 UI/L con útero vacío en la ecografía transvaginal = ectópico; bajo ese valor, repetir hCG en 48 h (el embarazo normal la duplica).

- Primera evaluación: hemodinamia y signos peritoneales; si está estable, derivar a urgencia gineco-obstétrica para confirmar y tratar.
- Metotrexato IM en dosis única si cumple todo: estable, hCG <5.000, masa <3,5 cm y sin latidos; si no, laparoscopía (salpingostomía si desea fertilidad, salpingectomía si no). Rh(–): anti-D.
- Seguimiento: derivar; control de hCG los días 4 y 7 tras metotrexato (descenso ≥15%) y luego semanal hasta negativizar.

PREGUNTAS (11)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 29

Una paciente de 24 años presenta amenorrea de 7 semanas de evolución, por lo que consulta. Su examen físico muestra frecuencia cardíaca de 80 por minuto, presión arterial de 120/80 mmHg, sin alteraciones en su examen ginecológico. **¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?**

A) Subunidad beta HCG
B) Niveles plasmáticos de FSH
C) Ecografía transvaginal
D) Niveles plasmáticos de prolactina
E) Niveles plasmáticos de TSH

Respuesta A. El estudio de la amenorrea debe comenzar siempre descartando el embarazo con beta hCG, incluso si la paciente ya tuvo un test previo negativo, antes de continuar con TSH, prolactina y FSH.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 29

Mujer de 24 años con amenorrea de 7 semanas. Su examen físico es normal. La beta-hCG plasmática resulta 4.000 unidades por litro, y la ecografía transvaginal muestra una masa anexial derecha de 3 centímetros, sin líquido libre. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Repetir los niveles de hCG en 48 horas
B) Realizar salpingostomía por laparotomía
C) Realizar salpingectomía por vía laparoscópica
D) Indicar metotrexato por vía intramuscular
E) Controlar con una ecografía en 10 días

Respuesta D. Beta-hCG sobre la zona discriminatoria con útero vacío confirma el ectópico. Cumple los tres criterios de metotrexato: hCG menor de cinco mil, masa menor de 3,5 centímetros, sin latidos.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 149

Mujer de 25 años, con atraso menstrual de 3 semanas y dolor abdominal de 5 días, mayor en la fosa ilíaca izquierda. La beta-hCG resulta 5.500 unidades por litro. La ecografía transvaginal muestra útero sin gestación intrauterina y un tumor anexial izquierdo de 53 milímetros, de aspecto complejo, sin líquido libre. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar laparoscopía exploradora
B) Realizar laparotomía exploradora
C) Indicar metotrexato
D) Solicitar ecografía en 7 días
E) Solicitar niveles de hCG y ecografía en 48 horas

Respuesta A. La masa mide más de 3,5 centímetros y la beta-hCG supera las cinco mil unidades: no cumple los criterios de metotrexato. Al no estar rota, la vía es laparoscópica, no la laparotomía.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 55 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 27 años presenta amenorrea de 7 semanas, por lo que se realiza un test de embarazo en orina, el que resulta positivo. Acude a control, solicitándose subunidad beta-HCG, que resulta 970 U/L y ecografía transvaginal, que muestra útero con endometrio de características normales, sin presencia de saco gestacional y visualización de un tumor anexial de 2,5 cm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar laparoscopía
B) Repetir la subunidad beta en 48 horas
C) Iniciar metotrexato
D) Repetir la ecografía en 48 horas
E) Repetir la ecografía en 7 a 10 días

Respuesta B. Embarazo ectópico vs. Embarazo normal: Se sospecha de un embarazo ectópico cuando una prueba de embarazo es positiva pero no se visualiza el saco gestacional en la ecografía. Para confirmar el diagnóstico, se debe analizar la subunidad beta de la gonadotropina coriónica humana (hCG). Si la concentración es mayor a 3500 U/L, se confirma el embarazo ectópico. Si es menor a 3500 U/L, se debe repetir

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 130 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 35 años con antecedente de enfermedad inflamatoria pélvica previa tratada, consulta por un cuadro de 24 horas de evolución de sangrado genital escaso y dolor abdominal bajo asociado a un test de embarazo en orina positivo. Refiere 6 semanas de amenorrea. Al examen físico sus signos vitales muestran FC: 82x', PA: 110/74 mmHg y se encuentra en buenas condiciones generales, sin alteraciones en el examen abdominal. Su especuloscopía muestra escaso sangrado uterino. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Solicitar ecografía y niveles plasmáticos de gonadotropina coriónica humana
B) Control con ecografía en 7 días
C) Realizar una laparoscopía exploradora inmediata
D) Realizar legrado uterino.
E) Solicitar una resonancia magnética nuclear de pelvis

Respuesta A. Metrorragia en el Embarazo: En una paciente con metrorragia en la primera mitad del embarazo (por las 6 semanas de amenorrea con prueba de embarazo positiva), se debe solicitar una ecografía para diferenciar entre aborto, embarazo ectópico y mola. Los niveles de gonadotropina coriónica humana ayudan a identificar embarazos ectópicos, con valores superiores a 3.500 UI/L y ecografía negativa para ge

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 3 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente consulta por atraso menstrual de 7 semanas y trae test de embarazo en orina, que resulta positivo. Se realiza una ecografía transvaginal, que no visualiza embarazo intrauterino y que constata la presencia de un tumor anexial derecho, complejo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar niveles de HCG en sangre
B) Solicitar una nueva ecografía transvaginal en 7 días
C) Solicitar marcadores tumorales en sangre
D) Solicitar proteína plasmática asociada al embarazo
E) Solicitar niveles de progesterona y estradiol

Respuesta A. Ante la sospecha de embarazo ectópico, se debe pedir HCG. Si es menor a 1.500 U/L, puede ser un embarazo normal, pero de menor edad gestacional y se debe esperar 48 horas y repetir la HCG. Si la HCG es mayor a 1.500 U/L, se confirma el diagnóstico (aunque en las recomendaciones norteamericanas más recientes, se sugiere esperar a que sea mayor a 3.500, o bien a que no suba al menos un 66% en 48 hor

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 155 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 27 años consulta por dolor abdominal bajo de 5 horas de evolución. Al examen físico tiene frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, presión arterial 110/70 mmHg, examen cardiopulmonar normal y abdomen blando, sin signos peritoneales, con dolor a la palpación del hipogastrio. Se solicita subunidad beta de gonadotropina coriónica que resulta en 1.000 UI/L y se realiza ecografía transvaginal que muestra endometrio de 17 mm, sin lesiones anexiales ni visualización de líquido libre en la pelvis. Además de hospitalizar, ¿cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar metotrexato
B) Realizar laparoscopía exploradora
C) Repe2r la gonadotropina coriónica en 48 horas
D) Realizar legrado uterino
E) Solicitar TAC de abdomen y pelvis

Respuesta C. La sospecha es un embarazo ectópico (prueba de embarazo positiva + ecografía negativa) no complicado (hemodinamia estable y ausencia de líquido libre). Por tener HCG menor a 3.500 UI/L también puede tratarse de un embarazo normal intrauterino, pero pequeño. Se debe controlar con HCG en 48 horas. Si aumenta al menos un 66% probablemente sea un embarazo normal; si eleva menos que eso, se confirma el

Pregunta real · EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 81 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 26 años, con atraso menstrual de 3 semanas, consulta por metrorragia escasa, sin dolor. Al examen físico. Se realiza ecografía transvaginal, que muestra tumor anexial de 3 cm, sin líquido libr

E) Los niveles de HCG resultan 3.400 UI/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?
A) Controlar con ecografía en 48 horas
B) Adminstrar metotrexato
C) Controlar con HCG en 48 horas
D) Realizar legrado

Respuesta C. La alternativa correcta es la C (Controlar con HCG en 48 horas). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Los niveles de HCG resultan 3.400 UI/L. ¿Cuál, Controlar con ecografía en 48 horas) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 124 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 23 años, nulípara, consulta por presentar metrorragia desde ayer, no asociado a otros síntomas. Se realizó prueba de embarazo en orina que resultó positiva. Al examen físico se aprecia sangre proveniente del orificio cervical externo. Se realiza ecografía transvaginal que muestra útero sin alteraciones y una masa anexial derecha solidoquística de tres centímetros de diámetro. Además se solicitan niveles de gonadotrofina coriónica que se encuentran en 700 mUI/mL. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Indicar tratamiento con metotrexato
B) Controlar con niveles de gonadotrofina coriónica y ecografía transvaginal en 48 horas
C) Controlar con nueva ecografía transvaginal en siete días
D) Hospitalizar y realizar salpingectomía derecha
E) Indicar reposo y controlar con niveles de gonadotrofina coriónica y ecografía transvaginal en siete días

Respuesta B. Como la metrorragia no es grave (si fuera grave habría que operar de inmediato por EE roto), se puede pedir la BetaHCG en 2 días, junto a la Eco, ya que está menor a 1.200. El diagnóstico probable es un embarazo de menor edad gestacional, con síntomas de aborto, vs un embarazo ectópico, con metrorragia, sin estar del todo roto. Recordar que los EE producen también metrorragia por la insuficiencia

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 77 · texto original del banco, sin revisar

Mujer de 24 años con amenorrea de 5 semanas y dolor hipogástrico leve. B-hCG cuantitativa: 800 mUI/mL. Ecografía transvaginal: no se visualiza saco gestacional intrauterino. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Alta con control en 1 semana
B) Repetir B-hCG en 48 horas (debe duplicar si el embarazo es viable)
C) Ecografía abdominal
D) Laparoscopia diagnóstica inmediata
E) Metotrexato intramuscular inmediato

Respuesta B. B-hCG 800 sin saco visible: la "zona discriminatoria" es ~1500-2000 mUI/mL para visibilizar saco por ecografía TV. Con 800, puede ser embarazo intrauterino muy precoz. Conducta: repetir B-hCG en 48h → si duplica, probablemente viable intrauterino; si sube <50% o baja, probable ectópico.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 81 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 32 años, usuaria de DIU, con antecedente FUR dudosa hace más de un mes, consulta por dolor abdominal bajo, asociado a escaso sangrado genital. Al examinarla, se constata PA: 110/70 mmHg, FC: 100x', abdomen blando, depresible, con dolor a la palpación de la zona abdominal baja. En el examen ginecológico se observan las guías del DIU y se aprecia escasa metrorragia, que proviene del orificio cervical externo. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?

A) Ecografía transvaginal
B) Gonadotropina coriónica plasmática
C) Radiografía de abdomen y pelvis
D) Laparoscopía exploradora
E) Hemograma y PCR

Respuesta B. La alternativa correcta es la B (Gonadotropina coriónica plasmática). Se sospecha un embarazo ectópico y es lo primero a descartarse.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

3.01.1.007 Embarazo múltiple

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: ob-21

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospecha: altura uterina mayor a la esperada, hiperémesis, hCG muy elevada, antecedente de fertilización asistida; la ecografía del 1.er trimestre confirma.
- Lo clave es definir la corionicidad entre las 11 y 14 semanas: signo lambda (bicorial) vs signo T (monocorial); el monocorial tiene más riesgo (transfusión feto-fetal).
- Riesgos maternos y fetales aumentados: parto prematuro, preeclampsia, diabetes gestacional, anemia, RCF, presentaciones anómalas e hemorragia posparto.
- Manejo inicial: suplementar hierro y ácido fólico, aspirina 150 mg si hay otro factor de riesgo de preeclampsia, y derivar a control en alto riesgo obstétrico.

- Vigilancia ecográfica seriada (cada 2 semanas desde las 16 si es monocorial); interrupción habitual: bicorial 37–38 semanas, monocorial biamniótico 36–37, monoamniótico 32–34 por cesárea.
- Seguimiento: derivar a especialista; vía de parto según presentación del primer gemelo (cefálico permite parto vaginal en bicorial).

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 54

Una paciente de 34 años, cursando su primer embarazo, gemelar, bicorial biamniótico, de 26 semanas de edad gestacional. Se controla con ecografía obstétrica, que visualiza un gemelo muerto, sin compromiso hemodinámico del gemelo sobreviviente. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar extracción del feto muerto
B) Realizar controles periódicos con dímero D
C) Interrumpir el embarazo
D) Realizar cesárea a las 37 semanas
E) Realizar controles periódicos con pruebas de coagulación

Respuesta E. En un embarazo bicorial de 26 semanas se puede mantener la conducta expectante, pero el feto muerto retenido es un gatillo obstétrico de CID. Se vigila con pruebas de coagulación, porque el dímero D se eleva normalmente durante el embarazo y no sirve para seguir a esta paciente.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 59

Paciente de 39 años, cursando un embarazo gemelar bicorial biamniótico de 36 semanas, acude a control. Está en buenas condiciones generales, sin síntomas, con signos vitales normales. La ecografía muestra al primer gemelo con peso fetal estimado de 2.850 g y al segundo con 2.750 g, con líquido amniótico normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar control ecográfico en una semana
B) Programar cesárea electiva a las 38 semanas
C) Inducir el parto de inmediato
D) Solicitar ecografía Doppler de arterias uterinas
E) Realizar cesárea de urgencia

Respuesta A. Gemelar bicorial no complicado, con crecimiento concordante y bienestar conservado: se mantiene vigilancia seriada y se interrumpe alrededor de las 37 a 38 semanas. A las 36 semanas no hay indicación de interrupción inmediata, y la vía de parto depende de la presentación del primer gemelo, no del embarazo gemelar en sí.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 143 · texto original del banco, sin revisar

ecografía-doppler, que muestra discordancia de crecimiento de 28%, perfil biofísico tranquilizador y doppler con aumento de la resistencia umbilical y flujo presente en diástole. Ambos fetos se encuentran en posición cefálica. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar cesárea ahora
B) Inducir el parto ahora
C) Realizar control seriado con doppler fetal
D) Administrar corticoides antenatales
E) Repetir el perfil biofísico

Respuesta C. Tiene gemelos discordantes (uno es 25% más chico que el otro), que, aunque la mayoría además cumple con que uno de ellos es RCIU, en este caso no se menciona. De todos modos, el manejo es similar al RCIU. En este caso, tiene un doppler con alteraciones, pero, de baja gravedad (aumento de la resistencia), ya que aún hay flujo en diástole. Por tanto, no es necesario interrumpir aún y se debe seguir

3.01.1.008 Enfermedad del trofoblasto

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 19.12 Enfermedad Trofoblástica Gestacional: Mola Completa vs Parcial, Criterios de Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG) y Seguimiento

QUÉ HAY QUE SABER

- Mola hidatiforme: metrorragia indolora del 1.er trimestre, útero mayor que la edad gestacional, hiperémesis y beta-hCG muy elevada (>100.000).
- Preeclampsia antes de las 20 semanas o hipertiroidismo con embarazo inicial: pensar en mola. Ecografía: patrón en tormenta de nieve (vesículas) sin embrión en la completa.

- Completa: 46,XX paterno, sin embrión, riesgo de neoplasia 15–20%; parcial: triploide 69, embrión malformado, riesgo 1–5%.
- Tratamiento inicial: evacuación por aspiración (AMEU) con oxitocina, biopsia de todo el material; Rh(–): anti-D. Derivar a ginecología.
- Seguimiento: beta-hCG semanal hasta 3 valores normales seguidos y luego mensual por 6 meses, con anticoncepción obligatoria.
- hCG que se estanca o sube = neoplasia trofoblástica gestacional: etapificar y quimioterapia (metotrexato); derivar a oncología ginecológica.

PREGUNTAS (8)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 82

Paciente de 25 años acude por metrorragia abundante de 2 días, con atraso menstrual de 4 semanas, dudoso por reglas irregulares. La palpación uterina muestra un útero aumentado de tamaño como para un embarazo de 12 semanas. La beta-hCG resulta 200.000 unidades por litro, y la ecografía transvaginal muestra imagen en tormenta de nieve. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Aborto en evolución
B) Embarazo ectópico roto
C) Mola hidatiforme
D) Metrorragia disfuncional
E) Tumor del sitio de inserción placentaria

Respuesta C. La imagen en tormenta de nieve junto con la beta-hCG muy elevada y el útero mayor a la edad gestacional confirman la mola hidatiforme.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 174

Mujer de 30 años, cursando un embarazo inicial, presenta un aborto espontáneo, manejado con legrado, sin complicaciones. Se controla dos semanas después y la biopsia es informada como mola hidatiforme. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Indicar anticonceptivos orales por 12 meses
B) Controlar con beta-hCG seriada
C) Controlar con ecografía transvaginal en 2 semanas
D) Quimioterapia profiláctica
E) Realizar histerectomía

Respuesta B. El hallazgo de mola en la biopsia obliga al seguimiento hormonal seriado para detectar precozmente una neoplasia trofoblástica, junto con anticoncepción durante todo el seguimiento.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 138

Mujer de 25 años presenta un aborto espontáneo hace 2 meses, que no requirió legrado. Actualmente presenta metrorragia de 7 días, que en la especuloscopía sale por el orificio cervical externo. Su beta-hCG resulta 135.000 unidades por litro. La ecografía transvaginal muestra útero aumentado de tamaño, con contenido uterino irregular y múltiples vesículas. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar metotrexato
B) Esperar evolución espontánea
C) Realizar legrado
D) Realizar resonancia magnética de pelvis
E) Realizar histerectomía

Respuesta E. Una mola que persiste sin tratamiento durante dos meses, con beta-hCG muy elevada y hallazgos molares francos, corresponde ya a una neoplasia trofoblástica establecida, que se trata con histerectomía y quimioterapia posterior.

Pregunta de práctica

Mujer de 22 años, con doce semanas por fecha de última regla, consulta por metrorragia y vómitos intensos. El útero se palpa como de dieciocho semanas. La beta-hCG resulta 190.000 unidades por litro, y la ecografía transvaginal muestra la cavidad ocupada por múltiples quistes pequeños, sin saco gestacional ni embrión. **¿Cuál es el diagnóstico y la conducta inicial más adecuada?**

A) Mola hidatiforme completa; evacuación con aspiración manual endouterina
B) Aborto retenido; misoprostol vaginal
C) Embarazo gemelar; control ecográfico en 4 semanas
D) Mola parcial; quimioterapia profiláctica de inmediato
E) Embarazo ectópico; metotrexato intramuscular

Respuesta A. Útero mucho mayor a la edad gestacional, beta-hCG extremadamente elevada y el patrón ecográfico en tormenta de nieve, sin embrión, son diagnósticos de mola completa. El tratamiento inicial es la evacuación con aspiración manual endouterina, con estudio histopatológico de todo el material.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 155 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente se realiza un legrado por un aborto espontáneo. La biopsia es informada como “mola completa”. Su HCG postlegrado es de 750 UI/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Seguirla con niveles seriados de HCG
B) Realizar biopsia endometrial
C) Indicar anticonceptivos con progestágeno solo
D) Repetir el legrado
E) Indicar metotrexato

Respuesta A. Ante un embarazo molar se debe seguir con HCG, después de sacarla. Si se eleva o mantiene sin bajar, se diagnostica neoplasia trofoblástica gestacional y se procede a la histerectomía más quimioterapia con metotrexato. Una HCG de 750 postlegrado, es bastante baja.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 65 · texto original del banco, sin revisar

Paciente de 34 años, sin antecedentes, consulta por atraso menstrual asociado a metrorragia abundante, náuseas y vómitos. Al examen físico se aprecian mucosas pálidas, útero a nivel suprapúbico y se palpan masas anexiales bilaterales no sensibles. El diagnóstico más probable es:

A) Embarazo normal
B) Aborto en evolución
C) Adenomiosis
D) Embarazo gemelar
E) Embarazo molar

Respuesta E. Diagnóstico: Embarazo molar (opción E). Es una mola completa, con los quistes tecoluteínicos, la metrorragia y los vómitos.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 90 · texto original del banco, sin revisar

Mujer de 40 y tantos con aborto y a la especuloscopía se ve salida de vesículas: a. Enfermedad trofoblastica

A) Ninguna de las anteriores es correcta
B) Todas las anteriores son correctas
C) No se dispone de información suficiente
D) Otra alternativa no descrita
E) Otra alternativa no descrita

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Ninguna de las anteriores es correcta). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Todas las anteriores son correctas, No se dispone de información suficiente) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciale

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 145 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de puérpera de 3 meses, cuyo parto fue por vía vaginal, sin complicaciones. Sin embargo, desde entonces presenta metrorragia intermitente, que ha aumentado. Está dando lactancia materna y no ha tenido otros síntomas. Se solicita ecografía transvaginal, que muestra endometrio de 17 mm de grosor, con algunas imágenes quísticas en su interior. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?

A) Niveles de HCG
B) Resonancia magnética nuclear de pelvis
C) Biopsia de endometrio
D) TAC de pelvis
E) Histeroscopía

Respuesta C. Es una pregunta muy discutible y que no tiene una respuesta clara. Tiene una insuficiencia renal, con hiperkalemia, hiponatremia y acidosis metabólica. De las complicaciones, la hiperkalemia es la más urgente de mejorar, por el riesgo de evolucionar a una pregunta muy discutible y, además, de manejo de especialista. Lo que se pregunta es una NTG, en específico un tumor del sitio de inserción place

3.01.1.009 Macrosomía fetal

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **No requiere**

Dónde se enseña: Tema 19.7 Diabetes Gestacional y Pregestacional: Tamizaje PTGO 75g (24-28 sem), Metas Glucémicas e Insulinoterapia

QUÉ HAY QUE SABER

- Macrosomía: peso fetal estimado o al nacer ≥4.000 g (o >p90 para la edad gestacional, GEG).
- Sospecha: altura uterina mayor a la esperada, diabetes (pregestacional o gestacional mal controlada), obesidad materna, ganancia de peso excesiva, macrosómico previo, postérmino.
- Mecanismo en diabetes: la glucosa cruza la placenta y la insulina no; el hiperinsulinismo fetal deposita grasa en hombros y tronco.
- Riesgos: distocia de hombros, lesión del plexo braquial, desgarros, hemorragia posparto e hipoglicemia neonatal.
- Manejo inicial: confirmar con ecografía (estimación imprecisa ±15%), optimizar control glicémico; considerar cesárea si EPF ≥4.500 g en diabética, ≥5.000 g en no diabética o si hubo distocia de hombros previa.
- Seguimiento: no requiere controles especiales posteriores; vigilar glicemia del recién nacido y reclasificar a la madre si es diabética.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 40

Una paciente de 32 años ingresa en trabajo de parto con 38 semanas de gestación. Al examen obstétrico presenta buena dinámica uterina, feto en presentación cefálica apoyada y dilatación cervical de 3 cm. El peso fetal estimado es de 4.200 g. Tiene antecedente de un parto vaginal previo a las 39 semanas, con retención de hombros y un peso al nacer de 3.900 g. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Conducir el trabajo de parto
B) Iniciar goteo oxitócico
C) Administrar tocolíticos
D) Realizar cesárea en este momento
E) Determinar la vía de parto una vez completada la dilatación

Respuesta D. Feto macrosómico estimado en 4.200 g, 300 g más que el hijo previo que tuvo retención de hombros: el riesgo de una nueva distocia de hombros es alto y lo razonable es la cesárea ahora. Conducir o esperar la dilatación completa expone a esa distocia.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 97 · texto original del banco, sin revisar

Embarazo 38 sem 4300g cesárea previa a las X sem por desproporción cefalo pélvica (guagua pesaba 3900). Conducta:

A) cesarea inmediata
B) programar cesarea 39 semanas
C) esperar inicio tdp
D) Interrupción del embarazo
E) Maduración pulmonar y observación

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: cesarea inmediata (opción A). La resolución quirúrgica urgente constituye la única medida definitiva capaz de controlar el foco séptico, revertir la isquemia o evitar la muerte materna/fetal frente a este compromiso clínico severo.

3.01.1.010 Restricción de crecimiento fetal

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 19.4 Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospecha: altura uterina menor a la esperada (≥3–4 cm bajo lo esperado) o ecografía con peso fetal estimado <p10; confirmar la EG con ecografía precoz.
- Peso p3–p10 con Doppler normal = PEG constitucional (sano, parto a término 39–40 semanas); <p3 o Doppler alterado en cualquier percentil, o caída >2 canales = restricción de crecimiento.
- Causas: insuficiencia placentaria (preeclampsia, HTA, tabaco, trombofilias), genéticas, infecciones (TORCH), embarazo múltiple.
- Precoz (<32 semanas) se asocia a preeclampsia y deterioro Doppler ordenado (umbilical → cerebral → ductus); tardío (≥32) con umbilical normal y cerebral media alterada.
- El examen clave es el Doppler de arteria umbilical; etapas: I → 37 semanas; II (diástole ausente) → 34; III (diástole reversa) → 30; IV (ductus con onda a reversa) → interrupción inmediata.
- Manejo inicial: derivar a alto riesgo; corticoides si <34 semanas (betametasona 12 mg IM c/24 h x2) y sulfato de magnesio neuroprotector si <32. Seguimiento: derivar.

PREGUNTAS (9)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 24

Paciente de 34 años, con embarazo de 35 semanas, con feto creciendo en percentil 2 desde la semana 33, con Doppler fetal normal en ese entonces. Se solicita un nuevo Doppler de control, que no muestra alteraciones. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Inducir el parto
B) Realizar cesárea
C) Solicitar perfil biofísico
D) Controlar semanalmente con Doppler
E) Interrumpir a las 37 semanas

Respuesta B. Un percentil 2 define restricción de crecimiento severa, independiente de que el Doppler siga normal: la severidad por percentil ya obliga a interrumpir a las 34 semanas, y por cesárea.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 168

Paciente cursando un embarazo de 35 semanas, es diagnosticada de restricción de crecimiento fetal en percentil 3. **¿Cuál de las siguientes alteraciones es indicación de interrupción inmediata del embarazo?**

A) Oligohidramnios
B) Aumento de la resistencia de las arterias umbilicales
C) Dilatación de la arteria cerebral media
D) Relación fémur/abdomen mayor a 0,25
E) Ductus venoso con flujo ausente en diástole

Respuesta E. El Doppler del ductus venoso alterado (flujo ausente o, más grave aún, onda a reversa) es el hallazgo más ominoso de la cascada, y su aparición obliga a la interrupción inmediata del embarazo.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 56

Paciente multípara de 40 años, con un embarazo de 32 semanas. La ecografía muestra líquido amniótico normal, con un feto creciendo en percentil 10, con un peso fetal estimado de 1.320 gramos. **¿Cuál es la actitud más adecuada?**

A) Observar evolución
B) Solicitar Doppler de arterias uterinas
C) Solicitar Doppler de arteria umbilical
D) Repetir la ecografía obstétrica en 2 semanas
E) Inducir maduración pulmonar con corticoides

Respuesta C. Ante un feto bajo el percentil 10, el examen de elección para diferenciar un PEG constitucional de una restricción de crecimiento, y para etapificar su gravedad, es el Doppler de arteria umbilical.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 161 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 30 años, cursando un embarazo de 37 semanas, tiene una altura uterina de 28 cm. Se realiza una ecografía obstétrica, que muestra un feto creciendo en percentil 8, con ILA de 8 cm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Inducir el parto con misoprostol
B) Realizar registro basal no estresante
C) Observar evolución
D) Realizar doppler materno fetal
E) Realizar operación cesárea

Respuesta D. Pregunta muy específica. Tiene un RCIU leve (percentil mayor a 5), con líquido amniótico límite, aunque al término, se considera normal hasta ILA de 5. Hoy en día, se pide Doppler umbilical, porque si está normal, se puede incluso llegar a término. Antes se interrumpían todos los RCIU a más tardar a las 37 semanas (hoy solo los moderados-severos o los con doppler alterado).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 149 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 30 años, cursando embarazo de 36 semanas, con feto creciendo en percentil 6 en la semana 35, con Doppler materno fetal normal en ese entonces. Se realiza ecografía de control que muestra feto que no ha crecido, en presentación podálica y Doppler normal. El registro basal no estresante es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar perfil biofísico
B) Administrar corticoides
C) Interrumpir a las 37 semanas
D) Realizar cesárea en este momento
E) Continuar el control semanal con Doppler

Respuesta E. Pregunta difícil. Tiene un RCIU leve (p5 a p9) con Doppler normal, por lo que sería un RCIU tipo I, que se interrumpe a las 37 semanas o incluso a las 40 semanas, si es que se considera un PEG (todo bien y Doppler normal, como en este caso). Para hablar de detención del crecimiento deben pasar al menos 2 semanas, ya que en un tiempo menor está dentro de la variabilidad de la misma ecografía. Por t

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 123 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 35 años, cursando un embarazo de 37 semanas, tiene una estimación de peso fetal en el percentil 5 para la edad gestacional. Se realiza una ecografía obstétrica, que confirma feto con peso en percentil 5 para la edad e índice de líquido amniótico de 6. La conducta más adecuada es:

A) Solicitar registro basal no estresante
B) Inducir el parto
C) Solicitar Doppler maternofetal
D) Realizar amnioinfusión
E) Realizar cesárea

Respuesta C. Tiene un RCIU leve (p5 a p9), con un ILA normal para la edad gestacional (OHA se define como ILA menor a 8 o menor a 5 si es de término; por tanto, no hay OHA en este caso). Sea como sea, todo RCIU siempre debe estudiarse con un doppler maternofetal, ya que si todo está bien, puede ser PEG y se puede esperar a las 40 semanas y nacer por vía vaginal; si está alterado el doppler, se debe interrumpir

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 156 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 34 años, cursando un embarazo de 38 semanas, con antecedente de RCIU en percentil 5. Se realiza una ecografía obstétrica, que muestra feto creciendo en percentil menor a 5 y oligohidroamnios. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Administrar corticoides, manteniendo una conducta expectante
B) Realizar cesárea dentro de las próximas 24 horas
C) Inducir el parto con misoprostol
D) Solicitar doppler umbilical y decidir según resultados
E) Realizar test de tolerancia a las contracciones

Respuesta B. Es un RCIU, con criterios de interrupción (mayor a 37 semanas y además OHA y además detención del crecimiento). Se prefiere la cesárea para evitar el estrés del trabajo de parto.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 29 · texto original del banco, sin revisar

Embarazada de 35 semanas, con altura uterina menor a lo esperado, es derivada a alto riesgo obstétrico donde se realiza ecografía que muestra feto de 1.800 gramos y el doppler umbilical muestra flujo reverso en diástole. La paciente está en buenas condiciones, sin dinámica uterina y su tacto vaginal no presenta cambios cervicales. La conducta más adecuada es:

A) Inducir con misoprostol y conducir trabajo de parto
B) Interrumpir por cesárea
C) Hospitalizar para estudio de la unidad fetoplacentaria
D) Solicitar estudio de líquido amniótico
E) Indicar reposo y control en 48 horas

Respuesta B. Tiene un RCIU mayor a 34 semanas y cuyo Doppler umbilical está alterado, por lo que se debe interrumpir. Por tener el doppler alterado, es decir, insuficiencia placentaria no se lo debe someter al estrés del parto vaginal.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 164 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 25 años, cursando embarazo de 35 semanas, acude a control ginecológico asintomática. Su examen físico es normal. Se realiza ecografía donde se estima peso fetal en percentil 8 para su edad gestacional. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Realizar perfil biofísico
B) Medición del flujo cerebral y umbilical
C) Medición del flujo de arterias uterinas
D) Realizar ecografías seriadas
E) Interrupción del embarazo

Respuesta B. Tiene un RCIU leve, de 35 semanas. Hay que pedir Doppler umbilical y se puede ver además con el de ACM. Pero también se debe pedir un PBF y la eco en 14 días. A grandes rasgos, el Doppler es el examen más importante en el RCIU. Esta pregunta está técnicamente mala, pero para asunto de examen RCIU = doppler umbilical (que se puede complementar con doppler de ACM y de ducto venoso).

3.01.1.011 Síndrome hipertensivo del embarazo

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 19.5 Trastornos Hipertensivos del Embarazo: HTA Crónica, HTA Gestacional y Preeclampsia sin Criterios de Severidad · Tema 19.6 Emergencias Hipertensivas en el Embarazo: Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome HELLP y Sulfato de Magnesio

QUÉ HAY QUE SABER

- HTA en embarazo: PA ≥140/90 en 2 tomas separadas por 4 h. Antes de 20 semanas o persistente posparto = crónica; después de 20 sin proteinuria = gestacional; con proteinuria o daño de órgano = preeclampsia.
- Proteinuria significativa: ≥300 mg/24 h o índice proteinuria/creatininuria ≥0,3. Sin proteinuria, plaquetopenia, alza de transaminasas o creatinina también definen preeclampsia.
- Severidad (basta uno): PA ≥160/110, plaquetas <100.000, transaminasas al doble, creatinina alta, cefalea, escotomas, epigastralgia, edema pulmonar.
- Tratamiento oral: labetalol, metildopa o nifedipino de liberación prolongada; IECA y ARA-II contraindicados (suspender si los usaba).
- Preeclampsia sin severidad: interrupción a las 37 semanas; hipertensión gestacional: 38–39 semanas. Con severidad: sulfato de magnesio e interrupción según estabilidad.

- Prevención: aspirina 150 mg nocturna desde antes de las 16 semanas en alto riesgo (preeclampsia previa, Doppler uterino alterado). Seguimiento: derivar a alto riesgo obstétrico.

PREGUNTAS (11)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 173

Paciente de 25 años cursando su primer embarazo de 37 semanas acude a control. Se observa leve edema de extremidades inferiores, presión arterial de 140/90 mmHg y frecuencia cardíaca fetal de 125 latidos por minuto. Está asintomática. **¿Qué examen es más adecuado para precisar el diagnóstico?**

A) Monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas
B) Ecografía Doppler renal
C) Ecografía obstétrica con Doppler fetal
D) Proteinuria de 24 horas
E) Test de tolerancia a las contracciones

Respuesta D. Con presión igual o mayor a 140/90 mmHg después de la semana 20, lo que decide entre hipertensión gestacional y preeclampsia es la proteinuria. El edema aislado orienta pero no define; la proteinuria de 24 horas sí.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 10

Paciente de 41 años, embarazada de 24 semanas, con presión arterial de 155/100 mmHg. Los exámenes muestran una proteinuria en 24 horas de 280 mg y el examen físico es normal, sin edema ni signos de preeclampsia severa. **¿Cuál es el tratamiento más apropiado?**

A) Iniciar metildopa oral
B) Iniciar hidralazina intravenosa
C) Observación y control en 1 semana
D) Iniciar nifedipino de acción prolongada
E) Sulfato de magnesio intravenoso

Respuesta A. La proteinuria de 280 mg queda bajo el corte de 300 mg, así que todavía no es preeclampsia. Pero la presión ya justifica tratamiento oral, y el fármaco de elección en este contexto es la metildopa.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 155

Paciente de 33 años, con 13 semanas de embarazo, con antecedente de cesárea de urgencia en un embarazo anterior, a las 31 semanas, por una preeclampsia severa. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Indicar aspirina
B) Indicar heparina
C) Indicar L-arginina
D) Indicar ácidos grasos omega 3
E) Indicar dexametasona

Respuesta A. El antecedente de preeclampsia severa previa define alto riesgo para este embarazo. La medida que reduce esa recurrencia es la aspirina en dosis baja, idealmente iniciada antes de las 16 semanas.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 126

Embarazada de 32 semanas con dolor epigástrico y en hipocondrio derecho de 2 días. Plaquetas 80.000/mm³, bilirrubina 2,0 mg/dL, GOT 320 UI/L, GPT 240 UI/L. La ecografía muestra litiasis vesicular. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Pancreatitis aguda
B) Hepatitis viral
C) Colecistitis aguda
D) Colestasia intrahepática
E) Síndrome de HELLP

Respuesta E. Plaquetas bajas, transaminasas elevadas y bilirrubina indirecta alta cumplen los tres criterios de HELLP. La litiasis vesicular es un distractor: en el embarazo es un hallazgo frecuente e incidental.

Pregunta real · EUNACOM 2023 · Pregunta 18

¿Cuál de los siguientes fármacos antihipertensivos se encuentra formalmente CONTRAINDICADO en un paciente con diagnóstico de fenómeno de Raynaud debido al riesgo de desencadenar o agravar crisis de vasoespasmo digital severo?

A) Losartán oral
B) Enalapril oral
C) Amlodipino oral
D) Propranolol oral (Betabloqueador no selectivo)
E) Hidroclorotiazida oral

Respuesta D. Los betabloqueadores (especialmente los no cardioselectivos como el propranolol) están formalmente contraindicados en pacientes con fenómeno de Raynaud. Al bloquear los receptores beta-2 adrenérgicos vasculares, predomina el tono alfa-adrenérgico vasoconstrictor, lo que puede precipitar o agravar severamente las crisis de isquemia digital e incluso gatillar necrosis.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 141 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 32 años con antecedente de síndrome hipertensivo del embarazo, a las 32 semanas no logra cifras tensionales normales a pesar de las medidas no farmacológicas. ¿Cuál de los siguientes fármacos es más adecuado para continuar con el tratamiento?

A) Losartán
B) Enalapril
C) Nifedipino
D) Espironolactona
E) Doxazosina

Respuesta C. Antihipertensivos en el Embarazo: En el embarazo, la mayoría de los antihipertensivos están contraindicados. Los cuatro medicamentos que se pueden usar son alfametildopa, nifedipino (de liberación prolongada o XR), hidralazina y labetalol vía oral (más eficaz, pero su disponibilidad es limitada).

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 50 · texto original del banco, sin revisar

Embarazada sobre 20 semanas con dolor epigástrico, hipertensión, transaminasas elevadas y trombocitopenia. ¿Diagnóstico más probable?

A) Preeclampsia severa sin criterios de HELLP
B) Síndrome de HELLP
C) Colestasia intrahepática del embarazo
D) Hepatitis aguda viral
E) Hígado graso agudo del embarazo

Respuesta B. Diagnóstico: Síndrome de HELLP (opción B). Síndrome de HELLP. El score de Tal es la herramienta clínica utilizada para evaluar la severidad del síndrome bronquial obstructivo (SBO). Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 28 · texto original del banco, sin revisar

paciente embarazada con hemograma patológico, enzimas hepáticas elevadas, litisis vesicular, hta, hipoglicemia, dolor y fiebre

A) sd hellp o higado graso agudo (en discusión)
B) Hepatitis viral
C) Preeclampsia severa
D) Colestasia intrahepática
E) Hígado graso agudo del embarazo

Respuesta A. Embarazada con HELLP + hígado graso agudo del embarazo (HGAE): ambas son emergencias obstétricas con laboratorio similar. En contexto de embarazo con hepatopatía grave, interrupción urgente es la conducta.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 100 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente primigesta, cursando un embarazo de 38 semanas, presenta presiones arteriales cercanas a 150/90 mmHg. Está en buenas condiciones generales, sin exaltación neurológica, ni otros síntomas. Se solicita proteinuria de 24 horas, que resulta 400 mg. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar ecodoppler de arterias umbilicales
B) Realizar operación cesárea
C) Solicitar monitoreo fetal no estresante
D) Inducir el parto
E) Repetir la proteinuria en 2 semanas

Respuesta D. Tiene una preclamsia, que pareciera ser moderada, aunque falta información para estar seguro. De todos modos, por haber llegado al término, se debe interrumpir el embarazo. No hay indicación de cesárea con la información que se entrega. Sin embargo, es una pregunta que induce a error, porque no está de más, evaluar el bienestar fetal antes, ya que en toda paciente con preclamsia debería hacerse un

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 48 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 25 años, primigesta, cursa un embarazo de 29 semanas. Consulta por dolor abdominal de 2 días de evolución, de localización epigástrica, asociada a vómitos y malestar general. En su examen físico presenta FC: 90x', PA: 147/100 mmHg, FR: 12x', abdomen depresible, doloroso en la palpación epigástrica y más intenso en hipocondrio derecho. Sus exámenes muestran creatinina plasmática: 1,2 mg/dl, electrolitos plasmáticos normales, hemoglobina: 10,6 g/dl, plaquetas: 90.000 por mm3, blancos: 12.000 por mm3, LDH: 720 UI/L, PCR: 5,0, bilirrubina: 1,4 mg/dl, SGPT: 248 UI/L y SGOT: 277 UI/L. Su ecografía abdominal muestra cálculos biliares. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síndrome de HELLP
B) Colecistitis aguda
C) Hígado graso agudo del embarazo
D) Colestasia intrahepática del embarazo
E) Colangitis

Respuesta A. Tanto por la presión elevada, como por la anemia, plaquetopenia y elevación de la LDH es un HELLP clásico. Los cálculos biliares solo están como distractor.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 154 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 22 semanas de gestación, con embarazo bien controlado, se realiza un doppler de arterias uterinas, que demuestra aumento de la resistencia. Como antecedente, estuvo hospitalizada en un embarazo anterior por una preclamsia. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar aspirina
B) Iniciar heparina
C) Iniciar L-arginina
D) Mantener el control normal del embarazo
E) Administrar corticoides

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Iniciar aspirina (opción A). Por ser una paciente de alto riesgo, debe recibir profilaxis de PE con aspirina.. Score de Tal: leve 0-5, moderado 6-8, severo 9-12 puntos (máximo 12) De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

3.01.1.012 Amenorrea

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 20.1 Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea

QUÉ HAY QUE SABER

- Amenorrea primaria: sin menarquia a los 15 años (o 13 sin caracteres sexuales secundarios); secundaria: ausencia de regla por 3 meses (6 si era irregular).
- Secundaria, paso a paso: beta-hCG siempre primero (embarazo es lo más frecuente); luego TSH y prolactina; después test de progesterona (sangra = anovulación, ej. SOP).
- Si no sangra: test de estrógeno + progesterona; si no sangra = causa uterina (Asherman tras legrado → histeroscopía); si sangra, FSH: alta = falla ovárica, baja = hipotalámico-hipofisaria.
- Primaria: sin útero → cariotipo (46,XX Rokitansky; 46,XY Morris, mamas sin vello); con útero → FSH (alta: Turner; baja: Kallmann con anosmia). Himen imperforado: dolor cíclico sin sangrado.
- Manejo inicial: hiperprolactinemia → cabergolina; amenorrea hipotalámica (estrés, anorexia, deportistas) → recuperar peso; insuficiencia ovárica prematura (<40 años) → terapia hormonal hasta los 50.

- Banderas rojas: hemianopsia bitemporal (macroprolactinoma, RM urgente), gónada con cromosoma Y (gonadectomía). Seguimiento: derivar a ginecología/endocrinología.

PREGUNTAS (8)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 84

Una paciente de 38 años, multípara de 4, con antecedente de 5 abortos que requirieron legrado, nota disminución progresiva del flujo menstrual, hasta caer en amenorrea desde hace 100 días. Su examen físico no muestra alteraciones y no utiliza métodos anticonceptivos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Síndrome de Asherman
B) Menopausia precoz
C) Hiperprolactinemia
D) Síndrome de ovario poliquístico
E) Hipopituitarismo

Respuesta A. El antecedente de legrados repetidos con disminución progresiva del flujo hasta la amenorrea es el cuadro clásico del síndrome de Asherman: las sinequias uterinas obliteran la cavidad y el endometrio deja de responder.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 18

Una paciente de 17 años consulta por amenorrea de 4 meses de evolución. Su examen físico no muestra alteraciones. Test de embarazo negativo, TSH y prolactina dentro de rangos normales. Se solicita prueba de progesterona, que resulta negativa, y prueba de estrógeno y progesterona, que resulta positiva. Además, LH y FSH están normales, en el límite bajo. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Macroadenoma hipofisiario
B) Falla ovárica primaria
C) Embarazo ectópico
D) Amenorrea hipotalámica
E) Síndrome de ovario poliquístico

Respuesta D. El test de progesterona negativo descarta anovulación con estrógenos presentes; el test combinado positivo confirma que el endometrio y el tracto de salida responden; y con LH y FSH en el límite bajo, el hipogonadismo es hipogonadotrópico, es decir, de causa hipotalámica o hipofisiaria.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 25 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 33 años consulta porque desde hace 95 días que no ha menstruado. Sus reglas previas eran regulares, es sexualmente activa y usa preservativo como método anticonceptivo. Hace dos semanas se realizó un test de embarazo en orina, que resultó negativo. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?

A) Subunidad beta HCG
B) Niveles plasmáticos de FSH
C) Ecografía transvaginal
D) Niveles plasmáticos de prolactina
E) Niveles plasmáticos de TSH

Respuesta A. Estudio de la amenorrea: El estudio de la amenorrea debe comenzar descartando el embarazo. Aunque la paciente se realizó una prueba de embarazo en orina hace dos semanas, es recomendable iniciar el estudio con una nueva prueba de embarazo, antes de continuarla con TSH, prolactina y FSH (en la práctica se pide todo junto).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 115 · texto original del banco, sin revisar

Una mujer de 27 años, nulípara, usuaria de anticonceptivos orales por seis años, consulta por amenorrea de cinco meses de evolución, no asociado a otros síntomas. Su examen físico es normal. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Solicitar niveles de prolactina, tirotropina, hormona folículoestimulante y estrógenos
B) Solicitar prueba de estrógeno y progesterona
C) Indicar anticonceptivos orales combinados
D) Observar evolución por un año
E) Indicar uso de agonistas de las gonadotrofinas y controlar en un mes

Respuesta A. Prolactina, TSH es lo más importante. La FSH y estrógenos se piden después, pero es la opción más correcta. DE todos modos, el test de embarazo debería ser lo primero, luego TSH y PRL y luego la prueba de progesterona.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 89 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 32 años consulta por amenorrea de 5 meses de evolución. Se realiza múltiples exámenes, entre los que destacan HCG: < 5 UL/L, FSH y LH < 5 UI/L, con pruebas tiroides y prolactina dentro de rangos normales. Su prueba de progesterona es negativa y su prueba de estrógeno más progesterona es positiva. Su examen físico no aporta mayor información. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síndrome de ovario poliquístico
B) Falla ovárica primaria
C) Síndrome de Asherman
D) Falla hipotalámica / hipofisiaria
E) Disgenesia gonadal

Respuesta D. PP negativa descarta anovulación (A); PE+P negativa confirma hipogonadismo; FSH y LH muy bajas muestran que es hipogonadotrópico y, por tanto, hipotalámico o hipofisiario. La B sería hipergonadotrópico. La C sería uterino, por lo que sus exámenes hormonales serían todos normales y tanto la PP como la PE+P estarían negativas.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 113 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 18 años consulta por amenorrea primaria. Refiere que inició su vida sexual hace algunos meses, pero presenta dolor durante la penetración. En su examen físico tiene desarrollo mamario y puberal normal, con genitales externos femeninos sin alteraciones. Se realiza especuloscopía y se observa vagina corta y estrecha, sin poder visualizar el cuello uterino. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar cariograma
B) Solicitar ecogra:a pélvica
C) Solicitar resonancia magné2ca nuclear de pelvis
D) Solicitar niveles plasmá2cos de estrógeno, progesterona, FSH y LH
E) Iniciar an2concep2vos orales

Respuesta B. Se debe estudiar con una ecografía pélvica, tanto por tener una amenorrea primaria (cuyo estudio inicia con ecografía), como por la vagina corta (que hace sospechar una agenesia mulleriana, que también se estudia con ecografía, la que muestra ausencia de útero). En caso de que no se identifique el útero, se sigue el estudio con cariograma, para diferenciar la agenesia mulleriana (46XX) de la insen

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 32 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 36 años, multípara de 3, con historia de amenorrea desde hace 4 meses, no asociado a otros síntomas. Refiere haber sido usuaria de anticonceptivos orales hasta hace 6 meses y que se realizó test de embarazo en dos oportunidades con resultado negativo. Se solicitan niveles de hormona tiroestiumlante y prolactina que resultan normales, además prueba de progesterona que es negativa, por este motivo se solicita prueba de estrógeno más progesterona que resulta positiva y niveles de hormona folículo estimulante que resulta en 5 mUI/mL. El diagnóstico más probable es:

A) Falla ovárica primaria
B) Falla del eje hipotálamo hipofisiario
C) Síndrome de ovario poliquístico
D) Malformación uterina
E) Síndrome de cushing

Respuesta B. Tiene un hipogonadismo (PP negativa, con PE+P positiva) hipogonadotrópico (FSH baja), por lo que es un problema hipotalámico (tendría GnRH baja) o hipofisiario (tendría GnRH alta).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 131 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 15 años, con menarquia a los 14 años, consulta por atraso mens- trual de 2 meses. No tiene vida sexual. Su examen físico segmentario no muestra altera- ciones y tiene desarrollo mamario y genital acorde a su edad. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Pedir niveles plasmáticos de TSH y prolactina
B) Solicitar ecografía transvaginal
C) Realizar histerosonografía
D) Iniciar anticonceptivos orales
E) Dar progesterona oral, si el atraso dura un mes más

Respuesta E. Sería una amenorrea secundaria, probablemente por anovulación. Aunque nie- gue vida sexual, lo primero es un test de embarazo. Luego, en adolescentes, se hace la prueba de progesterona, si es que alcanza a hacer amenorrea de 3 meses. Sin embargo, no se debe olvidar que dentro de los 2 primeros años post menarquia es normal tener todo tipo de alteraciones menstruales.

3.01.1.013 Cáncer cervicouterino

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 20.13 Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía

QUÉ HAY QUE SABER

- Causado por VPH de alto riesgo (16 y 18): E6 y E7 inactivan p53 y Rb; progresión lenta desde lesión intraepitelial, por eso el tamizaje es eficaz.
- Sospecha clínica: sinusorragia (sangrado poscoital), metrorragia, leucorrea fétida en agua de lavar carne; al espéculo, lesión exofítica friable o úlcera que sangra al contacto.
- Con lesión visible no se repite el PAP: colposcopía con biopsia dirigida (problema de salud GES: confirmación y tratamiento con plazos garantizados).
- Etapificación FIGO clínica-imagenológica: IA–IIA1 (confinado al cuello) → cirugía radical (Wertheim-Meigs con linfadenectomía); IIB o más (parametrio) → quimiorradioterapia con cisplatino y braquiterapia.
- Manejo inicial: hemorragia aguda por tumor → taponaje vaginal y derivación urgente; no operar sin biopsia previa.
- Prevención: vacuna VPH nonavalente gratuita en 4.º y 5.º básico, PAP cada 3 años entre 25 y 64 años (GES). Seguimiento: derivar a oncología ginecológica.

PREGUNTAS (4)

Pregunta del libro · Tema 20.13

Una paciente de 49 años consulta por sangrado genital postcoital y fetidez vaginal de 3 meses. Al examen ginecológico con espéculo se observa un tumor ulcerado y vegetante de 4 cm en el cuello uterino. Al tacto rectovaginal se palpa que la induración tumoral se extiende y compromete de forma evidente el tercio medial del parametrio izquierdo, sin alcanzar la pared ósea pélvica. La biopsia confirma Carcinoma Epidermoide Invasor de cuello uterino (Estadio IIB de la FIGO). ¿Cuál es el tratamiento de elección indicado?

A) Histerectomía radical con linfadenectomía pélvica bilateral (Operación de Wertheim-Meigs)
B) Conización cervical con márgenes amplios
C) Quimiorradioterapia concomitante (Radioterapia externa + Braquiterapia + Cisplatino semanal)
D) Histerectomía total simple extrafascial
E) Tratamiento exclusivamente sintomático y cuidados paliativos

Respuesta C. A) Incorrecta. La cirugía radical está formalmente CONTRAINDICADA cuando el tumor invade los parametrios (Estadio IIB en adelante), debido a que no permite lograr bordes quirúrgicos libres y aumenta masivamente las fístulas urinarias sin beneficio en sobrevida. B) Incorrecta. La conización es exclusiva de lesiones preinvasoras o microinvasoras IA1. C) Correcta. El límite biológico y quirúrgico consensuado internacionalmente (FIGO, NCCN, MINSAL) para operar el cáncer cervicouterino es la indemnidad de los parametrios. Desde el momento en que existe invasión parametrial demostrada al tacto rectovaginal (Estadio IIB), el tratamiento curativo estándar de elección es la Quimiorradioterapia Concomitante basada en Cisplatino semanal asociado a Radioterapia Externa pélvica y Braquiterapia intracavitaria de alta tasa de dosis. Este esquema alcanza excelentes tasas de control local sin la morbilidad de una cirugía no R0. D) Incorrecta. La histerectomía simple deja tumor parametrial activo. E) Incorrecta. El Estadio IIB es potencialmente curable con quimiorradioterapia definitiva.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 177 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 34 años consulta por genitorragia y sinusorragia, por lo que se realiza una especuloscopía, que muestra una lesión cervical ulcerada, friable. La conducta más adecuada es:

A) Colposcopía y biopsia
B) Conización cervical
C) Seguimiento ecográfico
D) Citología cervical
E) Buscar virus papiloma humano

Respuesta A. Es un probable cáncer de cuello uterino. Se debe biopsiar, idealmente en la colposcopía (aunque también se puede biopsiar directamente). El PAP (citología) ya no sirve

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 33 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 32 años se realizó un PAP hace dos años, que fue informado como “probable NIE 2”, sin embargo no tuvo controles posteriores. Hace un mes comienza con genitorragia escasa e intermitente, asociada a mal olor genital. Se realiza una especuloscopía, que visualiza una lesión de 2 cm de diámetro, en relación al cuello uterino, ulcerada. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Repetir el PAP en este momento
B) Realizar biopsia de cuello uterino
C) Realizar histerectomía radical
D) Realizar un cono cervical
E) Solicitar prueba de detección y tipificación de virus papiloma humano

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Realizar biopsia de cuello uterino (opción B). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 57 · texto original del banco, sin revisar

Mujer con PAP con NIE III hace 3 años, sin controles, ahora con lesión exofítica ulcerada en cuello uterino. ¿Cuál es la conducta?

A) Colposcopía y tratamiento inmediato
B) CONO diagnóstico-terapéutico
C) Biopsia cervical
D) Histerectomía total
E) Repetir PAP y controlar en 3 meses

Respuesta C. Conducta / Tratamiento indicado: Biopsia cervical (opción C). Biopsia cervical. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

3.01.1.014 Dolor pelviano y dismenorrea

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 20.5 Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado

QUÉ HAY QUE SABER

- Dismenorrea primaria: dolor cólico hipogástrico que inicia con la regla, desde 6–12 meses tras la menarquia, examen normal; por prostaglandinas.
- Dismenorrea secundaria: inicio tardío o progresiva, con dispareunia, sangrado anormal o infertilidad; sospechar endometriosis, adenomiosis, miomas, PIP crónico o DIU.
- Dolor pelviano crónico: >6 meses, no cíclico; descartar causas ginecológicas, urológicas (cistitis intersticial), digestivas (colon irritable) y musculoesqueléticas.
- Estudio inicial: examen ginecológico, beta-hCG, ecografía transvaginal; cultivos si hay flujo o sospecha de ITS.
- Tratamiento inicial primaria: AINE desde el inicio del dolor (ibuprofeno 400–600 mg c/8 h, naproxeno 550 mg) y/o anticonceptivos combinados; si no responde, pensar en endometriosis.
- Seguimiento: derivar a ginecología la dismenorrea secundaria, refractaria o con examen alterado (útero fijo, nódulos, masa anexial).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Adolescente de 16 años, menarquia a los 12 años, con ciclos regulares cada 28 días. Desde hace un año presenta dolor hipogástrico tipo cólico que comienza el primer día de la menstruación y dura 48 horas, con náuseas, que la obliga a faltar al colegio. No ha iniciado actividad sexual. No tiene dolor fuera de la menstruación ni dispareunia. Examen abdominal y ecografía pelviana transabdominal normales. **¿Cuál es el tratamiento de primera línea?**

A) Laparoscopía diagnóstica
B) Opioides en los días de dolor
C) Análogos de GnRH
D) Dienogest continuo
E) Antiinflamatorios no esteroidales iniciados al comienzo del dolor o 1 a 2 días antes de la menstruación

Respuesta E. Dolor que coincide con la menstruación, desde poco después de la menarquia, con examen y ecografía normales: dismenorrea primaria, por exceso de prostaglandinas endometriales. La primera línea son los AINE (ibuprofeno, naproxeno, ácido mefenámico); si no responden o necesita anticoncepción, anticonceptivos combinados. La laparoscopía se reserva para la dismenorrea refractaria con sospecha de endometriosis.

3.01.1.015 Endometriosis

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 20.5 Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado

QUÉ HAY QUE SABER

- Tríada: dismenorrea progresiva que no cede con AINE, dispareunia profunda e infertilidad (hasta 50%); también disquecia y disuria catameniales. Típica de mujer joven nulípara.
- Examen: útero en retroversión fija, nódulos dolorosos en el fondo de saco de Douglas y ligamentos uterosacros; teoría de la menstruación retrógrada (Sampson).
- Ecografía transvaginal: endometrioma con contenido homogéneo en vidrio esmerilado, sin papilas ni flujo Doppler; RM para enfermedad profunda; laparoscopía con biopsia es el estándar de oro.
- Sin deseo de embarazo: dienogest 2 mg/día continuo, ACO continuos o DIU-LNG; análogos de GnRH máximo 6 meses; AINE como coadyuvante.
- Busca embarazo: las hormonas no mejoran la fertilidad; derivar para cirugía conservadora o FIV. Cirugía si endometrioma ≥4 cm, dolor refractario o compromiso ureteral/intestinal.
- Diferencial con adenomiosis: multípara de 35–50 años, hipermenorrea, útero grande, blando y globoso. Seguimiento: derivar a ginecología.

PREGUNTAS (5)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 54

Mujer de 38 años con dismenorrea severa, dispareunia profunda y menometrorragia. La ecografía transvaginal muestra un útero aumentado de tamaño con ecotextura heterogénea, sin miomas definidos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Endometriosis
B) Pólipo endometrial
C) Hiperplasia endometrial
D) Mioma uterino intramural
E) Adenomiosis

Respuesta E. El útero aumentado de tamaño de forma difusa, con ecotextura heterogénea y sin miomas definidos, junto con menometrorragia y dismenorrea, es el cuadro clásico de adenomiosis: endometrio ectópico dentro del miometrio.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 10

Mujer de 32 años consulta por dismenorrea de 2 años, progresiva. Al examen ginecológico se palpa un tumor anexial derecho. La ecografía transvaginal muestra un tumor ovárico derecho de 6,5 cm, quístico, en vidrio esmerilado. Su Ca-125 resulta 86 UI/L (normal menor a 35). **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Carcinoma epitelial de ovario
B) Endometrioma ovárico
C) Teratoma maduro
D) Disgerminoma ovárico
E) Quiste folicular

Respuesta B. La imagen en vidrio esmerilado, en una mujer joven con dismenorrea progresiva, corresponde a un endometrioma ovárico. El Ca-125 elevado no descarta esto: también se eleva en procesos peritoneales benignos como la endometriosis, no solo en el cáncer.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 136 · texto original del banco, sin revisar

Paciente femenina 50 años aprox o 38 años (alguien recuerda?), tiene antecedente de esterilización y adenomiosis ¿Cual es el manejo? a. Histerectomía con preservación de ovarios

A) Amoxicilina
B) Ibuprofeno
C) Paracetamol
D) Omeprazol
E) Metformina

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Amoxicilina (opción A). Tratamiento De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad. Las opciones alternativas (Ibuprofeno, Paracetamol) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 53 · texto original del banco, sin revisar

Mujer de 18 años consulta por dismenorrea secundaria, intensa, de 6 meses de evolución que ha aumentado progresivamente, por lo que ha tomado AINEs y paracetamol sin respuesta. Su examen físico y ginecológico son normales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar an2concep2vos orales
B) Solicitar resonancia magné2ca nuclear de pelvis
C) Realizar laparoscopía diagnós2ca
D) Solicitar TAC de pelvis
E) Realizar histeroscopía

Respuesta C. Es una pregunta muy discutible. La clínica orienta fuertemente a una endometriosis (dismenorrea secundaria, progresiva y refractaria), cuyo examen diagnóstico de elección es la laparoscopía (que también es terapéutica) y quien redactó la pregunta probablemente buscaba evaluar la capacidad de reconocer el cuadro clínico de la endometriosis. Sin embargo, aunque no está en las opciones, se recomienda

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 47 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 35 años, usuaria de dispositivo intrauterino, hace 9 años, consulta por un cuadro de dolor pélvico, que aumentó en la última menstruación. Se realiza ecografía transvaginal, que muestra una lesión quística de 6 cm en el ovario derecho, con contenido denso. Se solicitan niveles de Ca-125 que resultan 160 UI/ml (VN: menor a 35). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Quiste folicular
B) Cáncer de ovario inicial
C) Quiste endometriósico
D) Cáncer de ovario avanzado
E) Teratoma ovárico

Respuesta C. Diagnóstico: Quiste endometriósico (opción C). Es un endometrioma clásico, que también puede llamarse quiste endometriósico.. Implantación de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina (peritoneo, ovarios, tabique recto-vaginal). Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

3.01.1.016 Enfermedad preinvasora del cuello uterino-Lesiones genitales intraepiteliales (NIE-HPV)

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 20.13 Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía

QUÉ HAY QUE SABER

- Lesiones intraepiteliales por VPH, asintomáticas; se pesquisan con el PAP (sistema Bethesda) y se confirman con colposcopía y biopsia.
- ASC-US o LIE de bajo grado en ≥30 años: test de VPH; si es 16/18 → colposcopía; si es negativo u otro genotipo, control en 6–12 meses. LIEBG (NIE I) regresa sola en la mayoría en 2 años.
- LIE de alto grado, ASC-H o AGC: colposcopía inmediata (GES: dentro de 30 días); AGC o sospecha de invasión se deriva sin observar.
- Colposcopía: zonas acetoblancas tras ácido acético y áreas yodonegativas en el test de Schiller orientan la biopsia.
- Tratamiento de NIE II–III: conización (LEEP o cono frío), diagnóstica y curativa si los márgenes son libres; no histerectomía de entrada.
- Manejo inicial del médico general: tomar PAP y derivar según resultado a la Unidad de Patología Cervical. Seguimiento: derivar (controles con PAP/VPH poscono).

PREGUNTAS (13)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 91

Una paciente de 35 años, multípara de 1, se realiza PAP de control, que es informado como presencia de atipias escamosas de significado incierto (ASC-US). Su especuloscopía es normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar colposcopía y biopsia cervical
B) Solicitar reacción de cadena de polimerasa para virus papiloma humano
C) Realizar diatermocoagulación cervical
D) Realizar histerectomía
E) Realizar biopsia de endometrio

Respuesta B. Ante un ASC-US, la conducta más aceptada es solicitar la prueba de VPH. Si resulta positiva para un genotipo de alto riesgo, se deriva a colposcopía y biopsia; si es negativa, se puede observar o repetir el PAP en 6 a 12 meses.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 21

Una paciente de 25 años, con antecedente de haber iniciado su vida sexual a los 14 años y mantener relaciones con múltiples parejas sin métodos de barrera, se realiza un PAP que es informado como lesión de alto grado. Además, se realiza tipificación de virus papiloma humano, que muestra serotipo de bajo grado. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Solicitar nuevo PAP en 6 meses
B) Solicitar nuevo PAP en 6 años
C) Realizar colposcopía y eventual biopsia
D) Realizar conización cervical
E) Realizar histerectomía

Respuesta C. El PAP de alto grado siempre se deriva a colposcopía y biopsia, sin importar el resultado de la tipificación de VPH: esa prueba solo cambia la conducta cuando el PAP es de bajo grado.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 159 · texto original del banco, sin revisar

Una mujer tiene un PAP alterado, por lo que se realiza una colposcopía y biopsia, que es informada como lesión de bajo grado/VPH. ¿A qué evolucionará con mayor probabilidad esta lesión?

A) Involución espontánea
B) NIE 2
C) Carcinoma in situ
D) Condiloma acuminado
E) Cáncer de cuello uterino

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Involución espontánea). Las NIE 1 en su mayoría involucionan espontáneamente. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 11 · texto original del banco, sin revisar

PAP lesión de alto riesgo + VPH (+) 16 y 18: conducta

A) Colposcopia y eventual biopsia (esta no es cono)
B) Cono: según Guevara lesión de alto grado + VPH de alto grado es indicación de tratamiento al tiro (noo, LIE o VPH de alto grado son indicaciones por si solas de colpo + bx pero juntas no cambian la conducta, las únicas indicaciones de cono son NIE II, NIE III, Ca in situ y disociación colpocitológica)
C) Amoxicilina
D) Ibuprofeno
E) Paracetamol

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Colposcopia y eventual biopsia (esta no es cono) (opción A). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 76 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 30 años se realiza un PAP, que resulta atípico de alto grado, por lo que se realiza una colposcopía y biopsia, que es informada como NIE-1, de localización exocervical. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Seguimiento con PAP
B) Crioterapia
C) Cono cervical
D) Tipificación de virus papiloma humano
E) Diatermocoagulación

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Diatermocoagulación (opción E). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención. Las opciones alternativas (Seguimiento con PAP, Crioterapia) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 60 · texto original del banco, sin revisar

Mujer de 34 años con PAP que informa células glandulares atípicas (AGC). ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Colposcopía con biopsia dirigida y legrado endocervical
B) Repetir PAP en 6 meses
C) Histerectomía total
D) Conización diagnóstica
E) Cepillado endocervical y repetir PAP en 3 meses

Respuesta A. Células glandulares atípicas (AGC) en PAP tienen mayor riesgo de lesión endocervical o endometrial significativa. Conducta: colposcopía + biopsia + legrado endocervical para descartar adenocarcinoma.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 58 · texto original del banco, sin revisar

Mujer con PAP con NIE III y colposcopía normal con legrado endocervical normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Cono cervical
B) Crioterapia cervical
C) Seguimiento con PAP en 6 meses
D) Histerectomía simple
E) LEEP inmediato

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Cono cervical (opción A). Cono cervical. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 165 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente se realiza un PAP, que es informado como probable lesión de bajo grado y presencia de virus papiloma humano. ¿Cuál es la conducta mas adecuada?

A) Vacunar contra virus papiloma humano
B) Realizar colposcopía y biopsia
C) Repetir el PAP en 6 meses
D) Realizar hibridación para serotipos oncogénicos de virus papiloma
E) Realizar PAP en fase líquida en 1 a 3 meses

Respuesta B. Un PAP alterado, con probable lesión neoplásica, debe ir a colposcopía y biopsia, independiente del grado de las atipías celulares, más aún si hay VPH. La tipificación de VPH es cara, pero se recomienda, en caso de haber recursos (no es el caso de Chile), cuando hay una ASCUS (atipías celulares de significado incierto). La vacunación de VPH ya no sirve (se debe hacer antes de contraer el virus: en

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 112 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 32 años, se realiza citología cervical, que es informada como “presencia de células escamosas atípicas, sugerentes de NIE 3”. Se realiza colposcopía que no muestra lesiones y curetaje endocervical que es informado como “tejido endocervical normal”. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Repetir el curetaje endocervical
B) Controlar con nuevo Papanicolau en un año
C) Realizar histerectomía
D) Realizar conización cervical
E) Realizar legrado y biopsia endometrial

Respuesta D. Conducta / Tratamiento indicado: Realizar conización cervical (opción D). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 173 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente se realiza un PAP que muestra atipías escamosas de bajo grado. Se realiza una colposcopía y biopsia, que muestra presencia de una neoplasia intraepitelial grado 1 y un condiloma. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Crioterapia
B) Tipificación de virus papiloma humano
C) Conización cervical
D) Histerectomía
E) Curetaje endocervical

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Crioterapia (opción A). Tanto NIE 1, como condilomas, se tratan con crioterapia como primera línea.. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 20 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 24 años se realiza un PAP que es informado como probable lesión de bajo grado, por lo que se realiza una colposcopía, que muestra una neoplasia intraepitelial de bajo grado. La conducta más adecuada es:

A) Controlar con PAP y colposcopía cada 6 meses
B) Tratar con diatermocoagulación bipolar
C) Tratar con crioterapia
D) Realizar cono cervical con asa LEEP
E) Realizar tratamiento con láser

Respuesta A. A y C son respuestas aceptables pata el manejo de una NIE 1; también la tipificación, al menos, según la guía Minsal. Sin embargo, lo más importante siempre es el control periódico de la paciente con un PAP alterado y, por eso, lo dejaremos como la respuesta correcta.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 12 · texto original del banco, sin revisar

Disociación colpocitológica (PAP NIE III y colpo normal):

A) Cono
B) Volver a hacer legrado endocervical
C) Repetir en 6 meses
D) Ninguna de las anteriores es correcta
E) Todas las anteriores son correctas

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Cono). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Volver a hacer legrado endocervical, Repetir en 6 meses) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 52 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 24 años se realiza un PAP, que es informado como lesión de bajo grado y probable infección de virus papiloma humano. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar PAP en 1 año
B) Realizar colposcopía y biopsia
C) Repetir el PAP en 6 meses
D) Realizar tipificación de virus papiloma humano
E) Realizar PAP en 3 meses

Respuesta D. Es una pregunta discutible, ya que un PAP de bajo grado se puede controlar en 6 meses y también se puede tipificar el VPH: si es del ato grado (16 o 18), se envía a colposcopía; si es VPH de bajo grado, se observa y controla en 6 meses. Solo por la parte de la pregunta que dice "probable infección de VPH", nos inclinaremos por la opción de tipificarlo.

3.01.1.017 Enfermedades de transmisión sexual

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 20.9 Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Úlceras genitales: sífilis primaria (chancro indoloro, indurado, adenopatía indolora) vs herpes (vesículas y úlceras múltiples dolorosas); confirmar con VDRL/RPR + treponémica o PCR.
- Sífilis primaria, secundaria o latente precoz: penicilina benzatina 2,4 millones UI IM dosis única (latente tardía: semanal x3); alérgicas no embarazadas: doxiciclina 100 mg c/12 h x14 días. Embarazada alérgica:

desensibilizar.

- Uretritis/cervicitis (secreción purulenta, cuello friable): tratamiento dual empírico de gonococo + Chlamydia: ceftriaxona 500 mg IM dosis única + doxiciclina 100 mg c/12 h x7 días (azitromicina 1 g en embarazo).
- Tricomoniasis (flujo espumoso verdoso, cuello en fresa): metronidazol 2 g VO dosis única o 500 mg c/12 h x7 días; tratar siempre a la pareja. Herpes: aciclovir 400 mg c/8 h x7–10 días.
- Condilomas acuminados (VPH 6 y 11): podofilotoxina, imiquimod o crioterapia; prevención con vacuna VPH.
- Seguimiento completo: tratar a parejas, ofrecer VIH, VDRL, hepatitis B y C; control con VDRL cuantitativo (caída de 2 diluciones a los 6–12 meses); notificación obligatoria de sífilis y gonorrea.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 69

Una paciente de 25 años, embarazada, con 12 semanas contadas desde una FUR segura y confiable, se realiza exámenes, entre los que trae un VDRL que resulta no reactivo y un MHA-TP que resulta reactivo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Administrar penicilina benzatina de inmediato
B) Realizar VDRL mensual durante el resto del embarazo
C) Controlar con VDRL a las 30 semanas
D) Solicitar un FTA-ABS
E) Indicar doxiciclina vía oral

Respuesta C. Las pruebas no treponémicas (VDRL, RPR) se negativizan tras un tratamiento exitoso; las treponémicas (MHA-TP, FTA-ABS) quedan positivas de por vida. VDRL no reactivo con MHA-TP reactivo corresponde a una sífilis tratada en el pasado: se sigue el control prenatal habitual, con VDRL a las 28 a 30 semanas.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 68 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 31 años multípara de uno, cursando un embarazo de 34 semanas, sin patología previa, acude a control, objetivándose lesiones vaginales, que se muestran a continuación: ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar cesárea electiva
B) Aplicación local de podofilino
C) Iniciar aciclovir oral
D) Realizar tocaciones con ácido tricloroacético
E) Inducir el parto en este momento

Respuesta D. Condilomas acuminados genitales en embarazo: La imagen muestra condilomas acuminados, causados por el virus del papiloma humano (VPH), serotipos 6 y 11. A diferencia del herpes genital, los condilomas acuminados no contraindican el parto vaginal. El tratamiento de elección durante el embarazo es el ácido tricloroacético tópico. Otros tratamientos tópicos como el imiquimod y el podofilino, aunque e

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 46 · texto original del banco, sin revisar

Paciente de 29 años, cursando embarazo de 38 semanas, consulta por aparición de vesículas dolorosas a nivel vulvar, sin otros síntomas. Al examen físico se apreian vesículas con base eritematosa a nivel vulvar. El examen de elección para el diagnóstico etiológio en este caso es:

A) Cultivo viral
B) PCR para virus herpes
C) Biopsia
D) Inmunoglobulina G para virus herpes
E) Tinción para virus herpes

Respuesta B. Pregunta mala. El diagnóstico es clínico y en la vida real no hay que pedir ningún examen y hacer cesárea. El gold standard siempre ha sido el cultivo viral, pero la PCR lo ha desplazado, por ser más rápida y más sensible. Yo marcaría PCR, pero el problema es que demora y hay que actuar de inmediato, por ser un embarazo y para decidir la vía de parto, lo único inmediato es la tinción de Tzank, aun

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 79 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente, con antecedente de varias parejas sexuales, consulta por disuria inicial y leucorrea. En la especuloscopía se observa cuello uterino con cambios inflamatorios y abundante leucorrea amarillenta, sin otras alteraciones en el examen ginecológico. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Vaginosis bacteriana
B) Proceso inflamatorio pélvico
C) Candidiasis urogenital
D) Tricomoniasis
E) Cervicitis gonocócica

Respuesta E. Diagnóstico: Cervicitis gonocócica (opción E). Es una cervicitis aguda clásica, cuyas causas más frecuentes son la gonorrea y la clamidia.. Esta clase aborda las generalidades de las ETS y cubre uretritis, herpes genital y condiloma acuminado. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

3.01.1.018 Hemorragia genital anormal

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **No requiere**

Dónde se enseña: Tema 20.3 Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo

QUÉ HAY QUE SABER

- Sangrado uterino anormal: descartar primero embarazo (beta-hCG) y clasificar con PALM-COEIN (pólipo, adenomiosis, leiomioma, malignidad; coagulopatía, ovulatoria, endometrial, iatrogénica, no clasificada).
- Pólipo: sangrado intermenstrual; mioma submucoso: hipermenorrea; disfunción ovulatoria (SOP, extremos de la vida) es la causa no estructural más frecuente; en la adolescente con hipermenorrea, pensar en von Willebrand.
- Biopsia endometrial obligatoria (Pipelle) en ≥45 años con cualquier sangrado anormal, en toda metrorragia postmenopáusica con endometrio ≥4–5 mm, y en <45 con factores de riesgo (obesidad, SOP, tamoxifeno, Lynch).
- Estudio inicial: hemograma, TSH, prolactina si corresponde, ecografía transvaginal; perfil de coagulación si es adolescente con sangrado abundante.
- Tratamiento médico: DIU con levonorgestrel (el más eficaz), ácido tranexámico (no hormonal), AINE, anticonceptivos combinados o progestágenos; corregir anemia con hierro.
- Seguimiento: no requiere controles especializados si responde; derivar si hay causa estructural, sospecha de malignidad o falla del tratamiento.

PREGUNTAS (7)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 5

Una paciente de 48 años consulta por sangrado uterino, que no ha cesado desde su última menstruación, que inició hace dos semanas. Se solicita una ecografía transvaginal que muestra útero de tamaño normal, con endometrio de 19 mm de grosor y sin alteraciones anexiales. Su PAP, realizado hace poco, es normal, y su test de embarazo en orina es negativo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Histerectomía
B) Ácido tranexámico endovenoso
C) Estrógenos inyectables
D) Anticonceptivos orales combinados
E) Biopsia de endometrio

Respuesta E. Mujer de 48 años con endometrio muy engrosado en la ecografía: la biopsia endometrial es obligatoria antes de definir cualquier tratamiento hormonal, tanto por la edad como por el hallazgo ecográfico.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 46

Una paciente de 55 años, con menopausia a los 51 años y usuaria de estrógenos transdérmicos como terapia de reemplazo hormonal, consulta por sangrado genital de 5 días de evolución. Al examen físico, sus signos vitales son normales y la especuloscopía no muestra sangrado activo ni lesiones del cuello uterino. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar histerectomía
B) Aumentar la dosis de estrógenos
C) Iniciar anticonceptivos orales
D) Solicitar biopsia de endometrio
E) Indicar ácido tranexámico vía oral

Respuesta D. Toda metrorragia en la postmenopausia se estudia. En usuarias de terapia de reemplazo hormonal el umbral ecográfico para biopsiar es más alto que en quien no la usa, pero cualquier sangrado igualmente obliga a descartar patología endometrial con biopsia.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 85

Una paciente de 15 años consulta por hipermenorrea y menometrorragia. Se solicita una ecografía transvaginal, que no muestra lesiones ni alteraciones uterinas ni ováricas. El endometrio tiene 5 mm de grosor. Su hemograma muestra anemia leve, con glóbulos blancos y plaquetas normales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar biopsia de endometrio
B) Solicitar estudio de alteraciones de la hemostasia
C) Solicitar estudio de trombofilias
D) Solicitar resonancia magnética nuclear abdominopélvica
E) Solicitar endosonografía uterina

Respuesta B. En una adolescente con hipermenorrea y ecografía sin causa anatómica, el paso siguiente es estudiar la hemostasia, buscando enfermedad de von Willebrand u otra coagulopatía. La biopsia de endometrio no tiene indicación a esta edad con endometrio delgado.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 53 · texto original del banco, sin revisar

Mujer de 22 años con ACO, metrorragia persistente 2 semanas y dolor hipogástrico hace 3 días, endometrio 15 mm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar β-HCG
B) Ecografía transvaginal urgente
C) Legrado uterino diagnóstico
D) Suspender ACO y observar
E) Solicitar hemograma y coagulación

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Solicitar β-HCG (opción A). Solicitar β-HCG. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 117 · texto original del banco, sin revisar

Mujer 43 años con sangrado intermenstrual sin dolor, activa sexualmente con preservativo, cómo continuar el estudio:

A) BHCG y eco TV (este es el estudio inicial de todo SUA)
B) TSH y T4
C) FSH y LH
D) Biopsia Yo puse biopsia QUE PUSIERON?, no convencía BHCG. Sg yo la beta era solo porque estaba en edad fertil pero igual hay que hacerle una eco si o si.
E) Hemograma y VHS

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (BHCG y eco TV (este es el estudio inicial de todo SUA)). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 82 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 31 años, usuaria de DIU desde hace 8 meses, consulta por un cuadro de 6 meses de evolución de flujo menstrual muy abundante, asociado a escaso dolor abdominal. Se solicita hemograma, que muestra anemia con hemoglobina: 8,9 g/dl, VCM: 70 fl, HCM: 24 pg. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Iniciar anticonceptivos orales
B) Realizar biopsia de endometrio
C) Iniciar ácido tranexámico
D) Retirar el DIU
E) Realizar ecografía transvaginal

Respuesta D. El DIU es causa de aumento del flujo menstrual y de dismenorrea. Se debe retirar y s epuede cambiar por un DIU medicado.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 180 · texto original del banco, sin revisar

Mujer de 51 años consulta por metrorragia moderada de 10 días de evolución. Su última menstruación fue hace 6 meses. ¿Cuál es la causa mas probable de su hemorragia?

A) Atrofia vaginal
B) Hiperplasia endometrial
C) Cáncer de endometrio
D) Cáncer cervicouterino
E) Metrorragia disfuncional FIN DEL EXAMEN La

Respuesta E. Por estar en el climaterio, es muy probable que sea disfuncional (es la causa más frecuente de metrorragia premenopausia). No aparecía atrofia endometrial como opción, sino atrofia vaginal, que está descartada.

3.01.1.019 Infecciones genitourinarias

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 20.9 Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis · Tema 19.9 Infección del Tracto Urinario en el Embarazo: Bacteriuria Asintomática, Cistitis y Pielonefritis Aguda

QUÉ HAY QUE SABER

- Vaginosis bacteriana: flujo gris homogéneo con olor a pescado, sin inflamación; criterios de Amsel (3 de 4): flujo, pH >4,5, aminas (+), clue cells >20%. Metronidazol 500 mg c/12 h x7 días; no tratar a la pareja.
- Candidiasis: prurito intenso, flujo en leche cortada, pH normal (<4,5); fluconazol 150 mg VO dosis única; en embarazada clotrimazol vaginal x7 días (nunca fluconazol oral).
- Tricomoniasis: flujo espumoso verde-amarillento, cuello en fresa, pH alto; metronidazol 2 g dosis única y tratar a la pareja (es ITS).
- Bacteriuria asintomática (>100.000 UFC de un germen) y cistitis en la embarazada: tratar siempre, cefadroxilo 500 mg c/12 h x7 días (nitrofurantoína alternativa, evitar a término) y urocultivo de control 7–14 días después.
- Pielonefritis en el embarazo (fiebre >38,5, puñopercusión +): hospitalizar siempre, ceftriaxona o cefazolina EV hasta 48 h afebril, completar 14 días VO y profilaxis nocturna hasta el parto.
- Cistitis no complicada en no embarazada: nitrofurantoína 100 mg c/8–12 h x5 días o fosfomicina 3 g dosis única. Seguimiento completo: urocultivo de control y manejo de recurrencias.

PREGUNTAS (11)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 121

Mujer de 28 años con dispareunia y flujo vaginal gris homogéneo con mal olor, que empeora tras el coito. El pH vaginal es de 5,5 y el test de aminas con KOH resulta positivo. **¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento más adecuado?**

A) Vaginosis bacteriana: metronidazol oral 500 mg cada 12 horas por 7 días
B) Candidiasis vaginal: fluconazol oral 150 mg dosis única
C) Tricomoniasis: metronidazol 2 g dosis única
D) Herpes genital: aciclovir
E) Cervicitis por Chlamydia: azitromicina

Respuesta A. Flujo gris homogéneo, pH sobre 4,5 y test de aminas positivo: vaginosis bacteriana. Se trata con metronidazol oral 500 mg cada 12 horas por 7 días.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 178

Mujer de 26 años, sin antecedentes, consulta por secreción vaginal asociada a prurito. Al examen se aprecia liquenificación y signos de grataje vulvar, y a la especuloscopía, leucorrea blanquecina. **¿Cuál es el fármaco de elección para el manejo de este caso?**

A) Metronidazol
B) Fluconazol
C) Miconazol
D) Doxiciclina
E) Ceftriaxona

Respuesta B. Prurito intenso con signos de rascado y leucorrea blanquecina: candidiasis genital. El fármaco de elección es fluconazol 150 mg oral en dosis única.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 117

Mujer de 30 años consulta por leucorrea y prurito. Al examen ginecológico destaca especuloscopía con leucorrea abundante, amarilla y espumosa. **¿Cuál es el examen de elección para el diagnóstico etiológico?**

A) Prueba de aminas vaginales (test de KOH)
B) Cultivo para Cándida albicans
C) Examen de determinación de células clave (clue cells)
D) Frotis fresco de la secreción vaginal
E) PCR para Chlamydia trachomatis

Respuesta D. Flujo amarillo y espumoso: cuadro clásico de tricomoniasis. El diagnóstico se confirma con el frotis fresco, donde se ve el protozoo flagelado móvil.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 147

Mujer de 23 años, cursando un embarazo de 20 semanas, sin complicaciones, se realiza un urocultivo, que resulta positivo para Escherichia coli multisensible, 60.000 UFC por mililitro. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Repetir el urocultivo en 2 semanas
B) Iniciar cefradina vía oral
C) Iniciar ciprofloxacino vía oral
D) Solicitar ecografía
E) Iniciar ceftriaxona endovenosa

Respuesta A. El corte para bacteriuria asintomática es cien mil colonias por mililitro; con sesenta mil, el urocultivo no la confirma. La conducta es repetirlo, no tratar todavía.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 137

Paciente de 23 años, cursando un embarazo de 7 semanas, presenta un cuadro de disuria y polaquiuria, por lo que se realiza un urocultivo, que resulta positivo para Escherichia coli sensible, con más de 100.000 UFC. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A) Cotrimoxazol
B) Flucloxacilina
C) Nitrofurantoína
D) Levofloxacino
E) Ciprofloxacino

Respuesta C. Cistitis en el primer trimestre: la nitrofurantoína es segura y de elección aquí; se evita solo entre las semanas 36 y 40. El cotrimoxazol se evita cerca del término, y las fluoroquinolonas están contraindicadas en todo el embarazo.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 32 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 31 años de edad refiere mal olor genital, asociado a flujo, que empeora cuando tiene relaciones sexuales. Es usuaria de dispositivo intrauterino de cobre, desde hace 4 años. No tiene PAP vigente, por lo que se solicita un nuevo PAP, que resulta normal. En la especuloscopía se observa leucorrea de color gris, sin lesiones cervicales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Retirar el DIU bajo cobertura antibiótica
B) Solicitar cultivo de secreción vaginal
C) Indicar clindamicina tópica en óvulos
D) Indicar clotrimazol tópico en óvulos
E) Indicar fluconazol oral

Respuesta C. Vaginosis Bacteriana: El diagnóstico probable es vaginosis bacteriana, que se trata con metronidazol oral, siendo una alternativa la clindamicina tópica. No se debe confundir con la enfermedad inflamatoria pélvica que se presenta con dolor, flujo purulento y fiebre. El tratamiento para esta última condición consiste en antibióticos (orales o intravenosos según la gravedad) y la extracción del DIU

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 116 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 27 años, usuaria de dispositivo intrauterino (DIU) de cobre, consulta por flujo genital de mal olor que empeora después de tener relaciones sexuales. Al examen físico se observa cuello uterino normal y secreción vaginal de color gris. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Retirar el dispositivo intrauterino bajo cobertura antibiótica
B) Indicar fluconazol vía oral
C) Iniciar doxiciclina vía oral
D) Realizar VDRL a la paciente y a su pareja.
E) Indicar metronidazol por vía oral

Respuesta E. Vaginosis Bacteriana y DIU: La paciente presenta un cuadro clínico compatible con vaginosis bacteriana, la cual se trata con metronidazol vía oral o clindamicina tópica. A diferencia del proceso inflamatorio pélvico que no responde al tratamiento antibiótico después de 48 horas, en la vaginosis bacteriana no es necesario retirar el DIU.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 34 · texto original del banco, sin revisar

Embarazada de 20 semanas con urocultivo positivo para E. coli sensible. Sin alergias. ¿Cuál es el antibiótico de elección para la infección urinaria en el embarazo?

A) Cefalexina oral por 7 días
B) Amoxicilina oral
C) Cotrimoxazol (contraindicado en tercer trimestre)
D) Ciprofloxacino (contraindicado en embarazo)
E) Nitrofurantoína (evitar en tercer trimestre)

Respuesta A. ITU en embarazo: cefalexina oral 500 mg c/6-8h por 7 días es de primera línea en Chile. Ciprofloxacino: contraindicado (artropatía fetal). Cotrimoxazol: contraindicado en tercer trimestre (kernicterus). Nitrofurantoína: evitar en tercer trimestre. Cefalexina: segura en todos los trimestres.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 136 · texto original del banco, sin revisar

Pregunta 136 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Una paciente cursando un embarazo de 7 semanas de evolución, presenta prurito vaginal desde hace 7 días, con leucorrea de aspecto grumoso. Se realiza un cultivo vaginal, que muestra desarrollo de Streptococcus betahemolítico grupo B y Candida albicans. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Clotrimazol tópico
B) Ampicilina oral
C) Azitromicina oral
D) Fluconazol oral
E) Clindamicina tópica

Respuesta A. Es una candidiasis y por estar embarazada, se prefiere el tratamiento tópico. De lo contrario, también habría sido correcto el fluconazol.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 176 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 33 años, con antecedente de molestias urinarias, caracterizadas por disuria dolorosa, por lo que es diagnosticada de infección urinaria y tratada con ciprofloxacino oral, con buena respuesta clínica. Sin embargo, algunos días después reaparece el ardor al orinar y presenta prurito genital. Al examen físico se aprecia eritema de la mucosa vulvar, sin leucorrea y se observan erosiones lineales a nivel de la horquilla. El tratamiento más adecuado es:

A) Cotrimoxazol
B) Fluconazol
C) Metronidazol
D) Doxicilina
E) Aciclovir

Respuesta B. Es una infección por Candida albicans, secundaria al uso de antibióticos, por tanto, se trata co fluconazol. Orientan a ello el prurito vaginal, la disuria y el compromiso de la horquilla. Eso sí, la ausencia de leucorrea inducía a la confusión, ya que habitualmente se pregunta con la infección más interna, con la leucorrea blanca grumosa clásica.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 176 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente cursa un embarazo de 24 semanas y es diagnosticada de infección urinaria baja, por Escherichia coli sensible, que se resuelve adecuadamente, luego de tratamiento antibiótico por 7 días. Tiene antecedente de una bacteriuria asintomática, tratada a las 16 semanas de embarazo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar urocultivo semanal
B) Solicitar pielografía de eliminación
C) Indicar aumento del consumo de agua
D) Indicar nitrofurantoína a permanencia
E) Indicar profilaxis, con jugo de cranberry

Respuesta D. La indicación de profilaxis antibiótica (con cefradina o nitrofurantoína) son 2 o más infecciones tratadas (independiente de si son bacteriurias asintomáticas, ITU baja, pielonefritis o mezclas de ellos).

3.01.1.020 Infertilidad conyugal

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 20.7 Infertilidad Conyugal: Estudio Básico Inicial en Cuatro Pilares y Técnicas de Reproducción Asistida

QUÉ HAY QUE SABER

- Infertilidad: no lograr embarazo tras 12 meses de relaciones sin protección (6 meses si la mujer tiene ≥35 años); estudiar siempre a la pareja.
- Causas: factor masculino ~1/3, ovulatorio (SOP el más frecuente), tuboperitoneal (PIP, endometriosis), uterino y sin causa aparente.
- Estudio básico de 4 pilares: espermiograma primero (abstinencia 3–5 días, repetir a las 4–12 semanas si alterado); ovulación (progesterona día 21) y reserva (AMH, FSH día 3).
- Trompas: histerosalpingografía (prueba de Cotte positiva = permeable); útero: ecografía transvaginal e histeroscopía si hay defectos.
- Técnicas: inseminación intrauterina si hay al menos una trompa permeable y semen suficiente; FIV/ICSI en obstrucción bilateral, factor masculino severo, edad >38 o baja reserva.
- Manejo inicial: ácido fólico, suspender tabaco, normalizar peso y tratar causas simples (hipotiroidismo, hiperprolactinemia). Seguimiento: derivar a especialista en reproducción.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 108

Una paciente de 28 años acude a la clínica de fertilidad. Presenta reglas irregulares, que ocurren cada 2 a 3 meses. Al examen físico se observa obesa y tiene hirsutismo y acné, sin alteraciones en el examen ginecológico. Se solicita prueba de HOMA, que resulta normal, y una ecografía transvaginal que muestra útero normal, con ovarios poliquísticos. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado para lograr la fertilidad en esta paciente?**

A) Espironolactona
B) Análogos de la GnRH
C) Citrato de clomifeno
D) Metformina
E) Progesterona

Respuesta C. Infertilidad por anovulación en el contexto de ovario poliquístico: se induce la ovulación. La metformina se reserva para pacientes con resistencia a la insulina comprobada, que aquí no está presente, ya que el HOMA es normal.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 149 · texto original del banco, sin revisar

Una pareja joven consulta por infertilidad, refieren que llevan 15 meses intentando tener hijos pero no han tenido resultado, ambos no tienen hijos anteriormente. El hombre trae consigo espermiograma que se realizó hace dos semanas que está normal. Ella nunca ha utilizado anticonceptivos orales y refiere ciclos menstruales normales, su examen físico resulta normal. El examen de elección para continuar el estudio de infertilidad en este caso es:

A) Repetir espermiograma
B) Test post coital
C) Laparoscopía
D) Histeroscopía
E) Histerosalpingografía

Respuesta B. De elección es el seguimiento folicular, que no está dentro de las alternativas. El test postcoital requiere de un seguimiento folicular y se le pide que tengan relaciones el día previo a la ovulación (se sabe ese día por el Seguimiento folicular ecográfico), de modo de evaluar el factro cervical además. Los demás exámenes son de segunda o tercera línea

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 109 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 30 años, con un hijo de 5 años con otra pareja, consulta por infertilidad de 3 años con su nueva pareja. Ella cuenta con estudio hormonal normal y él tiene un espermiograma sin alteraciones. La conducta más adecuada es:

A) Realizar cariograma
B) Repetir el espermiograma
C) Solicitar fragmentación de ADN espermático
D) Realizar laparoscopía diagnóstica
E) Realizar histerosalpingografía

Respuesta E. El estudio de la infertilidad siempre es de la pareja y no importa si tienen hijos de antes. El hombre solo se estudia con espermiograma. La mujer se estudia con exámenes por etapas: la primera línea es el seguimiento folicular con ecografías seriadas y exámenes hormonales; de segunda línea se pide la histerosalpingografía (busca alteraciones tubepritoneales); de tercera línea se hace la laparosco

3.01.1.021 Mioma uterino

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 20.4 Patología Benigna Uterina: Miomatosis Uterina (FIGO 0-8) y Adenomiosis

QUÉ HAY QUE SABER

- Tumor benigno de músculo liso más frecuente del aparato genital; más de la mitad son asintomáticos (hallazgo ecográfico).
- Clasificación FIGO por ubicación: submucoso (el que más sangra y causa infertilidad), intramural y subseroso (da síntomas compresivos: polaquiuria, constipación, dolor pélvico).
- Confirmación: ecografía transvaginal (nódulo hipoecogénico bien delimitado); histerosonografía o histeroscopía para submucosos. Si hay sangrado postmenopáusico con endometrio grueso, biopsiar: no atribuirlo al mioma.
- Manejo inicial: asintomático → observación con control ecográfico; sangrado → ácido tranexámico, AINE, DIU-LNG y hierro; análogos de GnRH solo como puente prequirúrgico.
- Quirúrgico: miomectomía si desea fertilidad (histeroscópica en submucoso); histerectomía con paridad cumplida o anemia refractaria.
- Embarazo: degeneración roja (dolor agudo, fiebre baja, leucocitosis) se maneja con reposo, hidratación y analgesia, no se opera. Crecimiento rápido en postmenopausia: sospechar sarcoma. Seguimiento: control ecográfico periódico y clínico.

PREGUNTAS (8)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 51

Una paciente de 35 años, nulípara, consulta por una historia de un año de flujo menstrual abundante y, en ocasiones, flujo intermenstrual escaso. Usa preservativo como método anticonceptivo. Trae hemograma con hemoglobina de 10,5 mg/dL, hematocrito de 31 %. Se realiza ecografía transvaginal, que demuestra presencia de un mioma submucoso de 2 cm de diámetro. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Histerectomía total
B) Resonancia magnética nuclear de pelvis
C) Observar evolución
D) Miomectomía histeroscópica
E) Resección del mioma por laparoscopía

Respuesta D. Mioma submucoso sintomático, con anemia asociada, en mujer nulípara: el tratamiento de elección es la miomectomía histeroscópica, que resuelve el sangrado conservando el útero y la fertilidad.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 151

Una paciente de 43 años, multípara de 4, consulta porque se ha sentido más cansada de lo normal, con disnea de grandes esfuerzos. Sus reglas son abundantes. Hemoglobina de 8 g/dL, hematocrito de 23 %, con hipocromía y microcitosis. Ecografía transvaginal: múltiples miomas intramurales de hasta 5 cm, más un mioma submucoso de 4 cm. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar histeroscopía
B) Realizar histerectomía total
C) Administrar análogos de la GnRH
D) Iniciar anticonceptivos orales
E) Antifibrinolíticos

Respuesta B. Miomatosis sintomática con anemia severa en una mujer con paridad cumplida (multípara de 4): el tratamiento curativo definitivo es la histerectomía total.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 43

Una paciente de 56 años, usuaria de terapia de reemplazo hormonal y sin síntomas ginecológicos, se realiza una ecografía abdominal durante el estudio de un cuadro de constipación crónica. En dicho examen se detecta un mioma uterino subseroso de 32 por 35 mm. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar laparoscopía
B) Suspender la terapia de reemplazo hormonal
C) Iniciar anticonceptivos orales
D) Realizar histerectomía
E) Realizar control ecográfico en 6 meses

Respuesta E. Mioma asintomático, hallazgo incidental en una ecografía pedida por otro motivo: la conducta es la observación con control ecográfico, sin importar su clasificación FIGO.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 63 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 30 años, nulípara, consulta por presentar reglas abundantes, asociado a astenia e hipersomnia. Al examen físico destacan mucosas pálidas, sin otros hallazgos. Se realiza hemograma donde destaca hemoglobina que resulta en 8mg/dL, y además se realiza ecografía transvaginal que muestra presencia de dos miomas intramurales. El tratamiento de elección en este caso es:

A) Anticonceptivos orales
B) Agonistas de las gonadotrofinas
C) Histerectomía
D) Miomectomía
E) Observación

Respuesta D. Miomas sintomáticos en mujer sin hijos: miomectomía. Cierto es que los miomas intramurales suelen ser asintomáticos, pero en este caso se debe simplificar la pregunta a ¿cuál es el tratamiento de los miomas con hipermenorrea?

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 162 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 53 años acude a control ginecológico. Tuvo su menopausia a los 51 años y está en terapia de reemplazo hormonal, con estrógeno y progestágeno por vía oral, como tratamiento de los síntomas vasomotores del climaterio. Su examen ginecológico es normal, al igual que su mamografía y PAP. Además, se solicita una ecografía transvaginal, cuya imagen se presenta a continuación: ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar biopsia endometrial
B) Controlar con ecogra:a en 6 meses
C) Suspender la terapia de reemplazo hormonal
D) Realizar resección de la lesión por laparoscopía
E) Instalar disposi2vo intrauterino medicado con levonorgestrel

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Controlar con ecogra:a en 6 meses (opción B). Tiene un mioma asintomático, por lo que se debe observar evolución. Fuente imagen: hxps://we.riseup.net/assets/230674/.... Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 154 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 50 años consulta por amenorrea de 8 meses de evolución. Se realiza ecografía transvaginal que muestra múltiples imágenes nodulares, hipoecogénicas intramurales y subserosas de hasta 3 cm. La indicación más adecuada es:

A) Histerectomía
B) Ecografía en 6 meses
C) Terapia de reemplazo hormonal
D) Análogos de la GnRH
E) Biopsia por histeroscopía

Respuesta B. Tiene miomas asintomáticos (la amenorrea no es síntoma de miomas), por lo que se observan. Además, por estar en amenorrea a los 50 años, probablemente esté menopáusica y, con ello, los miomas tienden a involucionar (aunque da igual en realidad).

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 79 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 35 años, multípara de dos, se realiza una cesárea por presentación podálica. Luego de la extracción del recién nacido y del legrado uterino, se observan múltiples miomas uterinos subserosos de variados tamaños. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar miomectomía múltiple
B) Realizar histerectomía subtotal
C) Realizar miomectomía selectiva de los tumores mayores a 5 cm
D) Realizar histerectomía obstétrica
E) Realizar el cierre habitual de la cesárea

Respuesta E. Los miomas asintomáticos (en este caso simple hallazgo en la cesárea) no requieren tratamiento alguno.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 166 · texto original del banco, sin revisar

Una mujer de 53 años, con antecedente de reglas irregulares, está en amenorrea desde hace 9 meses. Su examen ginecológico es normal y cuenta con mamografía y Papanicolau recientes, sin alteraciones. Se realiza una ecografía transvaginal que muestra endometrio fino y miometrio con múltiples nódulos hipoecogénicos subserosos y transmurales de entre 2 y 4 cm de diámetro. La indicación más adecuada es:

A) Histerectomía total
B) Tumorectomía
C) Análogos de GnRH
D) Anticonceptivos orales
E) Observar evolución

Respuesta E. Tiene un climaterio y probable menopausia (cuando cumpla 12 meses de amenorrea se hará el diagnóstico de menopausia). La presencia de miomas asintomáticos es un hallazgo ecográfico sin importancia.

3.01.1.022 Oligoanovulación crónica

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 20.2 Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP): Criterios de Rotterdam, Resistencia a la Insulina y Manejo

QUÉ HAY QUE SABER

- Oligoanovulación: ciclos >35 días u oligo/amenorrea; la causa más frecuente es el síndrome de ovario poliquístico; también hiperprolactinemia, hipotiroidismo e hipotalámica funcional.

- SOP por criterios de Rotterdam (2 de 3): oligo/anovulación, hiperandrogenismo clínico (hirsutismo, acné) o bioquímico, y morfología poliquística ecográfica.
- Antes de confirmar: descartar embarazo y pedir TSH, prolactina y 17-OH-progesterona (hiperplasia suprarrenal no clásica); evaluar resistencia insulínica (glicemia, PTGO) y lípidos.
- Riesgo de la anovulación crónica: endometrio expuesto a estrógeno sin oposición → hiperplasia y cáncer de endometrio; asocia síndrome metabólico y DM2.
- Manejo inicial: bajar 5–10% del peso; sin deseo de embarazo → ACO con progestágeno antiandrogénico (ciproterona, drospirenona) o progestágeno cíclico; metformina si hay resistencia insulínica.
- Con deseo de embarazo: inducción de ovulación con letrozol (primera línea) o clomifeno. Seguimiento: derivar a ginecología/endocrinología ginecológica.

Sin pregunta

3.01.1.023 Patología benigna del endometrio (hiperplasia, pólipos…)

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 20.3 Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo

QUÉ HAY QUE SABER

- Pólipo endometrial: causa estructural más frecuente de sangrado intermenstrual; también metrorragia postmenopáusica. Ecografía: engrosamiento focal; histerosonografía o histeroscopía confirma.
- Hiperplasia endometrial: por estrógeno sin oposición (obesidad, SOP/anovulación, tamoxifeno, TRH sin progestágeno); se manifiesta como sangrado uterino anormal.
- Sospecha: sangrado anormal en ≥45 años, metrorragia postmenopáusica con endometrio ≥4–5 mm (≥8 mm con TRH) o <45 años con factores de riesgo → biopsia con Pipelle.
- La hiperplasia con atipia (neoplasia intraepitelial endometrial) tiene alto riesgo de coexistir o progresar a cáncer: histerectomía si la paridad está cumplida.
- Hiperplasia sin atipia: progestágenos (DIU-LNG de elección u orales) y control con biopsia; pólipo sintomático o postmenopáusico: polipectomía histeroscópica.
- Manejo inicial del médico general: estudiar con ecografía, corregir anemia y derivar. Seguimiento: derivar a ginecología.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 49

Mujer con sangrado intermenstrual. La ecografía muestra un pólipo endometrial de 15 mm. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Legrado uterino diagnóstico-terapéutico
B) Anticonceptivos orales para control del sangrado
C) Seguimiento ecográfico en 6 meses
D) Realizar histeroscopia
E) Histerectomía

Respuesta D. El pólipo endometrial es la causa estructural (P de PALM-COEIN) más frecuente de sangrado intermenstrual, y su manejo de elección es la resección guiada por histeroscopía, que además permite el estudio histológico completo.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 120 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 68 años, nulípara, con antecedente de menopausia a los 50 años, consulta debido a sangrado genital intermitente de 2 meses de evolución, con cuantía variable. Se realiza una ecografía transvaginal que muestra un endometrio de 13 mm de grosor de aspecto heterogénea, con áreas microquísticas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hiperplasia endometrial
B) Miomatosis endometrial
C) Atrofia endometrial
D) Pólipo endometrial
E) Cáncer de endometrio

Respuesta A. Hiperplasia Endometrial: El endometrio grueso e irregular es una característica tanto de la hiperplasia endometrial como del cáncer de endometrio. Sin embargo, la descripción de un aspecto heterogéneo con áreas microquísticas se observa con mayor frecuencia en la hiperplasia endometrial, por lo que esta es la respuesta correcta. Eso sí, la conducta es realizar una biopsia de endometrio para confir

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 124 · texto original del banco, sin revisar

Pcte de 39 años con metrorragia e hipermenorrea, eco con endometrio homogéneo y masa en fondo uterino, conducta:

A) histeroscopia (segun yo tmbn x4, obs pólipo endometrial)
B) biopsia endometrial
C) Observación clínica
D) Derivar a urgencia
E) Control ambulatorio

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: histeroscopia (segun yo tmbn x4, obs pólipo endometrial) (opción A). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 37 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 35 años, nulípara, sin antecedentes mórbidos de importancia, consulta porque desde hace 6 meses ha presentado aumento del flujo menstrual. Su examen físico no aporta mayor información. Tiene PAP sin presencia de células atípicas, realizado hace 8 meses. Se realiza una ecografía transvaginal, que muestra la presencia de un pólipo endometrial de 8 mm de diámetro. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar histerosonografía
B) Realizar histerectomía
C) Realizar histeroscopía
D) Realizar legrado uterino
E) Iniciar anticonceptivos orales

Respuesta C. Conducta / Tratamiento indicado: Realizar histeroscopía (opción C). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención. Las opciones alternativas (Realizar histerosonografía, Realizar histerectomía) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan

3.01.1.024 Patología maligna del endometrio

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 20.15 Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores

QUÉ HAY QUE SABER

- Sangrado postmenopáusico es cáncer de endometrio hasta demostrar lo contrario; es su síntoma cardinal (presente en >90%).
- Tipo I (80%, endometrioide, estrógeno-dependiente, buen pronóstico): obesidad (el factor más potente), nuliparidad, SOP/anovulación, tamoxifeno, diabetes, síndrome de Lynch. Tipo II (seroso, células claras): mujeres mayores, agresivo.
- Estudio: ecografía transvaginal; endometrio ≥4–5 mm (≥8 mm con TRH) → biopsia con Pipelle; si es insuficiente o no concluyente → histeroscopía con biopsia dirigida.
- Confirmado: TAC de tórax, abdomen y pelvis y cirugía etapificadora (histerectomía total + salpingooforectomía bilateral + ganglio centinela o linfadenectomía); adyuvancia según estadio.
- Lynch: tamizaje anual desde los 30–35 años y cirugía profiláctica a los 40 con paridad cumplida.
- Manejo inicial: si sangra abundante, estabilizar; derivar a ginecología oncológica. Seguimiento: derivar.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 81

Una paciente de 56 años, en tratamiento con tamoxifeno 20 mg al día por un cáncer de mama diagnosticado hace 9 años, presenta metrorragia escasa desde hace 5 días, por lo que se solicita una ecografía transvaginal, que muestra un endometrio de 8 mm, sin alteraciones anexiales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar terapia de reemplazo hormonal oral
B) Instalar dispositivo intrauterino medicado
C) Disminuir la dosis de tamoxifeno
D) Solicitar biopsia endometrial
E) Realizar histerectomía

Respuesta D. El tamoxifeno actúa como estrógeno en el endometrio y sube el riesgo de hiperplasia y cáncer endometrial. Con metrorragia postmenopáusica y un endometrio de 8 mm, la conducta es biopsiar, no ajustar el tamoxifeno ni operar sin diagnóstico previo.

Pregunta de práctica

Mujer de 58 años, con menopausia hace 7 años, sin terapia de reemplazo hormonal, consulta por un sangrado genital escaso de 10 días de evolución. La ecografía transvaginal muestra un endometrio de 9 mm, heterogéneo, con anexos normales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Indicar estrógenos vaginales y controlar en 3 meses
B) Realizar biopsia endometrial ambulatoria con cánula de Pipelle
C) Solicitar resonancia magnética de pelvis
D) Indicar reposo y observar la evolución
E) Programar histerectomía sin estudio previo

Respuesta B. Sangrado postmenopáusico con endometrio de 9 mm, muy por encima del corte de 4 a 5 mm sin TRH: se biopsia de inmediato con cánula de Pipelle. Los estrógenos, el reposo o la observación retrasan un diagnóstico posible de cáncer, y operar sin biopsia previa es un error grave.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 178 · texto original del banco, sin revisar

Una mujer de 65 años, nulípara, con IMC de 33, sin síntomas, se realiza un PAP que muestra abundantes células endometriales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Controlar con nuevo PAP en un año
B) Indicar estrógenos tópicos
C) Solicitar colposcopía y biopsia
D) Realizar curejate endocervical
E) Solicitar ecografía transvaginal

Respuesta E. Tiene factores de riesgo de cáncer de endometrio (obesidad y nuliparidad) y además células endometriales. Se debe descartar una hiperplasia endometrial o cáncer de endometrio, partiendo por la Eco.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 166 · texto original del banco, sin revisar

Paciente de 40 y tantos años con uso de ACO, suspendidos hace 2 semanas por gastritis. Inicia con sangrado hace 3 días?, eco con endometrio de 10 mm heterogéneo. Conducta más adecuada:

A) Suspender ACO y controlar en 3 meses
B) Legrado biópsico en pabellón
C) Biopsia aspirativa de forma ambulatoria.
D) Interrupción del embarazo
E) Maduración pulmonar y observación

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Suspender ACO y controlar en 3 meses (opción A). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

3.01.1.025 Proceso inflamatorio pelviano

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 20.11 Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EIP / PIP): Criterios de Hager, Clasificación de Monif y Esquemas Terapéuticos

QUÉ HAY QUE SABER

- Infección ascendente por gonococo o Chlamydia (y flora polimicrobiana): endometritis → salpingitis → peritonitis pélvica → absceso tubo-ovárico.

- Criterios de Hager: los 3 mayores (dolor abdominal bajo, dolor a la movilización cervical, dolor anexial) + al menos 1 menor (fiebre >38,3 °C, leucorrea patológica, PCR/leucocitos altos, cultivo positivo).
- Estudio: beta-hCG (descartar ectópico), ecografía transvaginal (absceso), hemograma, PCR, cultivos; ante la sospecha clínica no retrasar el tratamiento.
- Ambulatorio (Monif I–II sin gravedad): ceftriaxona 500 mg IM dosis única + doxiciclina 100 mg c/12 h + metronidazol 500 mg c/12 h VO por 14 días; tratar a la pareja.
- Hospitalizar si: absceso tubo-ovárico, embarazo, peritonitis difusa, falta de respuesta o intolerancia oral, duda diagnóstica; esquema EV (o clindamicina + gentamicina).
- Secuelas: infertilidad tubaria, ectópico, dolor pelviano crónico; Fitz-Hugh-Curtis (dolor en hipocondrio derecho). El DIU solo aumenta el riesgo el primer mes. Seguimiento: derivar a ginecología.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 152

Mujer de 25 años, sexualmente activa, sin métodos de barrera, con fiebre, dolor abdominal, disuria, polaquiuria y leucorrea. Temperatura 38 grados, dolor a la palpación abdominal mayor en la fosa ilíaca derecha, leucorrea y dolor a la palpación bimanual. **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A) Escherichia coli
B) Gardnerella vaginalis
C) Trichomona vaginalis
D) Estreptococo grupo A
E) Gonococo

Respuesta E. Cuadro clínico de enfermedad pélvica inflamatoria (fiebre, dolor abdominal bajo y dolor a la palpación bimanual): el agente etiológico clásico es el gonococo, junto con Chlamydia trachomatis.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 174

Mujer de 26 años, sexualmente activa, consulta por disuria y dolor abdominal bajo que luego se extiende al hipocondrio derecho, con leucorrea. Al examen hay dolor a la palpación hipogástrica y del hipocondrio derecho, y en el examen ginecológico se constata leucorrea, sin mal olor. **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A) Enterococcus faecalis
B) Ureaplasma urealyticum
C) Chlamydia trachomatis
D) Treponema pallidum
E) Mycoplasma genitalium

Respuesta C. Dolor pélvico que se extiende al hipocondrio derecho: síndrome de Fitz-Hugh-Curtis, complicación de la enfermedad pélvica inflamatoria causada habitualmente por Chlamydia trachomatis o gonococo.

Pregunta de práctica

Mujer de 23 años, sexualmente activa, con dolor en hipogastrio de 3 días, fiebre de 38,6 grados y flujo purulento. Al tacto bimanual hay dolor a la movilización cervical y dolor anexial bilateral, sin masas. La ecografía transvaginal no muestra colecciones y el test de embarazo es negativo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Hospitalizar para tratamiento endovenoso
B) Laparoscopía exploradora de urgencia
C) Ceftriaxona intramuscular más doxiciclina y metronidazol orales por 14 días
D) Solo doxiciclina oral por 7 días
E) Retirar el DIU y esperar evolución

Respuesta C. Se cumplen los tres criterios mayores de Hager, con un criterio menor (fiebre), sin masas ni signos de gravedad: EIP estadio I-II de Monif, de manejo ambulatorio con el esquema triple durante 14 días.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 80 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de mantiene actividad sexual, sin método anticonceptivo, consulta por fiebre, asociada a dolor abdominal de 3 días de evolución. Al examen físico presenta abdomen sensible y al examen ginecológico destaca útero doloroso, tanto a la palpación, como a la movilización. Se solicitan exámenes, que muestran test de embarazo negativo, hemograma con leucocitos: 18.000 por campo y PCR: 8,0 mg/L. La ecografía transvaginal muestra presencia de líquido libre escaso en la cavidad peritoneal, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

A) Iniciar tratamiento sintomático con ácido mefenámico
B) Realizar cultivo endocervical
C) Indicar anticonceptivos orales
D) Iniciar tratamiento antibiótico
E) Realizar laparotomía exploradora

Respuesta D. Tiene un proceso inflamatorio pélvico, no complicado, por lo que se trata con antibióticos de amplio espectro.

3.01.1.026 Prolapso genital

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 20.6 Prolapso de Órganos Pélvicos (POP-Q) e Incontinencia Urinaria de Esfuerzo vs Urgencia

QUÉ HAY QUE SABER

- Prolapso de órganos pélvicos: descenso de pared anterior (cistocele), apical (útero/cúpula) o posterior (rectocele) por daño del piso pélvico.
- Factores de riesgo: partos vaginales traumáticos (fórceps, RN grandes), multiparidad, menopausia (hipoestrogenismo), obesidad, constipación y tos crónica.
- Sospecha: sensación de bulto o peso vaginal que empeora de pie o al final del día, dificultad miccional o defecatoria, que a veces requiere reducción manual.
- Clasificación POP-Q con el himen como punto 0: estadio 2 entre 1 cm sobre y 1 cm bajo el himen; estadio 4, eversión completa.
- Manejo inicial: ejercicios de Kegel, control de peso y constipación, estrógeno vaginal en atrofia; pesario si no desea o no tolera cirugía.
- Seguimiento: derivar a ginecología (uroginecología) para cirugía en prolapsos sintomáticos (colporrafia, histerectomía vaginal, sacrocolpopexia).

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 45

Mujer de 58 años, multípara de 4, presenta sensación de peso vaginal, asociada a escapes de orina al inicio del deseo miccional. Al examen físico presenta prolapso genital. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar oxibutinina oral
B) Realizar prueba de Q-tip
C) Realizar la estadificación POP-Q
D) Solicitar resonancia magnética pelviana
E) Realizar histerectomía

Respuesta C. Ante un prolapso genital confirmado al examen, el paso siguiente es cuantificarlo formalmente con el sistema POP-Q, que mide cada compartimento tomando el himen como plano de referencia. Recién con esa estadificación se decide el tratamiento.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 143 · texto original del banco, sin revisar

Una mujer de 87 años, es institucionalizada por una demencia tipo Alzheimer. Al examen físico del ingreso se aprecia lo siguiente: INSERTAR FOTO ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar cirugía de urgencia
B) Realizar PAP y colposcopía
C) Indicar pesario
D) Realizar biopsia
E) Cuidados paliativos

Respuesta C. Era un prolapso uterino completo. Si fuera una mujer sana, se haría cirugía electi- va (no de urgencia), pero dado que era una paciente con alzheimer avanzado, se puede dejar pesario.

3.01.1.027 Síndrome climatérico y menopausia

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 20.12 Climaterio, Menopausia y Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH): Ventana de Oportunidad y Riesgos

QUÉ HAY QUE SABER

- Menopausia: diagnóstico clínico tras 12 meses de amenorrea en mujer >45 años; no pedir FSH de rutina (solo si se sospecha insuficiencia ovárica antes de los 40).
- Síntomas: corto plazo bochornos, sudoración nocturna, insomnio y cambios del ánimo; mediano plazo síndrome genitourinario (sequedad, dispareunia, disuria); largo plazo osteoporosis y riesgo cardiovascular.
- TRH en síntomas que alteran la calidad de vida dentro de la ventana de oportunidad (<60 años o <10 años de menopausia): con útero, estrógeno + progestágeno obligatorio; histerectomizada, estrógeno solo.
- Contraindicaciones: cáncer de mama o endometrio, trombosis o evento cardiovascular, enfermedad hepática activa, sangrado uterino no estudiado.
- Alternativas no hormonales para bochornos: venlafaxina, paroxetina (no con tamoxifeno), gabapentina; atrofia vaginal: estrógeno vaginal local y lubricantes.
- Seguimiento completo: control anual con PA, peso, perfil lipídico, glicemia, mamografía, PAP y densitometría según riesgo; reevaluar la TRH cada año y usar la menor dosis eficaz.

PREGUNTAS (17)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 78

Mujer de 52 años con reglas irregulares desde hace 8 meses, asociadas a bochornos frecuentes, con calor, enrojecimiento de la cara, sudoración nocturna y dificultad para dormir. **¿Cuál es la indicación más adecuada para el manejo de sus síntomas?**

A) Fitoestrógenos
B) Terapia de reemplazo hormonal combinada continua
C) Terapia de reemplazo hormonal combinada cíclica
D) Estrógenos solos continuos
E) Progestágenos solos continuos

Respuesta B. Síntomas vasomotores en una mujer con reglas irregulares (útero intacto): terapia de reemplazo hormonal combinada continua, con estrógeno más progestágeno.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 139

Estás evaluando los criterios para elegir el esquema de terapia de reemplazo hormonal. **¿Qué antecedente es indicación del uso de estrógenos orales solos, en la terapia de reemplazo hormonal?**

A) Antecedente de cáncer de mama
B) Antecedente de dislipidemia
C) Antecedente de histerectomía total
D) Osteoporosis
E) Edad mayor a 70 años

Respuesta C. El progestágeno se agrega únicamente para proteger el endometrio. Si la paciente fue histerectomizada, ya no tiene endometrio que proteger, y se indica estrógeno solo.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 87

Mujer de 35 años, con antecedente de histerectomía radical por cáncer de cuello uterino hace 2 años, consulta por bochornos frecuentes, sequedad genital, dispareunia e insomnio. IMC de 28. Colesterol total 221 mg/dL, colesterol HDL 32 mg/dL, triglicéridos 456 mg/dL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Estrógeno más progestágeno oral
B) Estrógeno solo vía oral
C) Estrógeno en parches
D) Venlafaxina oral
E) Progestágenos tópicos

Respuesta C. Histerectomía radical (sin útero, sin ovarios): estrógeno solo, sin progestágeno. Por la hipertrigliceridemia marcada, se prefiere la vía transdérmica, que evita el paso hepático.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 43 · texto original del banco, sin revisar

Mujer de 56 años postmenopáusica con sequedad vaginal severa, dispareunia y urgencia urinaria. Sin tratamiento actual. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea?

A) Estrógenos tópicos vaginales
B) Estrógenos orales sistémicos
C) Lubricantes vaginales sin hormonas
D) Ospemifeno oral
E) Testosterona tópica

Respuesta A. Síndrome genitourinario de la menopausia (sequedad vaginal + dispareunia + síntomas urinarios): primera línea = estrógenos tópicos vaginales (crema, óvulos o anillo). Acción local, mínima absorción sistémica, pueden usarse incluso en pacientes con CA mama en muchos contextos.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 47 · texto original del banco, sin revisar

Mujer en menopausia con sequedad vaginal y dispareunia, atrofia de la mucosa vaginal. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Lubricante vaginal sin hormonas
B) Terapia hormonal sistémica
C) Promestrieno tópico vaginal
D) Estriol oral
E) Tibolona oral

Respuesta C. Conducta / Tratamiento indicado: Promestrieno tópico vaginal (opción C). Promestrieno tópico vaginal. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 178 · texto original del banco, sin revisar

Una mujer de 49 años obesa consulta por síntomas vasomotores consistentes en calor y enrojecimiento de pecho y cara, que ocurren con frecuencia, especialmente en la noche. Refiere que sus menstruaciones son cada vez más infrecuentes, cada 2 a 3 meses. ¿Qué tratamiento es el más adecuado para el manejo de sus síntomas?

A) Estrógeno más progesterona vía oral
B) Estrógeno más progesterona transdérmicos
C) Paroxe2na
D) An2concep2vos orales combinados
E) Estrógeno tópico

Respuesta B. Los síntomas vasomotores son indicación de terapia de reemplazo hormonal (TRH). Por tener útero se indica una asociación de estrógeno y progestina (en histerectomizadas se usa estrógeno solo). La vía de administración suele ser oral, aunque algunos prefieren la vía transdérmica se recomienda en pacientes obesas y con hipertrigliceridemia. Aunque no existe buena evidencia que respalde estas recomen

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 42 · texto original del banco, sin revisar

Mujer de 52 años con menopausia hace 2 años y sequedad vaginal severa. Inicia estrógenos tópicos vaginales. ¿Con qué frecuencia se deben aplicar en la fase de mantenimiento?

A) Una vez al día
B) Dos veces al día
C) Dos o tres veces por semana
D) Una vez por semana
E) Solo durante el período sintomático

Respuesta C. Estrógenos tópicos vaginales: fase inicial diaria por 2 semanas, luego mantenimiento 2-3 veces por semana. Dos veces al día en mantenimiento es dosis excesiva innecesaria.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 88 · texto original del banco, sin revisar

Una mujer de 52 años presenta reglas irregulares, desde hace 6 meses, asociada a bochornos frecuentes, con calor y enrojecimiento de la cara, que le molestan para dormir. ¿Cuál es la indicación más adecuada?

A) Fitoestrógenos
B) Terapia de reemplazo hormonal combinada continua
C) Terapia de reemplazo hormonal combinada cíclica
D) Estrógenos solos continuos
E) Progestágenos solos continuos

Respuesta B. La TRH comúnmente indicada es la combinada (estrógeno más progestágeno) continua. Si hubiese sido histerectomizada, se indican estrógenos solos.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 47 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 68 años, consulta por disuria y dispareunia de 5 meses de evolución, que ha ido en aumento. Cuenta con múltiples exámenes de orina y urocultivos, que han resultado negativos. En su examen físico, se constata mucosa vaginal pálida y seca, flujo patológico. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Promestireno tópico vaginal
B) 17 beta estradiol por vía oral
C) Tibolona oral
D) Acetato de medroxiprogesterona por vía oral
E) Estradiol más dienogest por vía oral

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: 17 beta estradiol por vía oral (opción B). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 61 · texto original del banco, sin revisar

Mujer de no se q edad 40-50? Menopáusica con clínica de 5 años de evolución con dispareunia y sequedad vaginal severa, sin ningún otro síntoma. con antecedente de ca de mama en tto con tamoxifeno. preguntan conducta inicial

A) Lubricante e hidratante vaginal
B) Estrógenos vaginales
C) Suspender tamoxifeno
D) Observación clínica
E) Derivar a urgencia

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Lubricante e hidratante vaginal (opción A). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 4 · texto original del banco, sin revisar

Una mujer de 54 años, menopáusica hace 2 años, con antecedente de enfermedad coronaria, consulta por sudoración y sensación calor en el pecho y rostro, que ocurre en episodios frecuentes y molestos, mayores en la noche. ¿Cuál es la terapia de elección?

A) Estradiol tópico intravaginal
B) Escitalopram oral
C) Tibolona oral
D) Terapia hormonal combinada de 17 beta estradiol más drospirenona por vía oral
E) Estradiol y progesterona combinados por vía transdérmica

Respuesta D. La alternativa correcta es la D (Terapia hormonal combinada de 17 beta estradiol más drospirenona por vía oral). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 9 · texto original del banco, sin revisar

Postmenopáusica con antecedente de IAM y bochornos: a. iniciar Escitalopram

B) Resto opciones tenian estradiol
B) Ninguna de las anteriores es correcta
C) Todas las anteriores son correctas
D) No se dispone de información suficiente
E) Otra alternativa no descrita

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Resto opciones tenian estradiol, Ninguna de las anteriores es correcta) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación de

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 75 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 51 años, obesa, con antecedente de menopausia a los 48 años, consulta por síntomas vasomotores intensos caracterizados por enrojecimiento y calor de la cara y pecho, mayores en la noche y que son muy molestos. Hace un año se realizó una histerectomía total, debido a diagnóstico de hiperplasia endometrial atípica. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de sus síntomas?

A) Estradiol más dienogest por vía oral
B) Estriol por vía vaginal
C) Estradiol gel, por vía transdérmica
D) Anticonceptivos orales combinados
E) Venlafaxina vía oral

Respuesta C. Terapia de Reemplazo Hormonal: Los síntomas vasomotores de la menopausia se tratan con terapia de reemplazo hormonal (TRH), a menos que esté contraindicada. Un antecedente de hiperplasia endometrial atípica no contraindica la TRH si ya fue tratada, pero sí lo haría si estuviera activa. La histerectomía implica que la TRH se realice solo con estrógeno, a diferencia de las pacientes con útero que re

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 19 · texto original del banco, sin revisar

Mujer con síntomas menopáusicos, con FRCV, histerectomizada, cuál es la mejor opción de manejo: a. Estradiol tópico

B) Estradiol
B) Amoxicilina
C) Ibuprofeno
D) Paracetamol
E) Omeprazol

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Estradiol (opción B). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención. Las opciones alternativas (Ibuprofeno, Paracetamol) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 46 · texto original del banco, sin revisar

Mujer en menopausia con bochornos y sudoración, antecedente de IAM a los 49 años. ¿Cuál es la terapia más adecuada?

A) Terapia hormonal con estrógenos solos
B) Terapia hormonal combinada (estrógeno + progestina)
C) Tibolona oral
D) Clonidina transdérmica
E) Escitalopram 10 mg/día

Respuesta E. La alternativa correcta es la E (Escitalopram 10 mg/día). Escitalopram 10 mg/día. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Terapia hormonal con estrógenos solos, Terapia hormonal combinada (estrógeno + proge) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnós

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 148 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 42 años se realiza un histerectomía radical, por un cáncer de cuello uterino. Evoluciona con bochornos, cefalea y dispareunia profunda, por resequedad vaginal. Al examen físico tiene sobrepeso y presi´pon arterial normal. Además trae exámenes en los que destaca Colesterol total: 204 mg/dl, Colesterol HDL: 54 mg/dl, Triglicéridos: 405 mg/dl. ¿Qué tratamiento es el más adecuado?

A) Estrógenos más progestágenos orales
B) Estrógenos orales
C) Estrógenos en parches
D) Progestágenos endovaginales
E) Sertralina

Respuesta C. Por estar histerectomizada, debe recibir estrógeno solo y por ser dislipidémica, debe ser por vía transdérmica. Recordar que lo habitual es dar estrógenos más progestágenos, para evitar el riesgo de cáncer de endometrio, pero con la histerectomía, ya no existe el riesgo de dicho cáncer y bastan los estrógenos.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 159 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 48 años, consulta por episodios de calor y enrojecimiento de la cara y la zona superior del tórax, que duran algunos minutos y ceden espontáneamente, no ha presentado menstruación en los últimos doce meses. Su examen físico es normal. Refiere antecedente de hermana con cáncer de mama. ¿Cuál de los siguientes fármacos indicaría como terapia de reemplazo hormonal en esta paciente?

A) Tibolona
B) Estrógenos y progestágenos orales
C) Estrógenos transdérmicos
D) Tamoxifeno
E) Venlafaxina

Respuesta A. Por el antecedente familiar de cáncer evitar los estrógenos, pero es fuertemente discutible, ya que las recomendaciones solo plantean como contraindicación al antecedente personal de cáncer de mama y no al antecedente familiar, sin embargo este es uno de los casos en que se da la tibolona, sabiendo que no hay mucha evidencia que lo respalde. La venlafaxina igual se usa, aunque no sirve mucho. Tibo

3.01.1.028 Tumores ováricos

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 20.15 Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores

QUÉ HAY QUE SABER

- Masa anexial: la mayoría son funcionales en edad fértil (quistes foliculares, cuerpo lúteo); en postmenopausia aumenta la probabilidad de malignidad.
- Cáncer de ovario: diagnóstico tardío (>70% en estadio III–IV) con síntomas vagos: distensión, saciedad precoz, dolor sordo, aumento del abdomen; el más frecuente es el seroso de alto grado.
- Ecografía (IOTA): quiste simple unilocular anecoico sin flujo = benigno (control en 6–12 semanas); papilas >3 mm, componente sólido, flujo central o ascitis = sospecha de malignidad.
- Marcadores: CA-125 útil en la postmenopáusica (en la joven sube con endometriosis, miomas, PIP); en la joven con masa sólida pedir AFP, beta-hCG y LDH (tumores germinales).
- Factores de riesgo: BRCA1/2, Lynch, nuliparidad, endometriosis; protectores: ACO, multiparidad, salpingectomía. Masa sospechosa nunca se punciona (siembra peritoneal).
- Manejo inicial: derivar a ginecología (oncológica si hay criterios de malignidad) para cirugía etapificadora y citorreducción. Seguimiento: derivar.

PREGUNTAS (5)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 87

Una paciente de 70 años consulta por dolor abdominal de intensidad progresiva, que inició hace 4 meses. Ha bajado 5 kilogramos de peso. Al examen físico se observa abdomen distendido y destaca una masa anexial de 7 cm, de consistencia aumentada. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Quiste funcional
B) Mioma uterino
C) Cáncer de ovario
D) Cáncer de colon
E) Endometriosis

Respuesta C. Mujer postmenopáusica con dolor abdominal progresivo, baja de peso y una masa anexial firme y de consistencia aumentada: es el cuadro clásico del cáncer de ovario, que se presenta tarde y con síntomas inespecíficos.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 150 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 55 años se realiza una ecografía transvaginal, como parte de un chequeo ginecológico, que visualiza una lesión anexial derecha, quística, de 4,5 cm de diámetro, con una pared fina y sin tabiques ni excescencias. Su última regla fue hace 5 años. ¿Cuál es la

A) Realizar laparoscopía
B) Iniciar análogos de la GnRH
C) Realizar bipsia de la lesión por punción, guiada por ecografía
D) Iniciar anticonceptivos orales
E) Realizar seguimiento ecográfico en 3 meses

Respuesta E. , ¿A? Es una pregunta muy difícil y en mi opinión es de manejo de especialista y tiene más de una opción de tratamiento. Tiene un quiste simple, en una mujer postmenopáusica. Se puede observar y controlar en 3 meses, dado que probablemente es benigno y actualmente muchos recomiendan observar los quistes simples de menos de 10 cm y solo operarlos si persisten sobre 5 cm a los 3 meses, por el riesgo

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 158 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 60 años consulta por dolor abdominal de 6 meses de evolución. Al examen físico se palpa una masa anexial derecha, de 8 cm de diámetro, con ascitis significativa. La ecografía transvaginal muestra una masa anexial, multiloculada, con increscencias y excrescencias. Su Ca- 125 resulta 700 UI/L. Se realiza un TAC que muestra engrosamiento peritoneal, probablemente de origen tumoral y se observa un tumor adosado a la pared gástrica y hepática. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Derivar a cuidados paliativos
B) Terapia de reemplazo hormonal
C) Cirugía más quimioterapia
D) Quimioterapia paliativa
E) Tamoxifeno

Respuesta D. El cáncer de ovario avanzado, fuera de alcance curativo, se trata con QT paliativa. Pregunta para especialista. No debería hacerse en el Eunacom.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 173 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 65 años, nulípara, asintomática, se realiza una ecografía tranvaginal, que muestra un tumor anexial izquierdo, de 23 mm, de aspecto quístico, con paredes lisas, sin tabiques ni excrecencias y sin presencia de líquido libre en la cavidad peritoneal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar laparoscopía
B) Iniciar terapia de reemplazo hormonal
C) Solicitar marcadores tumorales
D) Realizar punción del quiste
E) Realizar control ecográfico en 3 meses

Respuesta E. Pregunta demasiado específica. Es un tumor anexial en una mujer postmenopáusica (históricamente todos se tratan con anexectomía por laparoscopía). Sin embargo los quistes simples menores a 3 cm se siguen con Ecografía por 3 meses. Si persisten se piden marcadores tumorales y se operan solo si están positivos, ya que de lo contrario solo se observan. Hay estudios recientes que muestran que los quis

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 165 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 73 años presenta dolor abdominal moderado, en hipogastrio y fosa ilíaca izquierda, de 3 meses de evolución, sin otros síntomas. Al examen físico, se palpa una masa en la fosa ilíaca izquierda y, al examen ginecológico, se palpa confirma la masa anexial izquierda, de consistencia dura y 8 cm de diámetro. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?

A) Ecografía abdominal
B) Ecografía transvaginal
C) Resonancia magnética de abdomen y pelvis
D) TAC de abdomen y pelvis
E) Histerosonografía

Respuesta D. La alternativa correcta es la D (TAC de abdomen y pelvis). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Ecografía abdominal, Ecografía transvaginal) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del pa

3.01.1.029 Patología benigna de mama

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 20.14 Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna

QUÉ HAY QUE SABER

- Fibroadenoma: nódulo firme, móvil, indoloro, bien delimitado en mujer de 15–35 años; ecografía BI-RADS 2–3; observar si es pequeño, resecar si crece o genera dudas.
- Condición fibroquística (30–50 años): mastalgia cíclica bilateral y nodularidad difusa premenstrual; manejo con sostén adecuado y analgesia, tranquilizar.
- Papiloma intraductal: telorrea serohemática uniporo espontánea; estudio con ecografía y resección del conducto. Telorrea bilateral multiporo lechosa: pensar en hiperprolactinemia o fármacos.
- Quiste simple: ecografía diagnóstica, punción solo si es sintomático; mastitis no puerperal y absceso subareolar se asocian a tabaco.
- Primer estudio: ecografía mamaria en <35–40 años, mamografía + ecografía en mayores; BI-RADS 4–5 obliga a biopsia con aguja gruesa.
- Seguimiento completo: el médico general controla los BI-RADS 2 y realiza el control a 6 meses en BI-RADS 3; derivar si crece, cambia de características o hay telorrea hemática.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 161

Una paciente de 24 años se autopalpa un nódulo mamario de 2 cm, indoloro, que no está adherido a la piel ni a planos profundos. Se solicita una ecografía mamaria que muestra una lesión bien delimitada, de 25 mm de diámetro, homogénea, con una fina pared que la rodea. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Quiste mamario
B) Fibroadenoma
C) Cáncer de mama
D) Papiloma mamario
E) Tumor filoides

Respuesta B. Mujer joven con nódulo firme, móvil, bien delimitado y homogéneo en la ecografía: es el cuadro clásico del fibroadenoma, el tumor sólido benigno más frecuente entre los 15 y los 35 años.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 169 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 43 años, sin antecedentes, consulta por aparición de nódulo mamario, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se palpa nódulo pequeño, no adherido, de consistencia gomosa, sin presencia de adenopatías axilares. Se realiza mamografía inicialmente que es informada como BIRADS 0, por lo que se solicita ecografía mamaria que muestra un nódulo sólido de bordes regulares, con paredes lisas de dos milímetros. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Control con mamografía anual
B) Realizar biopsia estereotáxica
C) Realizar tumorectomía con biopsia rápida
D) Indicar estrógenos orales y controlar al año con nueva ecografía
E) Control con ecografía en seis meses

Respuesta E. Es un fibroadenoma. Se observa, pero se recomienda pedir una Eco en 6 meses porque hay un Cáncer de mama raro, que puede verse igual. Igual es una pregunta muy difícil. También sería correcto la mamografía en un año. Sí estoy seguro que los fibroadenomas se deben controlar al menor por un año con Eco, para asegurarse que no crezcan, como el cáncer raro mencionado.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 12 · texto original del banco, sin revisar

Una mujer de 23 años consulta porque se palpó un nódulo mamario en la mama derecha. Al examen físico tiene un nódulo de 5 cm, que se palpa liso y móvil. Se solicita ecografía mamaria, que muestra un nódulo de aspecto sólido, bien delimitado y encapsulado, de aspecto homogéneo, clasificación US-BIRADS2. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar biopsia estereotáxica
B) Control con mamografía en un año
C) Solicitar resonancia magnética nuclear de mamas
D) Controlar con nueva ecografía mamaria en 6 meses
E) Realizar remoción quirúrgica

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Control con mamografía en un año (opción B). El tratamiento de la mastopatía fibroquística es educación de que no es cáncer ni se transforma en cáncer, se resuelve con la menopausia, y AINEs como ácido mefenámico para el dolor. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

3.01.1.030 Cáncer de mama

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 20.14 Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna

QUÉ HAY QUE SABER

- Primera causa de muerte por cáncer en la mujer chilena; factores: edad, BRCA1/2, familiar de 1.er grado (sobre todo <40 años), radioterapia torácica joven, hiperplasia atípica, menarquia precoz/menopausia tardía, nuliparidad, obesidad, TRH prolongada.
- Sospecha: nódulo duro, indoloro, adherido, de bordes irregulares; retracción del pezón o la piel, piel de naranja, telorrea hemática uniporo, adenopatía axilar.
- Estudio: mamografía + ecografía; BI-RADS 4–5 → biopsia con aguja gruesa (no PAAF); BI-RADS 0 → completar con ecografía o proyecciones; BI-RADS 3 → control en 6 meses.
- GES: tamizaje con mamografía cada 2 años de 50 a 69 años (alto riesgo genético desde 30–35); confirmación y tratamiento con plazos garantizados ante sospecha.
- Tratamiento según subtipo: luminal A hormonoterapia (tamoxifeno en premenopáusica, inhibidor de aromatasa en postmenopáusica), HER2 + trastuzumab, triple negativo quimioterapia; cirugía conservadora + radioterapia o mastectomía + ganglio centinela.
- Manejo inicial: derivar a especialista (unidad de patología mamaria) ante sospecha clínica o BI-RADS 4–5. Seguimiento: derivar; el médico general controla efectos de tamoxifeno (endometrio, trombosis) e inhibidores (osteoporosis).

PREGUNTAS (1)

Pregunta del libro · Tema 20.14

Una paciente de 52 años asintomática se realiza una mamografía de tamizaje rutinario que informa: 'En el cuadrante superoexterno de la mama izquierda se observa un nódulo espiculado de 15 mm con microcalcificaciones heterogéneas agrupadas en su interior, clasificado como BI-RADS 4C'. ¿Cuál es la conducta diagnóstica de primera línea indicada a continuación?

A) Control mamográfico estricto a los 6 meses para evaluar estabilidad
B) Realización de Biopsia con aguja gruesa (Core Biopsy) guiada por imágenes
C) Mastectomía radical de urgencia sin confirmación anatomopatológica previa
D) Punción con aguja fina (PAAF) para estudio citológico exclusivo
E) Administración empírica de tamoxifeno oral durante 3 meses

Respuesta B. A) Incorrecta. El control a los 6 meses es la conducta exclusiva de la categoría BI-RADS 3 (95%) tiene indicación formal y mandatoria de confirmación histológica mediante Biopsia Percutánea con Aguja Gruesa (Core Biopsy o Tru-Cut) guiada por ecografía o estereotaxia. Este procedimiento obtiene cilindros de tejido que permiten diagnosticar invasión del estroma y realizar el panel inmunohistoquímico completo (RE, RP, HER2 y Ki-67). C) Incorrecta. Mutilar una mama sin diagnóstico histológico previo es una mala praxis inadmisible. D) Incorrecta. La PAAF solo aporta células aisladas que no permiten distinguir carcinoma in situ de carcinoma invasor ni medir adecuadamente los receptores. E) Incorrecta. La hormonoterapia requiere confirmación histológica de neoplasia con receptores positivos.

3.01.1.031 VIH en ginecobstetricia

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.1 Infección por VIH: Diagnóstico, Etapificación y Terapia Antirretroviral (TARV GES)

QUÉ HAY QUE SABER

- Tamizaje de VIH en toda embarazada con consentimiento en el 1.er control y repetido en el 3.er trimestre (32–34 semanas); test rápido en el preparto si no hay resultado.
- Test reactivo (ELISA o rápido) es preliminar: segunda muestra al ISP, único facultado para confirmar; en el parto, ante test rápido reactivo se inicia profilaxis sin esperar la confirmación.
- TARV inmediata en toda embarazada con VIH (GES), independiente de CD4; esquema con tenofovir + lamivudina/emtricitabina + dolutegravir; meta carga viral indetectable a las 34–36 semanas.
- Parto: zidovudina EV intraparto si carga viral >1.000 copias o desconocida, y cesárea electiva a las 38 semanas en ese caso; con carga indetectable puede tener parto vaginal.
- Recién nacido: zidovudina oral (± otros ARV si alto riesgo) y suspensión de la lactancia materna (inhibir con cabergolina), con fórmula láctea garantizada.
- Seguimiento: derivar a centro de atención VIH y alto riesgo obstétrico; diagnóstico del niño con PCR seriadas.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 165

Una paciente de 30 años, cursando un embarazo de 32 semanas, sin controles previos, se realiza un Elisa para VIH, que resulta positivo. **¿Cuál es la conducta más importante para evitar la transmisión vertical?**

A) Iniciar triterapia antirretroviral ahora
B) Realizar cesárea ahora
C) Iniciar triterapia antirretroviral si la carga viral es alta
D) Administrar terapia antirretroviral durante el trabajo de parto
E) Realizar cesárea al llegar a las 38 semanas

Respuesta A. La medida más importante para prevenir la transmisión vertical es la terapia antirretroviral de la madre durante el embarazo, iniciada de inmediato, sin condicionarla a la carga viral. La vía del parto se decide después según la carga viral alcanzada.

Pregunta de práctica

Puérpera de 27 años, con infección por VIH en terapia antirretroviral desde el primer trimestre y carga viral indetectable a las 36 semanas. Tuvo un parto vaginal hace 2 horas, con recién nacido sano de término. Pregunta si puede amamantar. **¿Cuál es la recomendación más adecuada según la norma chilena de transmisión vertical?**

A) Suspender la lactancia materna, inhibirla con cabergolina y alimentar con fórmula
B) Lactancia materna exclusiva, ya que la carga viral es indetectable
C) Lactancia mixta durante los primeros 3 meses
D) Extraer la leche y administrarla tras congelarla
E) Lactancia materna exclusiva si el recién nacido recibe zidovudina

Respuesta A. En Chile la norma de prevención de transmisión vertical del VIH contraindica la lactancia materna aun con carga viral indetectable, porque el riesgo no es cero y existe alternativa segura. Se inhibe la lactancia con cabergolina, se entrega fórmula láctea y el recién nacido recibe profilaxis antirretroviral.

3.01.1.032 Incontinencia urinaria

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 20.6 Prolapso de Órganos Pélvicos (POP-Q) e Incontinencia Urinaria de Esfuerzo vs Urgencia

QUÉ HAY QUE SABER

- De esfuerzo: escape de poco volumen sincrónico con tos, risa o ejercicio, sin urgencia; por hipermovilidad uretral tras partos vaginales. Prueba de esfuerzo positiva con vejiga llena.
- De urgencia (vejiga hiperactiva): deseo imperioso seguido de escape de mayor volumen, con polaquiuria (≥8/día) y nicturia (≥2); mixta cuando coexisten.
- Estudio inicial: historia, diario miccional, examen pélvico (prolapso, atrofia), urocultivo negativo (descartar ITU), residuo postmiccional; urodinamia antes de cirugía o si hay duda.
- Esfuerzo: ejercicios de Kegel/kinesioterapia de piso pélvico como primera línea; cabestrillo mediouretral (TOT/TVT) si fracasa.
- Urgencia: reeducación vesical (micción por horario), restringir cafeína, anticolinérgicos (oxibutinina, solifenacina) o mirabegrón; la cirugía está contraindicada.
- Rebalse: goteo continuo con residuo alto (obstrucción, neuropatía diabética): estudiar. Seguimiento: derivar a uroginecología si falla el manejo inicial.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 47

Una paciente de 57 años, multípara de 5, presenta incontinencia de esfuerzos moderados. Su examen físico muestra genitales normales, sin prolapso. Tiene sedimento de orina normal y urocultivo negativo. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para esta paciente? **¿Cuál es el tratamiento más adecuado para esta paciente?**

A) Oxibutinina
B) Suspensión uretral
C) Terapia de remplazo hormonal
D) Kinesioterapia pélvica
E) Doxasozina

Respuesta D. Incontinencia de esfuerzo con urocultivo negativo: primero kinesioterapia pélvica. La cirugía de suspensión uretral viene después, si fracasa.

Pregunta de práctica

Mujer de 52 años, con 3 partos vaginales de recién nacidos grandes, consulta por escapes de orina de 2 años. Ocurren al toser fuerte, reírse o hacer ejercicio. Niega deseo urgente de orinar, no tiene polaquiuria y duerme sin levantarse. Al examen, con vejiga llena, se le pide toser y se observa un chorro de escape sincrónico con la tos. El urocultivo es negativo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar oxibutinina oral
B) Indicar ejercicios de Kegel de piso pélvico
C) Realizar cistoscopía
D) Instalar sonda Foley permanente
E) Indicar cabestrillo mediouretral de entrada, sin kinesioterapia previa

Respuesta B. El escape sincrónico con la tos, sin urgencia ni polaquiuria, y con la prueba de esfuerzo positiva, confirma incontinencia urinaria de esfuerzo. El manejo inicial siempre es la kinesioterapia de piso pélvico; el cabestrillo se reserva para cuando esta falla.

Situaciones clínicas de urgencia 21 códigos

3.01.2.001 Aborto provocado

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 19.10 Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar aborto provocado ante metrorragia del 1.er trimestre con fiebre, flujo fétido, lesiones cervicales o vaginales (pinzas, cuerpos extraños) o relato de uso de misoprostol.
- Aborto séptico: fiebre, taquicardia, útero blando y muy doloroso, flujo fétido por OCI abierto; buscar shock séptico y Clostridium (hemólisis, ictericia, falla renal).
- Manejo inicial: hospitalizar, estabilizar (vías gruesas, cristaloides), hemocultivos y antibióticos EV de amplio espectro (ampicilina + gentamicina + metronidazol, o clindamicina + gentamicina).
- Evacuar el útero (AMEU o legrado suave) con el antibiótico ya circulando; histerectomía solo si no responde o hay necrosis/perforación. Rh(–): anti-D.
- Rige el secreto profesional: la atención no se condiciona a confesión ni denuncia. La Ley 21.030 despenaliza la interrupción solo en 3 causales (riesgo vital, inviabilidad fetal letal, violación hasta 12 semanas o 14 si es menor de 14 años).
- Seguimiento: derivar a ginecología; ofrecer consejería y anticoncepción posaborto.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 24 años, con 10 semanas de amenorrea, consulta en urgencia por metrorragia abundante, fiebre de 38,9 °C y dolor hipogástrico. Reconoce haberse introducido comprimidos de misoprostol comprados por internet hace 3 días. PA 95/60 mmHg, FC 112 lpm. Útero sensible, flujo de mal olor por el orificio cervical abierto. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Dar de alta con misoprostol adicional para completar el aborto
B) Denunciar a Fiscalía y diferir el tratamiento hasta su declaración
C) Hospitalizar, iniciar antibióticos endovenosos de amplio espectro y evacuar el útero, resguardando el secreto profesional
D) Indicar antibióticos orales y control en 7 días
E) Realizar histerectomía de urgencia como primera medida

Respuesta C. Es un aborto séptico por un aborto provocado: hospitalizar, estabilizar, antibióticos endovenosos (por ejemplo clindamicina más gentamicina) y evacuación uterina. La atención no puede condicionarse a una confesión ni a una denuncia; rige el secreto profesional. La histerectomía queda para la falla del tratamiento.

3.01.2.002 Absceso glándula de Bartolino

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 20.10 Patología Vulvar y Glándula de Bartolino: Quiste vs Absceso de Bartolino y Liquen Escleroso

QUÉ HAY QUE SABER

- Absceso de Bartolino: masa fluctuante, eritematosa, caliente y muy dolorosa en el tercio posterior del labio mayor (a las 4 u 8), que impide sentarse o caminar.
- Diferencial con el quiste de Bartolino: masa indolora sin signos inflamatorios, que se observa si es asintomática.
- Tratamiento de elección: drenaje con marsupialización (sutura de la pared del quiste a la mucosa vestibular, orificio permanente) o catéter de Word por 4 semanas.
- La punción o incisión simple recidiva en >80%: no usarla como tratamiento definitivo. Antibióticos (amoxicilina-clavulánico o cefalosporina + metronidazol) si hay celulitis extensa, inmunosupresión o ITS.
- Tomar cultivo (gonococo, Chlamydia, E. coli) y descartar ITS. En >40 años con masa recurrente o sólida, biopsiar (carcinoma de glándula de Bartolino).
- Seguimiento completo: control a la semana y vigilar recurrencias; baños de asiento y analgesia.

PREGUNTAS (5)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 168

Mujer de 30 años, con actividad sexual, consulta por dolor vulvar y sensación febril. Al examen físico se aprecia un aumento de volumen eritematoso, de 6 centímetros de diámetro, doloroso, en relación a la zona posterior del labio mayor derecho. **¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada?**

A) Cistectomía de Bartolino
B) Drenaje por punción
C) Drenaje quirúrgico simple
D) Iniciar antibióticos orales y esperar el drenaje espontáneo
E) Bartholinocistostomía

Respuesta E. Absceso de Bartolino de 6 cm: la conducta recomendada es la marsupialización (bartholinocistostomía), que drena la colección y crea un orificio permanente, con menor tasa de recidiva que la punción o el drenaje simple.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 111

Mujer de 35 años, con antecedente de tres abscesos de Bartolino que han requerido drenaje quirúrgico, consulta por dolor vulvar de dos días. Al examen se observa un aumento de volumen de 3 centímetros en el labio menor derecho, a tensión, doloroso, sin signos inflamatorios. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Bartholinocistoneostomía
B) Evacuación por punción
C) Vaciamiento por incisión
D) Antibióticos orales
E) Baños de asiento y analgésicos

Respuesta A. Recidiva de absceso de Bartolino tras varios drenajes previos: la conducta es la marsupialización (bartholinocistoneostomía), que crea un trayecto de drenaje definitivo y evita una cuarta recidiva.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 148 · texto original del banco, sin revisar

Mujer de 20 años tras parto vaginal con episiotomía presenta aumento de volumen doloroso, azulado y fluctuante en el labio mayor derecho de 48 horas de evolución. Sin fiebre. ¿Cuál es el diagnóstico y manejo más adecuado?

A) Hematoma vulvar: compresas frías y analgesia si no aumenta
B) Absceso vulvar: drenaje + antibióticos
C) Quiste de Bartolino: observación ambulatoria
D) Linfocele: punción aspirativa
E) Tromboflebitis pélvica: anticoagulación

Respuesta B. Absceso vulvar/hematoma infectado post-parto: aumento de volumen azulado + fluctuante + doloroso a las 48h del parto = hematoma infectado o absceso. Requiere drenaje quirúrgico + antibióticos (amoxicilina-clavulánico). El hematoma no infectado (<24h, sin fiebre) se maneja con compresas frías.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 141 · texto original del banco, sin revisar

Una mujer de 41 años consulta por dolor en la zona vulvar derecha, de dos días de evolución. Al examen físico se observa aumento de volumen eritematoso y muy doloroso a la palpación, de ubicación posterolateral en relación al labio mayor derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Forunculosis vulvar
B) Celuli2s vulvar
C) Absceso de Bartolino
D) Absceso perianal
E) Quiste epidermoide vulvar infectado

Respuesta C. La alternativa correcta es la C (Absceso de Bartolino). Es un absceso de Bartholino clásico.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 119 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 32 años presenta aumento de volumen doloroso en la zona vulvar derecha. Al examen físico se observa aumento de volumen de 3 cm de diámetro, eritematoso y doloroso a la palpación, en relación con el tercio posterior del labio mayor derecho. Refiere haber tenido un episodio previo que requirió drenaje quirúrgico. Además del tratamiento quirúrgico para la lesión actual, ¿qué antibiótico debe administrarse?

A) Metronidazol oral
B) Ciprofloxacino oral
C) Amoxicilina + ácido clavulánico oral
D) Azitromicina oral
E) Trimetoprim-sulfametoxazol

Respuesta C. Aunque no queda clara la utilidad de los antibióticos en el absceso de Bartholino, los esquemas más utilizados son 1. amoxicilina + ácido calvulánico o 2. Cefadroxilo + metronidazol. Suelen indicarse en los casos con infección severa y en las recurrencias. El tratamiento quirúrgico está indicado en los abscesos menores de 3 cm, con incisión simple. En cambio, en las recurrencias o lesiones de más

3.01.2.003 Crisis hipertensiva del embarazo

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 19.6 Emergencias Hipertensivas en el Embarazo: Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome HELLP y Sulfato de Magnesio

QUÉ HAY QUE SABER

- Crisis hipertensiva del embarazo: PA ≥160/110 mmHg confirmada en 15 minutos; es criterio de severidad y emergencia por riesgo de ACV materno.
- Evaluar síntomas de severidad: cefalea, escotomas, epigastralgia, convulsiones; exámenes: hemograma, plaquetas, transaminasas, LDH, creatinina, proteinuria; bienestar fetal.
- Tratamiento: labetalol EV en bolos (20 mg, luego 40–80 mg cada 10–20 min, máx. 220–300 mg) o nifedipino oral 10 mg; hidralazina EV 5 mg si hay asma o bradicardia.
- Meta: 140–150/90–100 mmHg; no bajar bruscamente (hipoperfusión placentaria). IECA/ARA-II contraindicados.
- Sulfato de magnesio para prevenir eclampsia (carga 4–5 g EV en 20 min, mantención 1–2 g/h); corticoides si <34 semanas.
- Seguimiento: derivar a alto riesgo obstétrico/hospitalizar para interrupción una vez estabilizada la madre.

PREGUNTAS (6)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 45

Paciente de 32 años, primigesta, cursando un embarazo de 33 semanas, presenta presión arterial de 162/113 mmHg en el control. Se encuentra asintomática y los latidos cardiofetales se auscultan normales. **¿Cuál es el fármaco más adecuado para iniciar el tratamiento?**

A) Enalapril
B) Sulfato de magnesio
C) Metildopa
D) Labetalol
E) Hidralazina

Respuesta D. PA de 160/110 mmHg o más es una crisis hipertensiva del embarazo: se trata con labetalol endovenoso (hidralazina si está contraindicado). Metildopa es de mantención, enalapril está contraindicado y el magnesio previene convulsiones pero no baja la presión.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 115 · texto original del banco, sin revisar

Embarazada de 36 semanas con presión arterial 170/110 y cefalea frontal intensa que no cede con analgesia. Sin convulsiones. ¿Cuál es el manejo más adecuado?

A) Hospitalizar, labetalol EV para control de PA, sulfato de magnesio profiláctico e interrupción del embarazo
B) Nifedipino oral y control ambulatorio
C) Sulfato de magnesio solo
D) Inducción con oxitocina inmediata sin otro manejo
E) Hidralazina oral y observar

Respuesta A. Preeclampsia severa a ≥34 semanas: hospitalización + control de PA (labetalol o hidralazina EV) + sulfato de magnesio para prevenir eclampsia + interrupción del embarazo una vez estabilizada.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 109 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 31 años con 28 semanas de gestación y antecedente de asma severo, presenta un cuadro de cefalea intensa asociada a tinitus. Al examen físico se constata presión arterial de 160/110 mmHg. El registro fetal muestra una frecuencia cardíaca de 135 latidos por minuto. No tiene focalidad neurológica. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada para esta paciente?

A) Administrar labetalol endovenoso
B) Administrar nifedipino oral
C) Administrar sulfato de magnesio endovenoso
D) Solicitar TAC de cerebro
E) Administrar misoprostol intrarrectal

Respuesta B. Manejo de Crisis Hipertensiva en el Embarazo: La paciente presenta una crisis hipertensiva del embarazo. El tratamiento habitual en estos casos es con labetalol intravenoso. Sin embargo, en esta paciente en particular, el uso de betabloqueadores está absolutamente contraindicado debido a su historial de asma severo. La alternativa de tratamiento en este caso es el nifedipino, que generalmente se a

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 54 · texto original del banco, sin revisar

Embarazada sobre 20 semanas con cefalea, fotopsias y presión 160/110 mmHg. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?

A) Nifedipino 10 mg sublingual
B) Hidralazina 5 mg EV
C) Sulfato de magnesio 4 g EV
D) Labetalol 20 mg EV
E) Metildopa 500 mg oral

Respuesta D. Conducta / Tratamiento indicado: Labetalol 20 mg EV (opción D). Labetalol 20 mg EV. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 163 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 27 años, cursando 36 semanas de embarazo, consulta por malestar general, asociada a cefalea, tinitus y epigastralgia. Su presión arterial es 170/100 mmHg y presenta reflejos osteotendíneos exaltados. Su tacto vaginal no muestra cambios cervicales y su registro cardiaco fetal no tiene alteraciones. ¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?

A) Administrar labetalol
B) Iniciar alfametildopa
C) Administrar sulfato de magnesio 5 gramos endovenoso y luego 2 gramos cada hora
D) Solicitar un test de tolerancia a las contracciones
E) Realizar cesárea de urgencia

Respuesta C. E? Es una pésima pregunta. Todo el mundo sabe que una preclamsia grave, con probable HELLP y exaltación neurológica, se debe interrumpir o si no, se muere (es lo más importante). Además todos sabemos que primero se administra el sulfato de magnesio, mientras se prepara el pabellón para la cesárea. Como se pregunta la conducta inmediata, probablemente quien redactó esta pregunta quiere que se marqu

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 140 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 38 años, cursando embarazo de 36 semanas, consulta por cuadro de una hora de evolución caracterizado por epigastralgia asociada a cefalea, sin otros síntomas. En el examen físico presenta dolor a la palpación de hipocondrio derecho, asociado a exaltación de los reflejos osteotendíneos. Al tacto vaginal se palpa cuello duro y posterior. Se auscultan latidos cardiofetales con variabilidad francamente disminuida. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Realizar cesárea de urgencia
B) Inducir con oxitocina
C) Inducir con misoprostol
D) Lateralizar a izquierda
E) Hospitalizar y esperar a las 37 semanas para realizar interrupción

Respuesta A. Tiene una preclamsia grave, con exaltación neurológica y un HELLP. Hay que interrumpir. Eso sí también hay que dar MgSO4. Si se preguntara lo primero que hay que hacer: sulfato de magnesio. Si se pregunta el tratamiento: interrupción inmediata.

3.01.2.004 Eclampsia

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 19.6 Emergencias Hipertensivas en el Embarazo: Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome HELLP y Sulfato de Magnesio

QUÉ HAY QUE SABER

- Eclampsia: convulsión tónico-clónica generalizada en embarazada con preeclampsia (o hasta semanas posparto) sin otra causa neurológica; la hemorragia cerebral es su principal causa de muerte.
- Primera medida (tras ABC, decúbito lateral, oxígeno, vía aérea): sulfato de magnesio, aun con antecedente de epilepsia o PA ya controlada; es superior a benzodiacepinas.
- Esquema de Zuspan: carga 4–5 g EV en 20 min y mantención 1–2 g/h hasta 24 h posparto; si convulsiona de nuevo, bolo adicional de 2 g.
- Vigilar cada hora reflejo rotuliano, frecuencia respiratoria (>12) y diuresis (>30 mL/h); toxicidad (arreflexia, depresión respiratoria) → suspender y gluconato de calcio 1 g EV.
- Luego controlar la presión (labetalol o hidralazina EV, meta 140–150/90–100) e interrumpir el embarazo una vez estabilizada, sin esperar madurez fetal.
- Seguimiento: derivar a UCI/alto riesgo obstétrico; neuroimagen si hay déficit focal o convulsión atípica.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 40

Mujer embarazada de 34 semanas es encontrada convulsionando en la calle. Previamente tenía presión arterial de 165/110 mmHg. Al llegar a urgencias persiste con crisis convulsiva. **¿Cuál es el tratamiento de elección?**

A) Fenitoína IV
B) Sulfato de magnesio IV
C) Diazepam IV
D) Nifedipino sublingual
E) Labetalol IV

Respuesta B. Convulsión en una embarazada con presión elevada: eclampsia. El anticonvulsivante de elección es el sulfato de magnesio, no las benzodiacepinas ni la fenitoína. Luego se controla la presión y se evalúa la interrupción del embarazo.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 48

Primigesta de 32 semanas con cefalea intensa y presión de 170/110 mmHg, se administra labetalol endovenoso, logrando 140/90 mmHg. Dos horas después presenta una convulsión tónico-clónica de 2 minutos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Administrar lorazepam endovenoso
B) Administrar labetalol endovenoso
C) Administrar sulfato de magnesio endovenoso
D) Administrar tocolíticos endovenosos
E) Realizar maduración pulmonar

Respuesta C. Aunque la presión ya esté controlada, la convulsión define eclampsia y exige sulfato de magnesio. Haber tratado bien la presión antes no reemplaza este paso: son dos problemas distintos que se tratan por separado.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 144 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 25 años, cursando con embarazo de 30 semanas, con antecedente de epilepsia hace 1 año, presenta crisis convulsivas tónico-clónicas, desde hace una hora. Al examen físico se aprecia edema de extremidades inferiores, FC: 87x' y PA: 160/100 mmHg. La ecografía obstétrica muestra feto vivo. ¿Cuál es la primera medida?

A) Administrar nifedipino
B) Administrar fenobarbital
C) Administrar diazepam
D) Administrar sulfato de magnesio
E) Administrar misoprostol

Respuesta D. Aunque haya teido antecedente de epilepsia, el diagnóstico ahora es una eclam- sia, que en primer lugar recibe MgSO4.

3.01.2.005 Embarazo ectópico complicado

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **No requiere**

Dónde se enseña: Tema 19.11 Embarazo Ectópico: Localizaciones, Diagnóstico con β-hCG Cuantitativa, Manejo Médico (Metotrexato) vs Quirúrgico

QUÉ HAY QUE SABER

- Ectópico roto: dolor abdominal súbito e intenso, signos peritoneales, omalgia (sangre irrita el diafragma), hipotensión y taquicardia en mujer con atraso menstrual o test positivo.
- Ecografía (si no retrasa el manejo): útero vacío, masa anexial y líquido libre abundante en el Douglas; culdocentesis con sangre incoagulable es clásica.
- Manejo inicial: ABC, dos vías venosas gruesas, cristaloides, clasificación y pruebas cruzadas, hemoderivados si es necesario.
- Cirugía de urgencia sin esperar exámenes: laparoscopía si está estable o laparotomía si está inestable, habitualmente salpingectomía.
- Ectópico intersticial: se rompe más tarde con hemorragia masiva. Rh(–): inmunoglobulina anti-D.
- Seguimiento: no requiere controles específicos tras la salpingectomía; consejería sobre riesgo de recurrencia en embarazos futuros (ecografía precoz).

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 62

Mujer joven con dolor súbito en FID, hipotensión y taquicardia súbitas, dolor en ambas fosas ilíacas. **¿Diagnóstico más probable?**

A) Apendicitis aguda complicada
B) Quiste ovárico torcido
C) Embarazo ectópico roto
D) Salpingitis aguda con absceso tubo-ovárico
E) Rotura folicular hemorrágica

Respuesta C. Mujer joven con dolor en ambas fosas ilíacas e hipotensión y taquicardia súbitas: es la presentación de un embarazo ectópico roto, con hemoperitoneo. El dolor bilateral y el colapso hemodinámico brusco no son típicos de una apendicitis, que suele doler solo a la derecha y no da shock tan súbito.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 62

Mujer joven con dolor súbito en la fosa ilíaca derecha, hipotensión y taquicardia súbitas, con dolor en ambas fosas ilíacas. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Apendicitis aguda complicada
B) Quiste ovárico torcido
C) Embarazo ectópico roto
D) Salpingitis aguda con absceso tubo-ovárico
E) Rotura folicular hemorrágica

Respuesta C. Dolor súbito con hipotensión y taquicardia súbitas en una mujer joven es el cuadro clásico de hemoperitoneo por rotura tubárica: embarazo ectópico roto.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 176 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 24 años consulta por atraso menstrual de 7 semanas. Se realiza HCG, que resulta 5.000 UI/L, por lo que se hace ecografía transvaginal, que muestra au- sencia de gestación intrauterina y abundante líquido libre peritoneal. ¿Cuál es la con- ducta más adecuada?

A) Realizar curva de HCG
B) Controlar con ecografía transvaginal en 7 días
C) Realizar laparoscopía
D) Administrar metotrexato
E) Mantener el control normal del embarazo

Respuesta C. Es un embarazo ectópico y por tener líquido libre y también más de 3.000 de HCG, es de tratamiento quirúrgico.

3.01.2.006 Endometritis puerperal

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 19.19 Infecciones Puerperales: Endometritis Puerperal y Patología Mamaria (Mastitis Congestiva vs Infecciosa vs Absceso)

QUÉ HAY QUE SABER

- Causa más frecuente de fiebre puerperal; aparece al 2.º–4.º día con fiebre y calofríos, útero blando, subinvolucionado y doloroso, loquios turbios y de mal olor.
- Factor de riesgo mayor: cesárea, sobre todo de urgencia; también RPM prolongada, corioamnionitis, tactos repetidos, retención de restos y parto prolongado.
- Diferencial de fiebre puerperal: ITU/pielonefritis, infección de herida, mastitis (más tardía), tromboflebitis pélvica séptica (fiebre persistente pese a antibióticos).
- Manejo inicial: hospitalizar siempre, hemocultivos, y clindamicina 600–900 mg c/8 h + gentamicina 5 mg/kg/día EV hasta 48 h afebril; no requiere completar antibióticos orales.
- Ecografía si se sospechan restos (legrado) o absceso; fiebre que no cede en 48–72 h obliga a buscar absceso o tromboflebitis séptica.
- Seguimiento: derivar a ginecobstetricia (manejo hospitalario); se puede mantener la lactancia.

PREGUNTAS (5)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 174

Puérpera hace 7 días, con antecedente de hemorragia puerperal, evoluciona con aumento de la metrorragia, fiebre hasta 38,5 grados y dolor abdominal bajo. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Inercia uterina
B) Neoplasia trofoblástica gestacional
C) Endometritis
D) Restos ovulares
E) Miometritis

Respuesta C. Fiebre, dolor abdominal bajo y aumento del sangrado en el puerperio es el cuadro clásico de endometritis puerperal, con o sin restos asociados.

Pregunta de práctica

Puérpera de tres días, tras una cesárea de urgencia por rotura de membranas prolongada, con fiebre de 38,7 grados, dolor abdominal bajo y útero doloroso, subinvolucionado, con loquios achocolatados y de mal olor. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Manejo ambulatorio con amoxicilina oral
B) Hospitalizar e iniciar clindamicina más gentamicina endovenosas
C) Indicar ciprofloxacino oral en el domicilio
D) Suspender la lactancia mientras se estudia
E) Solicitar ecografía mamaria antes de decidir

Respuesta B. Fiebre, dolor uterino, útero subinvolucionado y loquios fétidos tras una cesárea: endometritis puerperal. Se hospitaliza siempre, con clindamicina más gentamicina endovenosas hasta 48 horas afebril.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 151 · texto original del banco, sin revisar

Una mujer de 25 años, puérpera de 5 días, con parto vaginal, consulta por de aumento de la cantidad de loquios hemáticos y sensación febril. Al examen físico tiene FC: 80x', PA: 110/70 mmHg, examen genital con episiorrafia equimótica y dolor a la palpación uterina. El diagnóstico más probable es:

A) Restos placentarios
B) Neoplasia trofoblástica gestacional
C) Infección de la epifisiorrafia
D) Miometritis puerperal
E) Endometritis puerperal

Respuesta E. Tiene una endometritis clásica: fiebre, dolor uterino, loquios de mal olor. También puede tener metrorragia. Los restos placentarios solo producen metrorragia tardía, sin dolor ni fiebre (generalmente entre el día 2 y día 4). La NTG suele producir metrorragia tardía, varios días o semanas postparto. La epifisiorrafia equimótica es normal.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 171 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 26 años, puérpera de 5 días, presenta fiebre, malestar general y loquios de mal olor. Al examen físico tiene dolor a la palpación y se solicita una PCR, que resulta 9,2 mg/L. Se inicia tratamiento antibiótico con penicilina sódica y gentamicina, sin embargo, dos días después, continúa febril, con dolor y PCR 8,8 mg/L. El agente más probable es:

A) Proteus mirabilis
B) Escherichia coli
C) Bacteroides fragilis
D) Estreptococo betahemolítico grupo B
E) Chlamydia trachomatis

Respuesta C. Por no haber respondido, lo más probable es que sea un anaerobio (por eso se deja penicilina + gentamicina + clindamicina). Las demás opciones estaban cubiertas con el esquema indicado.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 152 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 32 años, cursando puerperio desde hace 8 días, con parto por cesárea, comienza con loquios abundantes y de mal olor, asociada a fiebre. Su examen físico muestra T°: 38,5°C FC: 85x´. PA: 120/80x', herida operatoria sin signos de infección y útero doloroso a la palpación. La conducta más adecuada es:

A) Iniciar ntibióticos orales
B) Realizar legrado
C) Hospitalizar y manejar con antibióticos endovenosos
D) Realizar histerectomía
E) Administrar una dosis de antibióticos endovenosos y luego manejo ambulatorio con

Respuesta C. Conducta / Tratamiento indicado: Hospitalizar y manejar con antibióticos endovenosos (opción C). Nuevamente es una endometritis, que se trata con antibióticos endovenosos de amplio espectro.. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

3.01.2.007 Hiperemesis gravídica

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **No requiere**

Dónde se enseña: ob-21

QUÉ HAY QUE SABER

- Hiperemesis gravídica: vómitos persistentes del 1.er trimestre con baja de peso >5% del peso previo, deshidratación, cetonuria y alteraciones hidroelectrolíticas.
- Factores: hCG elevada (embarazo múltiple, mola), primigesta, antecedente previo. Descartar mola y gemelar con ecografía, e ITU, gastroenteritis, pancreatitis, hepatitis y hipertiroidismo.
- Exámenes: electrolitos (hipokalemia, alcalosis hipoclorémica), función renal, pruebas hepáticas, TSH/T4L (hipertiroidismo transitorio por hCG), orina completa con cetonuria.
- Tratamiento: hospitalizar si hay deshidratación o intolerancia oral; régimen cero inicial, hidratación EV con suero fisiológico y reposición de potasio; tiamina 100 mg antes de aportar glucosa (prevenir Wernicke).
- Antieméticos: doxilamina-piridoxina, metoclopramida 10 mg EV c/8 h, ondansetrón 4–8 mg (2.ª línea); realimentación oral fraccionada progresiva al ceder los vómitos.
- Seguimiento: no requiere derivación de rutina; manejo en control prenatal habitual una vez resuelto.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 177

Paciente de 18 años, cursando un embarazo de 11 semanas, presenta vómitos frecuentes desde el inicio del embarazo, que han ido en aumento. En las últimas 24 horas ha empeorado al punto de no poder ingerir líquidos adecuadamente, por lo que acude al servicio de urgencia. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Gastroparesia gestacional
B) Cólico biliar
C) Hepatitis
D) Hiperemesis gravídica
E) Síndrome de HELLP

Respuesta D. Vómitos persistentes del primer trimestre que impiden la ingesta y llevan a deshidratación definen la hiperemesis gravídica. Se maneja con hospitalización, hidratación endovenosa, reposición de electrolitos, tiamina y antieméticos. El HELLP aparece en la segunda mitad del embarazo con hipertensión, hemólisis y trombocitopenia.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 179 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 24 años, primigesta de 12 semanas, consulta porque presenta náuseas y vómitos que afectan significativamente su calidad vida. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es más adecuado para el manejo inicial de esta paciente?

A) Corticoides orales
B) Omeprazol oral
C) Doxilamina más piridoxina oral
D) metoclopramida oral
E) Ondasentrón oral

Respuesta C. Conducta / Tratamiento indicado: Doxilamina más piridoxina oral (opción C). Tratamiento Escalonado De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad. Las opciones alternativas (Corticoides orales, Omeprazol oral) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 56 · texto original del banco, sin revisar

Embarazada con náuseas y vómitos importantes que impactan su calidad de vida. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Metoclopramida oral
B) Ondansetrón endovenoso
C) Dieta fraccionada y observación
D) Dimenhidrinato oral
E) Doxilamina y piridoxina

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Doxilamina y piridoxina (opción E). Doxilamina y piridoxina. Tratamiento Escalonado De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 178 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 24 años, cursando un embarazo de 10 semanas, presenta vómitos frecuentes, que iniciaron hace un mes y han ido en aumento. Además ha bajado 3 kilogramos de peso, desde que se embarazó, ya que muchos de los alimentos y olores le producen muchas náuseas y vómitos. Refiere que vomita cerca de 6 veces al día y que esto afecta claramente su calidad de vida. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Doxilamina
B) Clorpromazina
C) Omeprazol
D) Metoclopramida
E) Ondasentrón sublingual

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Doxilamina (opción A). La doxilamina (antihistamínico) son el tratamiento de primera línea en la hiperemesis gravídica.. Tratamiento Escalonado De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

3.01.2.008 Hemorragia genital aguda (metrorragia disfuncional-cervicorragia por Cáncer C.U.)

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **No requiere**

Dónde se enseña: Tema 20.3 Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo · Tema 19.18 Hemorragia Postparto Inmediata (HPI), Código Rojo, Regla de las 4T y Algoritmo Terapéutico Escalonado

QUÉ HAY QUE SABER

- Hemorragia uterina aguda severa: estabilizar primero (ABC, dos vías gruesas, cristaloides, hemograma, grupo y Rh, coagulación, beta-hCG); transfundir si hay inestabilidad o anemia severa.
- Metrorragia disfuncional (anovulatoria) en adolescente o perimenopáusica: estrógenos conjugados EV en dosis altas o ACO en esquema escalonado, más ácido tranexámico 1 g c/6–8 h.
- En la adolescente con hipermenorrea importante, descartar coagulopatía (von Willebrand); en ≥45 años, biopsia endometrial antes de terapia hormonal prolongada.
- Si no cede o hay inestabilidad: legrado uterino hemostático (además diagnóstico) o sonda Foley intrauterina como taponamiento.
- Cervicorragia por cáncer cervicouterino: taponaje vaginal compresivo con gasa (± agentes hemostáticos), reposición de volumen y derivación urgente para radioterapia hemostática.
- Seguimiento: una vez controlada, no requiere seguimiento especializado por el sangrado agudo; estudiar la causa de base y derivar según hallazgo.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 122

Mujer de 55 años postmenopáusica con miomas uterinos conocidos. Llega a urgencias por metrorragia severa, con presión arterial de 90/60 mmHg y frecuencia cardíaca de 118 por minuto. **¿Cuál es el manejo inmediato?**

A) Estabilización hemodinámica más histerectomía de urgencia
B) Ácido tranexámico endovenoso y observar
C) Progestágenos endovenosos en dosis alta
D) Embolización uterina electiva
E) Solo transfusión de glóbulos rojos y alta

Respuesta A. Sangrado uterino masivo con inestabilidad hemodinámica manifiesta: la prioridad es la estabilización con volumen y transfusión, seguida de histerectomía de urgencia como manejo definitivo, sin tiempo para escalar tratamientos médicos.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 124

Una paciente, cursando embarazo de término, inicia contracciones uterinas intensas. Al examen obstétrico se palpan tres contracciones cada 10 minutos y dilatación cervical de 5 centímetros. Al romper las membranas, se produce metrorragia moderada, seguida de bradicardia fetal. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Rotura uterina
B) Desprendimiento de placenta normoinserta
C) Placenta previa
D) Rotura de vasa previa
E) Procidencia de cordón umbilical

Respuesta D. Metrorragia inmediatamente después de romper membranas, seguida de bradicardia fetal, sin dolor ni compromiso materno: rotura de vasa previa. La rotura uterina tiene dolor y cesación de contracciones; el DPPNI tiene hipertonía; la placenta previa no sangra recién al romper membranas.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 144

Paciente de 24 años con metrorragia importante en el puerperio inmediato, con flujo abundante de sangre roja. El fondo uterino se palpa por sobre el ombligo. **¿Cuál es la medida inicial más adecuada?**

A) Metilergonovina
B) Misoprostol
C) Masaje uterino
D) Carbetocina
E) Oxitocina

Respuesta C. Ante una hemorragia postparto por atonía, el primer paso siempre es el masaje uterino bimanual, y en paralelo se inician los uterotónicos, empezando por la oxitocina.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 99 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 47 años, cuya FUR fue hace 55 días, presenta metrorragia de 10 días de evolución, abundante. Se solicita hemograma, que muestra hematocrito: 7,4 g/dl, blancos: 7.000. La conducta más adecuada es:

A) Realizar legrado uterino
B) Administrar progestágenos orales
C) Administrar estrógenos orales
D) Realizar histerectomía
E) Administrar estrógenos endovenosos

Respuesta A. Tiene una metrorragia grave, anemizante. Por ello, se debe legrar para detener la hemorragia. Lo mismo aplica a las metrorragias graves, asociadas a compromiso hemodinámico. Los estrógenos sí se usan en las metrorragias disfuncionales, pero si es que no tienen ni anemia severa ni compromiso hemodinámico.

3.01.2.009 Mastitis puerperal

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **No requiere**

Dónde se enseña: Tema 19.19 Infecciones Puerperales: Endometritis Puerperal y Patología Mamaria (Mastitis Congestiva vs Infecciosa vs Absceso)

QUÉ HAY QUE SABER

- Mastitis puerperal: placa eritematosa, dolorosa y caliente unilateral, con fiebre alta, calofríos y malestar general, habitualmente en la 2.ª–4.ª semana posparto.
- Diferencial con congestión mamaria: bilateral, primeros días, mamas duras sin fiebre importante; se maneja con vaciamiento, calor y lactancia a libre demanda, sin antibióticos.
- Agente principal: Staphylococcus aureus, por grietas del pezón y vaciamiento incompleto.
- Tratamiento: cloxacilina 500 mg c/6 h VO por 10–14 días (alternativa cefadroxilo; alergia: clindamicina), AINE o paracetamol, frío local tras amamantar.
- Nunca suspender la lactancia: el vaciamiento frecuente (empezando por la mama sana si hay mucho dolor) previene el absceso; corregir acople.
- Si no responde en 48–72 h o aparece masa fluctuante: ecografía para descartar absceso. Seguimiento: no requiere derivación.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 176

Puérpera de 15 días, en lactancia materna, con dolor en la mama derecha de 3 días de evolución, eritema y malestar general. La mama derecha tiene los cuadrantes superiores dolorosos, indurados, con aumento de temperatura local y eritema. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar drenaje mamario quirúrgico
B) Suspender la lactancia materna
C) Iniciar antibióticos
D) Indicar analgésicos
E) Aplicar frío y luego calor local, alternadamente

Respuesta C. Mastitis puerperal sin fluctuación: se trata con antibióticos orales con cobertura de estafilococo. No hay indicación de drenaje ni de suspender la lactancia; al contrario, se debe mejorar la técnica de amamantamiento.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 153 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 24 años, puérpera de 15 días, presencta dolor en la mama derecha, asociada a eritema, aumento de la temperatura local y fiebre hasta 38,8°C. Al examen físico se aprecia mama derecha eritematosa y congestiva, dolorosa a la palpación, sin zonas fluctuantes. ¿Cuál es el manejo más adecuado?

A) Antiinflamatorios
B) Compresión con frío local
C) Suspender la lactancia materna
D) Drenaje mamario
E) Antibióticos orales

Respuesta E. Tiene una mastitis aguda, que se trata con antibióticos, generalmente endovenosos, aunque si está bien se puede tratar con antibióticos orales (generalmente amoxicilina con ácido clavulánico, aunque también se pueden dar otros fármacos que cubran S. aureus).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 170 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 30 años, púerpera de 28 días, en lactancia materna, consulta por dolor en la mama derecha, asociado a fiebre hasta 38,5°C. Al examen tiene aumento de volumen y eritema zona superior derecha de la mama, con aumento de volumen palpable, de consistencia aumentada y dolorosa, de 4 cm de diámetro, no fluctuante ni renicente (una palabra inventada por quien hizo esa pregunta), ubicado en el cuadrante superoexterno de dicha mama. El diagnóstico más probable es:

A) Congestión mamaria
B) Flegmón mamario
C) Absceso mamario derecho
D) Mastitis derecha
E) Cáncer inflamatorio de mama

Respuesta B. Por no ser fluctuante, parece un flegmón mamario. Aunque en estricto rigor igual es una mastitis. Sin embargo, se hacía mucho hincapié en la lesión no fluctuante, por lo que dejaremos flegmón como respuesta correcta. Es una mala pregunta.

3.01.2.010 Metrorragia: Desprendimiento previo de placenta normoinserta (DPPNI)

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **No requiere**

Dónde se enseña: Tema 19.13 Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospecha clínica: metrorragia de sangre oscura (a veces escasa u oculta) con dolor abdominal intenso, útero leñoso (hipertonía) y contracciones seguidas, con sufrimiento fetal precoz.
- Factores de riesgo: síndrome hipertensivo del embarazo (la causa más frecuente), trauma abdominal, cocaína, tabaco, RPM, sobredistensión uterina, DPPNI previo.
- El diagnóstico es clínico: la ecografía solo muestra el hematoma retroplacentario en la mitad de los casos, por lo que una ecografía normal no lo descarta.
- Manejo inicial: ABC, dos vías gruesas, cristaloides, hemograma, pruebas de coagulación y fibrinógeno, sangre disponible; monitoreo fetal.
- Feto vivo: cesárea de urgencia inmediata; feto muerto con madre estable: parto vaginal (amniotomía + oxitocina). Rh(–): anti-D.
- Complicaciones: CID (por tromboplastina), útero de Couvelaire con atonía y hemorragia posparto, shock hipovolémico, insuficiencia renal. Seguimiento: no requiere (resolución hospitalaria).

PREGUNTAS (5)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 49

Una paciente de 33 años, cursando un embarazo de 36 semanas, consulta por contracciones uterinas dolorosas y metrorragia. Al examen se palpa un útero con tono aumentado y tres contracciones uterinas en 10 minutos. La especuloscopía muestra sangre roja oscura en cantidad moderada, sin dilatación cervical. Los latidos cardiofetales se auscultan a 130 por minuto. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar cesárea de urgencia
B) Realizar maduración pulmonar y conducta expectante
C) Inducir el trabajo de parto con misoprostol
D) Solicitar Doppler fetal
E) Administrar tocolíticos endovenosos

Respuesta A. Dolor, hipertonía y sangre oscura son un DPPNI. Sin dilatación cervical, la vía más expedita para interrumpir de inmediato es la cesárea de urgencia.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 7 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 30 años, con embarazo de 35 semanas controlado, consulta al servicio de urgencias por metrorragia escasa asociada a dolor abdominal. Al examen físico destaca aumento marcado del tono uterino de forma permanente y frecuencia cardiaca fetal de 110 por minuto. El diagnóstico más probable es:

A) Placenta previa
B) Rotura uterina
C) Rotura de vasa previa
D) Síntomas de parto prematuro
E) Desprendimiento de placenta

Respuesta E. Diagnóstico: Desprendimiento de placenta (opción E). Metrorragia más dolor e hipertonía uterina. Además FCF en límite bajo.. Metrorragia del tercer trimestre acompañada de dolor abdominal súbito y marcada hipertonía uterina ("útero leñoso o en tabla") con sufrimiento fetal agudo es la tríada clásica de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta (DPPNI), una urgencia obstétrica que exige in

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 166 · texto original del banco, sin revisar

paciente de 28 años de edad, con 34 semanas de gestación consulta por metrorragia moderada. Al examen físico tiene presión arterial: 130/70 mmHG y FC: 107x', útero doloroso e hipertónico y metrorragia escasa en la especuloscopía. Se realiza ecografía obstétrica que resulta normal, con placenta posterior, sin signos de desprendimiento. El doppler maternofetal resulta normal normal y el cuello tiene 30 mm de longitud. La conducta mas adecuada con la paciente es:

A) Administrar nifedipino
B) Inducción de parto
C) Repetir el doppler fetal en 7 días
D) Realizar rotura de membranas
E) Realizar cesárea

Respuesta E. Aunque la ecografía no lo vea, el diagnóstico clínico es un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, que requiere de interrupción por la vía más expedita: en este caso cesárea, por no estar en trabajo de parto avanzado.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 96 · texto original del banco, sin revisar

DPPNI (útero tónico, sangrado escaso) 32 sem aprox, se evidencia en eco leve desprendimiento de placenta. Cuál es la conducta:

A) Cesarea
B) Interrumpir 34 sem
C) Dar corticoides e interrumpir en 48 hrs, era un DPPNI leve, sin sufrimiento fetal, no creo que sea cesárea de urg más considerando que tiene <34
D) Interrupción del embarazo
E) Maduración pulmonar y observación

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Cesarea (opción A). La resolución quirúrgica urgente constituye la única medida definitiva capaz de controlar el foco séptico, revertir la isquemia o evitar la muerte materna/fetal frente a este compromiso clínico severo.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 150 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 32 años, con 32 semanas de embarazo, acude al servicio de urgencia por contracciones uterinas dolorosas, asociada a metrorragia. Al examen físico se palpa aumento del tono uterino, se objetiva metrorragia escasa y contracciones uterinas hipertónicas a razón de 3/10 minutos. El cuello uterino no tiene modificaciones y los latidos cardiofetales se auscultan a 120 lpm. La conducta más adecuada es:

A) Interrumpir el embarazo de inmediato
B) Administrar corticoides intramusculares
C) Solicitar perfil biofísico
D) Solicitar Doppler materno-fetal
E) Administrar tocolíticos

Respuesta A. Tiene un DPPNI sintomático, por lo que se debe interrumpir por la vía más expedita, a pesar de que los LCF estén normales.

3.01.2.011 Metrorragia: placenta previa

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 19.13 Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospecha: metrorragia indolora, roja fresca, súbita, en la segunda mitad del embarazo, con útero blando y feto habitualmente en buen estado; asocia presentaciones anómalas.
- Regla de oro: no hacer tacto vaginal hasta conocer la ubicación de la placenta; diagnóstico con ecografía transvaginal (oclusiva o de inserción baja <2 cm del OCI).
- Factores de riesgo: cesárea anterior (el más importante), multiparidad, legrados previos, edad >35 años, tabaquismo, embarazo múltiple.
- Manejo inicial: hospitalizar si sangra, vías venosas, hemograma, grupo y Rh, reposo, corticoides si <34 semanas, anti-D si Rh(−); sangrado masivo o compromiso materno-fetal → cesárea de urgencia.
- Placenta previa oclusiva: cesárea electiva a las 36–37 semanas; nunca parto vaginal.
- Previa sobre cicatriz de cesárea: alto riesgo de acretismo; derivar a centro de alta complejidad para cesárea-histerectomía programada con placenta in situ. Seguimiento: derivar.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 40

Una paciente multípara, con un parto anterior por cesárea, cursando un nuevo embarazo de 35 semanas, consulta por metrorragia moderada. Al examen físico presenta una contracción uterina cada diez minutos y se realiza ecografía que visualiza una placenta posterior que sobrepasa en dos centímetros el orificio cervical. El ecodoppler materno-fetal es normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Administrar tocolíticos
B) Inducir el parto con misoprostol
C) Administrar corticoides para maduración pulmonar
D) Repetir la ecografía a las 37 semanas
E) Realizar cesárea

Respuesta E. Placenta que cubre el orificio cervical interno a esta edad gestacional es placenta previa oclusiva. Con 35 semanas cumplidas, el riesgo de prematurez ya es bajo, así que se interrumpe con cesárea sin esperar.

Pregunta de práctica

Embarazada de 34 semanas, con una cesárea anterior, consulta por sangrado vaginal rojo fresco y abundante, de inicio súbito hace 1 hora, sin dolor ni contracciones. Al examen: presión arterial 110/70 mmHg, afebril, abdomen blando e indoloro, sin dinámica uterina. El monitor fetal muestra latidos de 142 por minuto, reactivos. El interno se pone guantes para hacer un tacto vaginal. **¿Cuál es la conducta más adecuada en este momento?**

A) Realizar el tacto vaginal para evaluar la dilatación cervical
B) Detener el tacto vaginal y solicitar una ecografía transvaginal
C) Iniciar tocolíticos endovenosos de inmediato
D) Solicitar una tomografía computarizada de abdomen y pelvis
E) Indicar deambulación y dar el alta a control ambulatorio

Respuesta B. Sangrado indoloro, rojo fresco, con útero blando y feto reactivo: cuadro típico de placenta previa. Antes de cualquier tacto vaginal hay que conocer la posición de la placenta con ecografía transvaginal, que es segura y no la toca. El tacto puede desgarrarla y provocar una hemorragia exanguinante.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 54 · texto original del banco, sin revisar

Una mujer de 27 años, cursando un embarazo de 25 semanas, acude a control de su embarazo. Se solicita una ecografía obstétrica, que muestra feto creciendo en percentil 50, con líquido amniótico normal y sin alteraciones morfológicas, observándose que el borde inferior de la placenta se encuentra en contacto con el orificio cervical interno. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Inducir el parto
B) Realizar operación cesárea
C) Controlar con ecografía en el tercer trimestre
D) Administrar tocolíticos desde las 32 semanas
E) Solicitar Doppler de arterias uterinas

Respuesta C. Placenta previa: Se diagnostica con la ecografía, cuando la placenta cubre completamente el orificio cervical interno. El diagnóstico generalmente se realiza a las 32 semanas de gestación, ya que antes de esa edad gestacional es frecuente que la placenta se desplace hacia arriba, resolviendo la condición. Sin embargo, si la placenta previa persiste, contraindica absolutamente el parto vaginal y se

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 106 · texto original del banco, sin revisar

Mujer de 29 años, cursando embarazo de 33 semanas, consulta por presentar metrorragia escasa en una oportunidad no asociado a otros síntomas. Al examen físico no se aprecia sangre proveniente del orificio cervical externo, resto normal. Se realiza registro basal no estresante que resulta reactivo. El diagnóstico más probable en este caso es:

A) Rotura de vasa previa
B) Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta
C) Placenta previa
D) Rotura uterina
E) Sinusorragia

Respuesta C. Para mí es una salida del tapón mucoso (metrorragia escasa y autolimitada). Como no está dentro de las opciones marcaría la Placenta Previa, por estar todo bien, sin compromiso fetal. No habla de relaciones sexuales ni describe lesiones cervicales, como para ser sinusorragia.

3.01.2.012 Parto prematuro

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 19.15 Síndrome de Parto Prematuro: Amenaza de Parto Prematuro (APP), Tocolíticos, Maduración Pulmonar y Neuroprotección

QUÉ HAY QUE SABER

- Parto prematuro: entre las 22 y 36+6 semanas; amenaza = contracciones dolorosas ≥4 en 20 min (o 8 en 60) con modificaciones cervicales o cervicometría <25 mm.
- Estudio: cervicometría transvaginal (cuello largo = riesgo bajo, observar), especuloscopía para descartar RPM, urocultivo, cultivo de flujo y descartar corioamnionitis o DPPNI.
- Tocolisis solo para ganar 48 h: nifedipino oral (20 mg y luego 10–20 mg c/6–8 h); indometacina solo <32 semanas; atosibán de segunda línea. Contraindicada en corioamnionitis, DPPNI, eclampsia, sufrimiento fetal.
- Corticoides entre 24 y 34 semanas: betametasona 12 mg IM c/24 h x2 (o dexametasona 6 mg c/12 h x4); sulfato de magnesio como neuroprotector si <32 semanas y parto inminente.
- Profilaxis de estreptococo grupo B con penicilina en todo trabajo de parto prematuro con cultivo positivo o desconocido.
- Prevención: progesterona vaginal 200 mg/noche hasta las 36 semanas si cuello <25 mm o parto prematuro previo. Seguimiento: derivar a alto riesgo obstétrico.

PREGUNTAS (15)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 155

Primigesta de 23 años, cursando un embarazo de 20 semanas, se realiza una ecografía transvaginal que muestra un cuello de 20 mm de longitud, sin otras alteraciones. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Indicar pesario cervical
B) Iniciar progesterona vaginal
C) Realizar cerclaje cervical
D) Administrar corticoides sistémicos
E) Observar evolución, sin intervenir

Respuesta B. Cuello menor a 25 mm en paciente sin antecedente de parto prematuro ni de incompetencia cervical: la conducta es progesterona vaginal. El cerclaje se reserva para cuando además hay antecedente de aborto tardío o parto muy prematuro previo.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 72

Una paciente de 27 años, cursando un embarazo de 32 semanas, consulta en urgencias por contracciones uterinas dolorosas. Al examen físico se constatan contracciones de tres en diez minutos, cuello uterino borrado en un 50 por ciento y con un centímetro de dilatación. La frecuencia cardíaca fetal es de 130 por minuto, con buena variabilidad. **¿Cuál de los siguientes fármacos es el más adecuado para el manejo inicial?**

A) Ampicilina
B) Indometacina
C) Nifedipino
D) Sulfato de magnesio
E) Atosibán

Respuesta C. A partir de las 32 semanas, el tocolítico de primera línea es el nifedipino oral. La indometacina se reserva para menores de 32 semanas. El atosibán es de segunda línea.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 155

Una primigesta de 23 años, cursando un embarazo de 20 semanas, se realiza una ecografía transvaginal que muestra un cuello de 20 milímetros de longitud, sin otras alteraciones. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Indicar pesario cervical
B) Iniciar progesterona vaginal
C) Realizar cerclaje
D) Administrar corticoides sistémicos
E) Observar la evolución

Respuesta B. Cuello menor a 25 mm sin antecedentes de partos muy prematuros ni incompetencia cervical: se maneja con progesterona vaginal como prevención primaria. El cerclaje se reserva para quien tiene ese antecedente.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 164

Una paciente de 32 años, cursando un embarazo de 32 semanas, consulta por dolor abdominal. Se constatan contracciones uterinas de tres a cuatro en diez minutos y un tacto vaginal que muestra dilatación de 6 centímetros, con borramiento completo. **¿Cuál de los siguientes fármacos es el más importante para mejorar el pronóstico del recién nacido?**

A) Corticoides
B) Sulfato de magnesio
C) Tocolíticos
D) Antibióticos
E) Progesterona

Respuesta B. Con 6 cm de dilatación y borramiento completo, el parto ya es inminente: no alcanzan a actuar ni los tocolíticos ni los corticoides. Lo que sí sigue teniendo efecto y protege al recién nacido es el sulfato de magnesio.

Pregunta de práctica

Primigesta de 29 semanas consulta por dolor tipo cólico menstrual de 3 horas de evolución. Al examen: signos vitales normales, afebril. El tocodinamómetro muestra 4 contracciones dolorosas en 20 minutos. La cervicometría transvaginal muestra un cuello de 18 milímetros, con dilatación de 1,5 centímetros. No hay pérdida de líquido ni sangrado, y el monitor fetal es reactivo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Indicar reposo en domicilio y control en una semana
B) Hospitalizar e iniciar nifedipino, betametasona y sulfato de magnesio
C) Realizar cesárea de urgencia por riesgo de parto inminente
D) Administrar indometacina rectal por 14 días y dar el alta
E) Realizar un cerclaje cervical de urgencia

Respuesta B. Contracciones frecuentes con cuello corto y dilatado a las 29 semanas confirman una amenaza de parto prematuro, sin contraindicaciones para tocolisis. El manejo integral es nifedipino, betametasona, y sulfato de magnesio por ser menor a 32 semanas.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 73 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 27 años, cursando un embarazo de 32 semanas consulta en el servicio de urgencias, debido a que presenta contracciones uterinas dolorosas en su domicilio. Al examen físico se constatan contracciones uterinas de 3 en 10 minutos y se palpa el cuello uterino borrado en 50%, con dilatación de 1 cm. El registro fetal muestra frecuencia cardíaca fetal basal de 130 latidos por minutos, con buena variabilidad. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el más adecuado para el manejo inicial de esta paciente?

A) Ampicilina
B) Indometacina
C) Nifedipino
D) Sulfato de magnesio
E) Atosibán

Respuesta C. Manejo del Trabajo de Parto Prematuro: En un trabajo de parto prematuro menor a 34 semanas, se usan corticoides y tocolíticos. La indometacina se recomienda en menores de 32 semanas y el nifedipino desde las 32 semanas en adelante. El atosibán es un tocolítico de segunda línea, mientras que la ampicilina sí está indicada cuando avance el trabajo de parto, ya que se usa como profilaxis para el estr

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 88 · texto original del banco, sin revisar

Una mujer de 35 años, multípara de uno, cursando embarazo de 28 semanas, consulta por dolor abdominal, sin otros síntomas. Al examen se aprecia presencia de contracciones uterinas de tres en diez minutos, al tacto vaginal se palpa cuello con un centímetro de dilatación, 50% borrado. Se realiza ecografía transvaginal que muestra cérvix de 18 mm. El fármaco de elección para el manejo de esta paciente es:

A) Atosiban
B) Nifedipino
C) Fenoterol
D) Progesterona
E) Sulfato de magnesio

Respuesta B. Parto prematuro de menos de 34 semanas, con cuello corto y con algo de modificaciones. Hay que dar corticoides y tocolíticos. Atosiban, fenoterol y nifedipino son opciones. La guía minsal dice nifedipino en primer lugar. Si no frena a las 2 horas, se hace ambocentesis y si no hay bacterias, se dan tocolíticos de segunda línea: fenoterol o atosiván. Clave Eplicación

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 167 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 35 años, multípara de 2, tiene un embarazo de 30 semanas. Consulta porque inició contracciones uterinas dolorosas, hace pocas horas. Al examen tiene un cuello 80% borrado, con 2cm de dilatación y 3 contracciones uterinas cada 10 minutos. El registro fetal no muestra alteraciones. ¿Cuál es la medida más importante ante esta paciente?

A) Antibióticos
B) Tocólisis
C) Conducir el trabajo de parto
D) Cerclaje
E) Interrumpir el embarazo

Respuesta B. La alternativa correcta es la B (Tocólisis). Tiene un parto prematuro menor a 34 semanas, por lo que se debe dar tocolíticos y corticoides.. 1. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 11 · texto original del banco, sin revisar

Una mujer de 30 años, multípara de 1, cursando un embarazo de 29 semanas, con- sulta por dinámica uterina persistente. Al examen físico presenta 3 contracciones uteri- nas en 10 minutos y su tacto vaginal muestra feto en cefálica, con cuello delgado y dila-

A) Dar fenoterol endovenoso
B) Dar nifedipino oral
C) Dar sulfato de magnesio endovenoso
D) Realizar cesárea de urgencia
E) Administrar corticoides

Respuesta E. Ya que está en fase activa, están contraindicados los tocolíticos. Además la indica- ción relativa (sin evidencia) de la cesárea en el parto prematuro, es cuando tiene menos de 28 semanas o 1Kg. Los corticoides poco servirán, pero siguen siendo indicados en el parto prematuro entre 24 y 34 semanas.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 170 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 33 años, cursando un embarazo de 31 semanas, presenta contracciones uterinas frecuentes y dolorosas. Además, su tacto vaginal demuestra 2 cm de dilatación y 50% de borramiento. ¿Qué se debe realizar antes, para decidir si se administran o no los tocolíticos?

A) Realizar ecodoppler de arterias umbilicales
B) Determinar vitalidad y bienestar fetal mediante ecografía
C) Realizar ecodoppler de arterias uterinas
D) Realizar monitoreo electrónico de la frecuencia cardiaca fetal
E) Descartar infección con amniocentesis

Respuesta D. , B? Por regla general, antes de dar los tocolíticos, se debe evaluar si están contraindicados (ej. Óbito fetal, alteración grave del bienestar fetal, dilatación mayor a 3 o 6 cm, etc.). Tanto el registro, como la Ecografía se suelen solicitar. Yo marqué el registro, ya que es lo que suele estar disponible y es más rápido de hacer en ese momento.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 91 · texto original del banco, sin revisar

Una mujer cursando un embarazo de 27 semanas, presenta dinámica uterina persis- tente y dolorosa, asociada a fiebre hasta 38 grados. Al examen físico tiene temperatura 37,8 grados Celsius, FC: 80x', PA: 120/80 mmHg y 4 contracciones uterinas cada 10 minu- tos, que persisten, a pesar de administrar nifedipino oral. Sus exámenes de sangre de- muestran PCR: 25 ng/ml (VN: menor a 10 ng/ml) y hemograma con 12.000 glóbulos blan- cos por mm3. El monitoreo fetal es tranquilizador. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Interrumpir el embarazo
B) Administar fenoterol
C) Administrar atosiban
D) Realizar amniocentesis
E) Iniciar antibióticos

Respuesta D. No alcanzaba a cumplir criterios de coriomanionitis, pero dado que se trataba de un parto prematuro, que no respondía a tocolíticos de primera línea, era necesario rea- lizar la amniocentesis.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 164 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente, que cursa un embarazo de 30 semanas de edad gestacional, inicia contracciones uterinas de 3 en 10 minutos. Su tacto vaginal muestra un cuello con 80% de borramiento y 3 cm de dilatación. Se administra nifedipino y la primera dosis de corticoides. Se reevalúa a las 2 horas y persiste con la dinámica uterina de 3 a 4 contracciones en 10 minutos, con 4 cm de dilatación, por lo que se realiza amniocentesis, que da salida a un líquido con escasa bacterias a la tinción de Gram. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Dejar a evolución espontánea
B) Administrar la segunda dosis de corticoides
C) Determinar madurez fetal en líquido amniótico
D) Realizar operación cesárea
E) Administrar tocolíticos de segunda línea

Respuesta D. Como tiene infección está contraindicada la tocolisis de segunda línea. No tiene sentido dar la segunda dosis de corticoides. Llama la atención que no aparezcan antibióticos como alternativa, ya que son la medida más importante. Está indicado interrumpir el embarazo, pero por tener 30 semanas, está contraindicado el parto vaginal (contraindicación relativa que tenga menos de 1.500 gramos), por lo

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 159 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 32 años, con antecedente de un parto prematuro previo a las 30 semanas de gestación, cursa un nuevo embarazo de 13 semanas. Se realiza una ecografía transvaginal, que muestra una longitud cervical de 28mm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar cerclaje cervical
B) Iniciar tocolíticos a las 28 semanas
C) Indicar progesterona endovaginal y realizar cervicometrías seriadas
D) Indicar aspirina oral
E) Realizar el control habitual del embarazo

Respuesta C. Cuello Uterino Corto: Un cuello uterino corto se define como una longitud cervical menor o igual a 25 mm. La progesterona endovaginal se recomienda en pacientes con cuello uterino corto o con antecedentes de parto prematuro (discutible). Además, el cerclaje se indica si la paciente presenta ambas condiciones.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 165 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente cursa un embarazo de 32 semanas, presenta dinámica uterina 2 a 3 contracciones cada 10 minutos y dilatación cervical de 1 cm. El registro fetal es tranquilizador. Se administran corticoides a la madre, más nifedipino 10 mg vía oral, sin embargo persiste con la dinámica uterina una hora después. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Administrar tocolíticos de segunda línea
B) Dejar a evolución espontánea
C) Administrar sulfato de magnesio
D) Realizar cesárea
E) Realizar amniocentesis

Respuesta E. Al fallar los tocolíticos de primera línea, lo primero es descartar una infección con la amniocentesis.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 166 · texto original del banco, sin revisar

Una mujer de 25 años, primigesta, cursando su embarazo de 22 semanas, se realiza una cervicometría, que muestra un cuello de 25 mm de largo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Mantener conducta expectante
B) Indicar progesterona oral
C) Indicar progesterona vaginal
D) Realizar cerclaje
E) Administrar corticoides

Respuesta C. Si bien tiene un cuello corto, el cerclaje solo se indica cuando hay antecedente de abortos tardíos o partos prematuros muy tempranos. De lo contrario, solo se da progesterona vaginal.

3.01.2.013 Presentaciones fetales anómalas

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **No requiere**

Dónde se enseña: Tema 19.17 Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO)

QUÉ HAY QUE SABER

- La presentación cefálica de vértice es la normal; las anómalas son podálica (3–4% a término), de cara, frente, bregma y la situación transversa.
- Sospecha: maniobras de Leopold (polo duro en fondo uterino en podálica), LCF auscultados sobre el ombligo, tacto vaginal (sacro, cara o miembros); confirmar con ecografía.
- Factores: prematurez, multiparidad, placenta previa, miomas, malformaciones uterinas o fetales, polihidroamnios, embarazo múltiple.
- Podálica a término: ofrecer versión cefálica externa a las 36–37 semanas si no hay contraindicaciones; si persiste, cesárea electiva a las 39 semanas en la mayoría.
- Situación transversa en trabajo de parto: cesárea siempre (riesgo de procidencia de cordón y de rotura uterina); frente: cesárea; cara mentoanterior puede nacer por vía vaginal.
- Manejo inicial del médico general: reconocer y derivar a parto hospitalario; si hay procidencia de cordón, elevar la presentación y cesárea urgente. Seguimiento: no requiere.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 135

Paciente de 35 años, cursando un embarazo de 38 semanas, consulta por contracciones uterinas de 3 a 4 cada 10 minutos. Al tacto vaginal presenta 10 cm de dilatación, membranas rotas y cabeza fetal en espinas 0, en variedad mento-ilíaca derecha posterior. El monitoreo fetal es tranquilizador. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Dejar a evolución espontánea y controlar en una hora
B) Hacer fórceps
C) Realizar vacuum de la cabeza fetal
D) Realizar amnioinfusión con rotación manual
E) Hacer cesárea de urgencia

Respuesta E. Presentación de cara con mentón posterior: el cuello fetal ya está en extensión máxima y no puede seguir la curva del canal, por lo que el parto vaginal es imposible. La conducta es cesárea. Solo la cara con mentón anterior (mento-púbica) puede nacer por vía vaginal; el fórceps y el vacuum están contraindicados.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 160 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente primigesta, cursando un embarazo de 37 semanas, consulta por contracciones uterinas dolorosas, 3 en 10 minutos. Tiene 8 cm de dilatación, con 100% de borramiento, con feto en posición podálica y registro fetal tranquilizador. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Tocolíticos
B) Reversión interna
C) Reversión externa
D) Fórceps
E) Operación cesárea

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Operación cesárea (opción E). Trabajo de parto en podálica contraindica el parto vaginal. Cesárea.. La resolución quirúrgica urgente constituye la única medida definitiva capaz de controlar el foco séptico, revertir la isquemia o evitar la muerte materna/fetal frente a este compromiso clínico severo.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 23 · texto original del banco, sin revisar

Mujer en trabajo de parto, feto en cefálica, Bishop 8, dilatación 10 cm, encajado, presentación de cara, Mentón- posterior cual es la conducta

A) Cesárea
B) Forceps
C) Vacum
D) Continuar tdp (la presentación de cara no tiene contraindicación de cesárea, la de frente si) eso!!! (Pero ojo la variedad de posición mento púbica = mentón-anterior, es la única NO distócica según Guevara, por lo que la Mentón posterior de este caso debería ser indicación de cesárea)... Había una opción que decía reevaluar en 2 horas
E) Realizar prueba de trabajo de parto

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Cesárea (opción A). La resolución quirúrgica urgente constituye la única medida definitiva capaz de controlar el foco séptico, revertir la isquemia o evitar la muerte materna/fetal frente a este compromiso clínico severo.

3.01.2.014 Rotura prematura de membranas

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 19.14 Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis Antibiótica y Corioamnionitis

QUÉ HAY QUE SABER

- RPM: pérdida de líquido claro con olor a cloro antes del inicio del trabajo de parto; no hacer tacto vaginal (aumenta infección y acorta la latencia).
- Confirmación: especuloscopía estéril viendo salir líquido por el OCI (Valsalva o Tarnier); si hay duda, PAMG-1 (mayor rendimiento), test de helecho o pH (nitrazina); ecografía con oligoamnios apoya.
- ≥34 semanas: interrumpir (inducción) y profilaxis de estreptococo grupo B si cultivo positivo, desconocido o RPM >12–18 h.
- 24–33+6 semanas sin infección: hospitalizar, ampicilina + eritromicina (48 h EV y luego VO, 7 días en total), betametasona y sulfato de magnesio si <32 semanas; vigilancia de infección.
- Corioamnionitis (fiebre ≥38 °C + 2 menores: taquicardia materna o fetal, útero doloroso, LA fétido, leucocitosis): ampicilina + gentamicina EV e interrupción inmediata; sin tocolisis ni corticoides.
- Seguimiento: derivar a alto riesgo obstétrico para manejo hospitalario.

PREGUNTAS (12)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 16

Una paciente de 34 años, multípara, embarazada de 36 semanas, presenta pérdida de líquido amniótico hace una hora, confirmándose rotura de membranas con la prueba de microglobulina placentaria. La ecografía obstétrica muestra disminución del líquido amniótico, con presentación cefálica y bienestar fetal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar cesárea
B) Administrar corticoides
C) Inducir el parto
D) Esperar 48 horas para el inicio espontáneo del trabajo de parto
E) Administrar antibióticos

Respuesta C. RPM de 34 semanas o más se induce de inmediato si no hay contraindicación de parto vaginal. Los corticoides y los antibióticos de latencia son para las gestaciones menores a 34 semanas.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 105

Una paciente de 28 años, cursa un embarazo de 32 semanas por amenorrea, sin controles obstétricos previos, y consulta por pérdida de líquido amniótico. Al examen físico presenta temperatura de 38,5 grados y frecuencia cardíaca de 110 por minuto. La especuloscopía muestra salida de líquido por el orificio cervical. El monitoreo fetal muestra una frecuencia cardíaca fetal de 180 latidos por minuto. La ecografía obstétrica muestra oligoamnios. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Interrumpir el embarazo
B) Administrar corticoides y antibióticos, manteniendo una conducta expectante
C) Solicitar Doppler materno-fetal
D) Realizar amniocentesis
E) Realizar amnioinfusión con surfactante intraamniótico

Respuesta A. Fiebre materna con taquicardia materna y fetal, en una RPM de pretérmino, cumple criterios de corioamnionitis clínica. Esto gana por encima de la edad gestacional: se interrumpe el embarazo, sin importar que sea menor a 34 semanas.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 96

Una mujer de 34 años, cursando su primer embarazo de 36 semanas, refiere salida de abundante líquido por los genitales. A la especuloscopía no se observa salida de líquido por el orificio cervical externo, y al tacto vaginal se palpa un cuello sin dilatación, posterior y duro, sin borramiento. Una ecografía muestra oligoamnios. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Indicar antibióticos profilácticos y mantener conducta expectante
B) Inducir el parto con misoprostol
C) Realizar cesárea
D) Inducir el parto con oxitocina
E) Solicitar un perfil biofísico para tomar la conducta definitiva

Respuesta B. RPM de 36 semanas con cuello posterior, duro y sin dilatación es un Bishop bajo. Con cuello inmaduro, la oxitocina no sirve: se induce con misoprostol para madurar y desencadenar el parto a la vez.

Pregunta de práctica

Primigesta de 30 semanas, hospitalizada hace 3 días por rotura prematura de membranas en manejo conservador, presenta fiebre de 38,6 grados, calofríos y taquicardia materna. El útero está hipertónico y muy sensible al tacto. Por la especuloscopía sale líquido amniótico purulento y de mal olor. El monitor fetal muestra taquicardia fetal sostenida, y el hemograma muestra leucocitosis con desviación a la izquierda. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Dar antipiréticos y tocolíticos, y esperar a las 34 semanas
B) Iniciar ampicilina más gentamicina endovenosa e interrumpir el embarazo ya
C) Dar un segundo ciclo de betametasona y esperar 48 horas
D) Realizar una amniocentesis y esperar el resultado del cultivo
E) Indicar sulfato de magnesio y mantener la conducta expectante

Respuesta B. Fiebre más taquicardia materna y fetal, útero doloroso, líquido purulento y leucocitosis: cumple criterios de Gibbs para corioamnionitis clínica. Esto contraindica cualquier conducta expectante, tocolisis o corticoides. La conducta es antibióticos endovenosos de amplio espectro e interrupción inmediata.

Pregunta de práctica

Paciente de 30 semanas de gestación, primigesta, consulta por pérdida repentina de líquido transparente hace 4 horas, con olor a lavandina, sin dolor ni contracciones. Al examen: afebril, presión y frecuencia cardíaca normales, útero relajado. La especuloscopía estéril confirma la salida de líquido claro al toser. Los latidos fetales son reactivos, y no hay dinámica uterina. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Hospitalizar en ARO, dar betametasona y antibióticos de latencia
B) Indicar reposo domiciliario y control en una semana
C) Inducir el parto con misoprostol de inmediato
D) Realizar cesárea dentro de las próximas horas
E) Iniciar tocolisis de mantención por dos semanas

Respuesta A. RPM confirmada a las 30 semanas, sin signos de infección ni trabajo de parto: manejo conservador en ARO, con betametasona para maduración pulmonar y antibióticos de latencia para prolongar el tiempo libre de parto.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 85 · texto original del banco, sin revisar

Embarazada de 35 semanas con rotura prematura de membranas hace 48 horas. Sin contracciones, sin fiebre, sin signos de infección. Feto en cefálica, sin signos de sufrimiento. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Hospitalizar, maduración pulmonar con corticoides, antibióticos y vigilancia
B) Inducción del parto inmediata
C) Cesárea de urgencia
D) Alta con control ambulatorio
E) Amnioinfusión

Respuesta A. RPM a las 35 semanas: manejo conservador con hospitalización, corticoides (betametasona) para maduración pulmonar, antibióticos profilácticos (ampicilina + eritromicina) y monitoreo fetal estrecho.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 165 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 35 años, multípara de 1, cursando un nuevo embarazo de 35 semanas, presenta rotura prematura de membranas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar operación cesárea
B) Realizar amniocentesis
C) Interrumpir el embarazo
D) Administrar tocolíticos
E) Administrar antibióticos y mantener una conducta expectante

Respuesta C. La RPO mayor a 34 semanas se debe interrumpir, idealmente por vía vagina, a menos que tenga contraindicación del parto vaginal, en que se realiza cesárea.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 75 · texto original del banco, sin revisar

Embarazada de 35 semanas, multípara de 2, refiere pérdida de líquido claro abundante por genitales, no asociado a otros síntomas. A la especuloscopía no se observa líquido saliendo del orificio cervical externo. Se realiza registro basal no estresante que se encuentra reactivo. El examen de elección para evaluar a esta paciente es:

A) Ecografía
B) Test de nitrazina
C) Test de cristalización
D) Detección de alfa 1 microglobulina placentaria
E) Medición del pH vaginal

Respuesta D. La PAMG1 es de elección hoy en día, aunque suele no estar disponible y se hace el test de cristalización. Si no apareciera en las alternativas, la respuesta sería el test de cristalización, pero la PAMG1 (altísima sensibilidad y especificidad) es mejor y es la respuesta correcta. Si la pregunta estuviese planteada en términos de costos, eficiencia o algo así, sí sería el test de cristalización.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 121 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 28 años, multípara de 2, con un parto nacido por cesárea y el segundo nacido por vía vaginal. Consulta por pérdida de líquido claro por genitales. La especuloscopía no muestra alteraciones, por lo que se realiza un test de nitrazina, con pH: 5,5. La ecografía obstétrica muestra feto en cefálica, con peso acorde para la edad gestacional, con índice de líquido amniótico de 2,2 y 128 latidos cardiofetales por minuto. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Inducir el parto
B) Realizar amniocentesis
C) Solicitar Doppler fetal
D) Realizar operación cesárea
E) Mantener una conducta expectante

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Mantener una conducta expectante (opción E). Manejo De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad. Las opciones alternativas (Inducir el parto, Realizar amniocentesis) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del pac

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 128 · texto original del banco, sin revisar

¿Cuál es la conducta más adecuada para una paciente de 22 años, primigesta, cursando un embarazo de 35 semanas, que sufre una rotura de membranas, sin trabajo de parto?

A) Inducir el parto
B) Administrar antibióticos terapéuticos
C) Administrar corticoides
D) Adminitrar tocolíticos
E) Administrar sulfato de magnesio

Respuesta A. Toda RPM mayor a 34 semanas se debe interrumpir. Si no tiene contraindicación del parto vaginal, se induce; si tiene contraindicación, se hace una cesárea. En cambio, las menores a 34 semanas se maduran con corticoides, se les da antibióticos y se interrumpen al cumplir 34 semanas, desarrollar una corioamnionitis clínica o comprobarse madurez fetal en la amniocentesis (la que se hace si hay sospec

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 150 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 30 años, embarazada sin controles iniciales, con edad gestacional dudosa, consulta por pérdida de líquido por los genitales. Sus signos vitales son norma- les y al examen obstétrico no presenta dinámica uterina ni modificaciones cervicales en el tacto vaginal. Su altura uterina es de 25 cm y las pruebas de bienestar fetal son normales. Se realiza ecografía obstétrica, que muestra índice de líquido amniótico de 5,2 y biometría para 30 semanas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Inducir el parto con misoprostol
B) Realizar cesárea
C) Dar antibióticos y corticoides y mantener una conducta expectante
D) Determinar madurez fetal en líquido amniótico
E) Administrar nifedipino oral

Respuesta C. C, D? Pregunta demasiado específica y difícil y con todo al límite (si quien hizo esta pregunta es la misma persona que preguntó lo de la regurgitación tricuspidea, le comu- nico que no tiene idea de qué debe o no debe saber un médico general). Es una RPO y dado que la edad gestacional es dudosa, se hizo una biometría que tiene un rango de error de 3 semanas: así tiene entre 27 y 33 semanas. Al ha

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 66 · texto original del banco, sin revisar

Paciente de 35 años, multípara, con un nuevo embarazo de 32 semanas, presenta salida de líquido amniótico por genitales. El test de cristalización confirma rotura prematura ovular. Al examen físico se constata taquicardia materna y fetal, asociada a contracciones uterinas dolorosas y útero doloroso a la palpación. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Inducir el parto
B) Realizar cesárea
C) Administrar corticoides
D) Administrar antibióticos
E) Administrar tocolíticos

Respuesta B. Pregunta con información insuficiente. Tiene clínica de corioamnionitis (por lo que es una corioamnionitis), por lo que lo más correcto es interrumpir el embarazo, bajo cobertura antibiótica (clinda-genta). Ninguna de las opciones entregaba el manejo completo. Lo más importante es la interrupción del embarazo, por lo que dejaremos como correcta la B. Es importante aclarar que la corioamnionitis no

3.01.2.015 Rotura uterina

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 19.13 Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospecha: dolor abdominal súbito e intenso durante el trabajo de parto que luego cede junto con las contracciones, metrorragia, ascenso de la presentación y partes fetales palpables bajo la piel.
- Signo más precoz y frecuente: alteración del registro fetal (bradicardia o desaceleraciones prolongadas); luego shock hipovolémico materno.
- Factor de riesgo clave: cicatriz uterina previa (cesárea, miomectomía), sobre todo en prueba de trabajo de parto con oxitocina o inducción con prostaglandinas; también multiparidad y distocias.
- Signo premonitorio (inminencia): anillo de Bandl (retracción patológica) con contracciones intensas en parto obstruido.

- Manejo inicial: ABC, dos vías gruesas, reposición de volumen y hemoderivados, suspender oxitocina; laparotomía de urgencia para extraer al feto y reparar el útero o histerectomía.
- Seguimiento: derivar; en embarazos futuros, cesárea electiva antes del trabajo de parto.

PREGUNTAS (5)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 51

Una paciente de 38 años, cursando embarazo de 38 semanas, inicia trabajo de parto y es ingresada al hospital. Al examen físico presenta cuatro contracciones uterinas cada 10 minutos y se palpa la cabeza fetal encajada, en el tercer plano de Hodge. Durante el parto, evoluciona con metrorragia escasa y dolor abdominal, constatándose elevación de la presentación fetal y cese de las contracciones uterinas. Tiene antecedente de una cesárea previa. El monitoreo fetal muestra descenso de los latidos cardiofetales a 90 por minuto. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Esperar evolución espontánea
B) Realizar cesárea de urgencia
C) Realizar reanimación fetal
D) Administrar tocolíticos endovenosos
E) Solicitar pH de cuero cabelludo

Respuesta B. Cese súbito de las contracciones, ascenso de la presentación fetal y bradicardia, con cesárea previa: rotura uterina. La conducta es cesárea de urgencia inmediata, sin perder tiempo en otros exámenes.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 132 · texto original del banco, sin revisar

Puérpera con una cesárea anterior presenta trabajo de parto espontáneo. A las 2 horas de trabajo de parto activo, refiere dolor uterino súbito diferente a las contracciones, y el MEFI muestra bradicardia fetal sostenida. ¿Cuál es la conducta inmediata?

A) Fórceps de urgencia
B) Conducción con oxitocina
C) Vacuum
D) Cesárea de urgencia inmediata
E) Espera activa y analgesia

Respuesta D. Rotura uterina (dolor súbito diferente a contracciones + bradicardia fetal + antecedente de cicatriz uterina): emergencia obstétrica máxima. Cesárea de urgencia INMEDIATA. El fórceps/vacuum están absolutamente contraindicados. Sin tratamiento puede ser fatal para madre y feto.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 41 · texto original del banco, sin revisar

Embarazada con antecedente de cesárea previa, durante el parto presenta cese de contracciones, sangrado y bradicardia fetal. ¿Diagnóstico más probable?

A) Desprendimiento prematuro de placenta
B) Placenta previa sangrante
C) Prolapso de cordón umbilical
D) Embolia de líquido amniótico
E) Rotura uterina

Respuesta E. Diagnóstico: Rotura uterina (opción E). Rotura uterina. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 98 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 37 años, multípara de 1, cesarizada anterior, presenta un nuevo embarazo de término. Ingresa a la sala de preparto, por contracciones uterinas doloro- sas. Al examen tiene 3-4 contracciones uterinas cada 10 minutos y tacto vaginal con di-

A) Placenta previa
B) Procidencia de cordón
C) Rotura uterina
D) Rotura de vasa previa
E) Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta

Respuesta C. Es una rotura uterina clásica, con el antecedente de cesárea y la clínica habitual (dolor, sufrimiento fetal, escasa metrorragia y útero difícil de palpar).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 166 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 24 años, multípara de 1, con antecedente de una cesárea previa, por desproporción céfalo pélvica. Cursa con un nuevo embarazo, de término, cuando inicia trabajo de parto. Inicialmente tiene buena dinámica uterina, sin embargo, luego desaparece, agregándose escasa metrorragia. El monitoreo fetal muestra bradicardia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Desprendimiento de placenta
B) Rotura uterina
C) Rotura de vasa previa
D) Placenta previa
E) Hipotensión secundaria a la anestesia

Respuesta B. Es una rotura uterina clásica: antecedente de cesárea, contracciones dolorosas que ceden, metrorragia intraparto y sufrimiento fetal.

3.01.2.016 Dolor pélvico agudo

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 20.16 Urgencias Ginecológicas Quirúrgicas: Torsión Anexial y Rotura de Quiste Ovárico Hemorrágico

QUÉ HAY QUE SABER

- Primer paso en toda mujer en edad fértil con dolor pélvico agudo: beta-hCG y evaluación hemodinámica; positivo con útero vacío obliga a descartar ectópico.
- Torsión anexial: dolor unilateral hiperagudo con vómitos profusos (>80%), quiste de 5–10 cm (teratoma); Doppler: ovario aumentado, edematoso, signo del remolino y flujo ausente o disminuido.
- Quiste hemorrágico roto: dolor poscoital en fase lútea tardía (días 20–26), sin vómitos; ecografía con patrón en red de pesca y líquido libre; manejo médico si está estable.
- Otros diferenciales: PIP/absceso tubo-ovárico (fiebre, flujo, dolor a la movilización cervical), apendicitis, litiasis ureteral, pielonefritis, degeneración de mioma.
- Manejo inicial: analgesia EV, hemograma, PCR, orina, ecografía transvaginal con Doppler; inestable o ectópico roto → cirugía de urgencia.
- Seguimiento: derivar a ginecología de urgencia según diagnóstico (laparoscopía en torsión, hospitalización en PIP grave).

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 169

Una paciente de 19 años, con ciclos menstruales regulares, consulta por dolor abdominal intenso, mayor en la fosa ilíaca izquierda. Su fecha de última regla fue hace 20 días. Al examen físico presenta dolor a la palpación con signos peritoneales esbozados. El test de embarazo es negativo, y la ecografía transvaginal muestra una lesión anexial mixta de 8 cm, con líquido libre en moderada cantidad. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Cuerpo lúteo hemorrágico
B) Cuerpo lúteo roto
C) Apendicitis aguda
D) Torsión ovárica
E) Absceso tubo-ovárico

Respuesta A. El día 20 del ciclo corresponde a la fase lútea, y la imagen mixta con líquido libre, sin cortejo vegetativo intenso ni signos de compromiso vascular, es el cuadro clásico del cuerpo lúteo hemorrágico, distinto de la torsión y del cuerpo lúteo ya roto con inestabilidad.

3.01.2.017 Sufrimiento fetal agudo

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **No requiere**

Dónde se enseña: Tema 19.17 Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO)

QUÉ HAY QUE SABER

- Hipoxia fetal aguda intraparto; se sospecha por alteración del registro cardiotocográfico y se reconoce por categorías: I normal, II indeterminado, III anormal.
- Normal: basal 110–160 lpm, variabilidad 6–25, aceleraciones; desaceleración precoz (espejo de la contracción, compresión cefálica) es benigna.

- Desaceleraciones tardías recurrentes (hipoxia placentaria), variabilidad ausente, bradicardia sostenida <110 o patrón sinusoidal (anemia fetal) = categoría III.
- Reanimación intrauterina: suspender oxitocina, decúbito lateral izquierdo, hidratación EV, oxígeno, corregir hipotensión (anestesia) y tocolisis aguda si hay taquisistolia.
- Categoría III que no mejora: interrupción inmediata por la vía más rápida (cesárea, o fórceps/vacuum si está en expulsivo con condiciones).
- Causas a buscar: DPPNI, rotura uterina, procidencia de cordón, hiperdinamia, hipotensión materna. Seguimiento: no requiere; atención del RN con equipo de reanimación neonatal.

PREGUNTAS (8)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 170

Embarazo de término en trabajo de parto, con seis centímetros de dilatación y variabilidad disminuida de la frecuencia cardíaca fetal. Dos horas después, con ocho centímetros de dilatación, persiste la variabilidad disminuida y aparecen desaceleraciones tardías en relación a cada contracción. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar fórceps
B) Realizar operación cesárea
C) Administrar misoprostol
D) Iniciar oxitocina en goteo
E) Mantener conducta expectante y reevaluar en 30 minutos

Respuesta B. Variabilidad disminuida más desaceleraciones tardías recurrentes es categoría tres: sufrimiento fetal que exige la vía más expedita. No se puede hacer fórceps con solo ocho centímetros de dilatación, así que la conducta es cesárea de urgencia.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 22 · texto original del banco, sin revisar

Una mujer de 38 de años, cursando un embarazo de término, inicia trabajo de parto. Actualmente tiene 7 cm de dilatación y se palpa la cabeza fetal ascendida, 2 centímetros por sobre las espinas isquiáticas. Presenta dinámica uterina de 4 a 5 contracciones uterinas cada 10 minutos, recibiendo goteo oxitócico. Luego de 2 horas de observación no se presentan cambios en las condiciones obstétricas y, poco después, aparecen múltiples desaceleraciones tardías en el monitoreo fetal y el líquido amniótico se tiñe de meconio. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Suspender oxitocina, lateralizar y controlar por 30 minutos
B) Realizar operación cesárea de inmediato
C) Administrar anestesia epidural y conducir el trabajo de parto
D) Aumentar la dosis de oxitocina y, una vez que se logre el descenso de la cabeza, realizar fórceps
E) Solicitar ecografía Doppler fetal

Respuesta B. Sufrimiento fetal y prueba de parto fracasada: La paciente presenta signos de sufrimiento fetal, incluyendo desaceleraciones tardías en el registro fetal y líquido amniótico meconial. Si bien sería aceptable comenzar con la reanimación intrauterina, en este caso, además, se observa una prueba de parto fracasada, por lo que se debe indica cesárea de inmediato.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 88 · texto original del banco, sin revisar

Paciente de 30 años, multípara de 1 parto vaginal, presenta parto de término, con 4 cm de dilatación, membranas rotas, se administra anestesia peridural, presentando PA 100/65 mmHg, LCF 90/min y 6 contracciones uterinas cada 10 minutos. La conducta más adecuada es:

A) Administrar volumen y monitorizacion fetal
B) Realizar cesárea de urgencia
C) Iniciar tocolisis de urgencia
D) Realizar fórceps
E) Iniciar amniotransfusión

Respuesta B. Pareciera un desprendimiento de placenta, pero le falta la metrorragia. De todos modos, está con un sufrimiento fetal agudo (FC: menor a 100) y la bradicardia fetal es indicación de interrumpir por la vía más expedita y en este caso es la cesárea, porque está en fase activa y no se puede hacer un fórceps (a menos que esté en expulsivo: 10 cm, con descenso en tercer plano de Hodge o espinas +2).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 118 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 33 años, cursando embarazo de 40 semanas, inicia trabajo de parto. Se realiza control del parto, que constata dilatación cervical completa y cabeza en espinas +2. El monitoreo electrónico fetal muestra lo siguiente: La conducta más adecuada es:

A) Realizar cesárea de urgencia
B) Realizar fórceps
C) Solicitar perfil biofísico
D) Lateralizar a la madre y administrarle oxígeno
E) Mantener una conducta expectante

Respuesta B. Tiene una bradicardia fetal mantenida (mayor a 10 minutos), por lo que se debe interrumpir inmediatamente por la vía más expedita. En este caso, la vía más expedita es el fórceps, ya que cumple con todos los requisitos: cefálica, dilatación completa, espinas +2 y anestesia (aunque no se menciona, pero tampoco se puede hacer una cesárea sin anestesia).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 71 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 28 años, cursando un embarazo de 39 semanas inicia trabajo de parto. Al tacto vaginal, tiene feto en cefálica, con cuello borrado, con 8 cm de dilatación y membranas íntegras. Se realiza un registro fetal intraparto, cuyo trazado se muestra a continuación: INSERTAR FOTO ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Mantener una conducta expectante
B) Realizar rotura de membranas
C) Realizar cesárea de urgencia
D) Iniciar oxitocina endovenosa
E) Solicitar perfil biofísico

Respuesta C. Era un registro ominoso, con múltiples desaceleraciones variables complejas. Fal- taba un buen trazado de la dinámica uterina, ya que en ese parecía no haber contracciones.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 148 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 27 años, multípara, cursando un embarazo de 38 semanas, en trabajo de parto en fase activa, se produce rotura de membranas, con salida de líquido amniótico claro, luego de lo cual la frecuencia cardíaca fetal disminuye a 90 latidos por minuto. ¿Cuál es la conducta inmediata que debe realizarse en esta paciente?

A) Realizar perfil biofísico
B) Realizar cesárea
C) Cambiar de posición a la madre
D) Realizar tacto vaginal
E) Realizar Doppler fetal

Respuesta D. Tiene una procidencia de cordón, por lo que se debe interrumpir de inmediato. El TV ayuda a 1. descomprimir el cordón umbilical y 2. determinar las condiciones obstétricas para la vía más expedita de parto (aunque suele ser por cesárea en la procidencia de cordón). La bradicardia también obliga a interrumpir por la vía más expedita (por tanto, hay que hacer también un TV).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 169 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 37 años, está en trabajo de parto de término. Está con anestesia raquídea y oxitocina en goteo. Presenta registro electrónico fetal tipo III y se constatan 6 contracciones uterinas cada 10 minutos. La conducta más adecuada es:

A) Poner a la madre en decúbito lateral izquierdo
B) Suspender la oxitocina
C) Realizar rotura artificial de membrana
D) Dar oxígeno a la madre
E) Administrar tocolíticos

Respuesta B. Tiene un registro ominoso, con taquisistolía, así que lo primero a hacer es suspender la oxitocina. Sin embargo, también hay que lateralizar, dar O2, etc, por lo que es una mala pregunta.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 22 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 29 años, cursando un embarazo de 36+2 semanas, acude al servicio de urgencia por contracciones uterinas dolorosas y frecuentes. Al examen físico tiene altura uterina: 32 cm, estimación de peso fetal en percentil 25 y se constatan 5 contracciones uterinas cada 10 minutos. El tacto vaginal demuestra dilatación cervical de 4 cm y membranas íntegras. Se auscultan los latidos cardiofetales a 140x' y se realiza registro fetal, que se muestra a continuación: ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar cesárea de urgencia
B) Realizar rotura de membranas
C) Inducir con misoprostol
D) Inducir con goteo oxitócico
E) Controlar en dos horas

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Realizar cesárea de urgencia (opción A). La resolución quirúrgica urgente constituye la única medida definitiva capaz de controlar el foco séptico, revertir la isquemia o evitar la muerte materna/fetal frente a este compromiso clínico severo.

3.01.2.018 Pelviperitonitis

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 20.11 Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EIP / PIP): Criterios de Hager, Clasificación de Monif y Esquemas Terapéuticos

QUÉ HAY QUE SABER

- Pelviperitonitis: extensión de un PIP al peritoneo pélvico (Monif II) o rotura de un absceso tubo-ovárico (Monif IV, peritonitis difusa y shock séptico).
- Sospecha: dolor hipogástrico intenso con signos de irritación peritoneal (Blumberg), fiebre alta, dolor a la movilización cervical y anexial, flujo purulento; descartar ectópico con beta-hCG.
- Estudio: hemograma, PCR, hemocultivos, cultivo endocervical, ecografía transvaginal (absceso, líquido libre) o TAC si hay duda con apendicitis.
- Manejo inicial: hospitalizar, hidratación, antibióticos EV (ceftriaxona + doxiciclina + metronidazol, o clindamicina + gentamicina), retirar DIU si lo tiene y está grave.
- Absceso tubo-ovárico >7–8 cm, sin respuesta a 48–72 h o rotura: drenaje percutáneo o cirugía (laparoscopía/laparotomía).
- Seguimiento completo: completar 14 días de antibióticos, control clínico a las 72 h, tratar a la pareja, tamizaje de ITS (VIH, VDRL) y consejería sobre secuelas (infertilidad, ectópico).

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 95

Una paciente de 25 años consulta en el servicio de urgencias por dolor abdominal de 3 días de evolución, que ha aumentado de intensidad. Es sexualmente activa y utiliza dispositivo intrauterino tipo T de cobre como método anticonceptivo. Refiere que el dolor es más intenso en el abdomen bajo, mayor al lado derecho. En su examen físico tiene frecuencia cardíaca 108 por minuto y presión arterial 110/70 mmHg, con dolor a la palpación abdominal baja y signo de Blumberg esbozado a derecha. La especuloscopía muestra cuello uterino con secreción purulenta y el tacto vaginal demuestra dolor a la presión cervical y a la palpación de ambos anexos, mayor a derecha. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Embarazo ectópico
B) Aborto séptico
C) Torsión ovárica
D) Pelviperitonitis
E) Apendicitis aguda

Respuesta D. Es un proceso inflamatorio pelviano: cervicitis purulenta, dolor a la movilización cervical y anexial bilateral. El signo de Blumberg indica compromiso peritoneal, es decir, pelviperitonitis. Se pide ecografía transvaginal para descartar absceso tubo-ovárico y se tratan con antibióticos de amplio espectro. El DIU no se retira de rutina.

3.01.2.019 Quiste ovárico torcido

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 20.16 Urgencias Ginecológicas Quirúrgicas: Torsión Anexial y Rotura de Quiste Ovárico Hemorrágico

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospecha: dolor pélvico unilateral súbito, lancinante y con paroxismos, con náuseas y vómitos profusos, en mujer con quiste ovárico conocido (sobre todo teratoma de 5–10 cm).
- Examen: masa anexial dolorosa, defensa localizada; fiebre baja y leucocitosis si hay necrosis. Beta-hCG para descartar ectópico.
- Ecografía Doppler: ovario aumentado y edematoso con folículos periféricos, signo del remolino, flujo ausente o disminuido (un Doppler normal no descarta la torsión).
- Manejo inicial: analgesia, régimen cero y laparoscopía de urgencia sin demora: la isquemia progresa en horas.
- Detorsión conservadora aunque el ovario se vea violáceo, con cistectomía; ooforectomía solo si hay necrosis gangrenosa evidente o sospecha de malignidad.
- Seguimiento completo: control postoperatorio con ecografía a las 6–8 semanas, resultado de biopsia del quiste y vigilancia de recurrencia.

PREGUNTAS (7)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 58

Una paciente de 30 años consulta por dolor en la fosa ilíaca derecha, asociado a vómitos alimentarios, que inició hace 48 horas. Al examen físico: FC 110 por minuto, resistencia muscular involuntaria en la fosa ilíaca derecha. La ecografía transvaginal visualiza un tumor anexial derecho quístico multiloculado, de 10 cm de diámetro, con ausencia de flujo al Doppler color. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Apendicitis aguda
B) Embarazo ectópico
C) Proceso inflamatorio pélvico
D) Tumor anexial torcido
E) Cáncer de ovario

Respuesta D. Aunque la clínica imita una apendicitis, el tumor anexial de 10 cm sin flujo Doppler es una torsión ovárica. El tamaño mayor a 10 cm es el factor de riesgo de mayor peso, y aun con Doppler normal, la sospecha clínica obliga a operar.

Pregunta de práctica

Mujer de 26 años, nulípara, consulta por dolor súbito en fosa ilíaca izquierda de 3 horas, intensidad 9/10, con 3 episodios de vómitos. Test de embarazo negativo. La ecografía Doppler muestra un ovario izquierdo de 8 cm, edematoso, con un quiste de 6 cm compatible con teratoma, y ausencia de flujo venoso. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Analgesia endovenosa y alta con control ambulatorio
B) Laparoscopía de urgencia para detorsión ovárica conservadora
C) Ooforectomía izquierda abierta, sin intentar destorcer
D) Antibióticos endovenosos por sospecha de proceso inflamatorio pélvico
E) Punción ecoguiada del quiste para aliviar el dolor

Respuesta B. Dolor unilateral hiperagudo con vómitos profusos, un quiste de riesgo y ausencia de flujo venoso en la ecografía Doppler: es una torsión anexial. La conducta es laparoscopía de urgencia con detorsión ovárica conservadora, preservando el órgano aunque se vea comprometido.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 51 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 20 años, consulta por dolor intenso en la fosa iliaca izquierda, de 3 horas de evolución, que se ha asociado a vómitos. Al examen físico está afebril, con signos vitales normales y al examen abdominal presenta intenso dolor a la palpación de la fosa iliaca izquierda, con signo de Blumberg y resistencia muscular. No presenta atraso menstrual. Se solicita ecografía ginecológica, que muestra útero y ovario derecho normales y ovario izquierdo, con aumento de tamaño y presencia de un quiste de 6 x 4 cm, sin flujo al doppler y sin visualización de líquido peritoneal libre. El diagnóstico más probable es:

A) Endometrioma
B) Cuerpo lúteo hemorrágico
C) Quiste ovárico torcido
D) Teratoma ovárico
E) Embarazo ectópico

Respuesta C. Tanto la clínica (algia pélvica aguda intensa, con náuseas y vómitos), como la presencia de un tumor anexial (principal factor de riesgo), como el doppler alterado son muy sugerentes de torsión ovárica.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 63 · texto original del banco, sin revisar

Mujer joven con dolor pélvico súbito, náuseas, vómitos y masa anexial dura de 7 cm al examen. ¿Diagnóstico más probable?

A) Quiste ovárico torsionado
B) Embarazo ectópico roto
C) Absceso tubo-ovárico
D) Mioma pediculado torsionado
E) Endometrioma roto

Respuesta A. Diagnóstico: Quiste ovárico torsionado (opción A). Quiste ovárico torsionado. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 162 · texto original del banco, sin revisar

Paciente femenina, en su día 10 de ciclo menstrual, dolor abdominal súbito, con tumor anexial 7 cm, diagnóstico mas probable

A) Torsión ovárica
B) Endometrioma
C) Diverticulitis aguda
D) Hemograma y VHS
E) Ecografía

Respuesta A. Diagnóstico: Torsión ovárica (opción A). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 113 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 24 años, usuaria de anticonceptivos orales, cuya última regla fue hace 8 días, consulta por dolor en la fosa ilíaca derecha, de inicio súbito, intenso, que se ha asociado a náuseas y vómitos alimentarios, en una oportunidad. Al examen físico, tiene FC: 88x', PA: 120/78 mmHg, examen abdominal con dolor a la palpación de la fosa ilíaca derecha y del hipogastrio. Al examen ginecológico, además, se palapa una masa anexial derecha de 6 cm. Se solicita ecografía transvaginal, que visualiza útero de tamaño y paredes normales, endometrio de 6 mm de diámetro, presencia de una lesión anexial derecha quística de 6 cm, sin líquido libre, además, no es posible visualizar el apéndice cecal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Absceso tubo ovárico
B) Apendicitis aguda
C) Quiste ovárico torcido
D) Embarazo ectópico
E) Vólvulo de ciego

Respuesta C. Diagnóstico: Quiste ovárico torcido (opción C). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 175 · texto original del banco, sin revisar

Una niña de 17 años, con antecedente de menarquia a los 15 años y cuyas reglas son irregulares, cada 30 a 40 días. Consulta por dolor pélvico muy intenso, asociado a sudoración y vómitos. Al preguntarle dirigidamente, niega actividad sexual. Al examen físico se observa adolorida, quejumbrosa y se palpa una masa hipogástrica de 7 cm de diámetro, muy dolorosa. El diagnóstico más probable es:

A) Cáncer de ovario
B) Absceso tuboperitoneal
C) Síntomas de aborto
D) Torsión anexial
E) Pelviperitonitis

Respuesta D. Diagnóstico: Torsión anexial (opción D). Parece una torsión ovárica clásica: dolor intenso, asociado a vómitos, de inicio súbito.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

3.01.2.020 Mastitis abscedada

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 19.19 Infecciones Puerperales: Endometritis Puerperal y Patología Mamaria (Mastitis Congestiva vs Infecciosa vs Absceso)

QUÉ HAY QUE SABER

- Absceso mamario: complicación de una mastitis mal tratada o sin tratar (3–10%); masa fluctuante, muy dolorosa, con eritema y fiebre persistente pese a 48–72 h de antibióticos.
- Confirmación: ecografía mamaria (colección hipoecogénica), que además guía el drenaje.
- Tratamiento de elección: punción aspirativa ecoguiada (repetible) en abscesos pequeños; drenaje quirúrgico (incisión periareolar o radial) si es grande, multiloculado o con piel comprometida.
- Antibiótico antiestafilocócico: cloxacilina 500 mg c/6 h VO por 10–14 días; cultivo del pus y cobertura de SAMR (clindamicina o cotrimoxazol) si no responde.
- Lactancia: mantenerla desde la mama sana y vaciar la afectada (extracción); amamantar de ella si la incisión está lejos del pezón.
- Seguimiento completo: control clínico y ecográfico hasta la resolución; absceso recurrente o masa persistente fuera del puerperio obliga a descartar carcinoma.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 64 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 32 años, puérpera de parto vaginal eutócico de 8 días de evolución, consulta por dolor mamario derecho, mayor durante la lactancia. Al examen físico tiene T°: 38,5°C, FC: 100x', PA: 120/78 mmHg. Ambas mamas se observan eritematosas, con grietas visibles en el pezón y, en el lado derecho, se palpa aumento de volumen doloroso y fluctuante a la palpación, de 6 cm de diámetro, con aumento de la temperatura local y eritema. El examen ginecológico no tiene alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Antibióticos endovenosos más drenaje quirúrgico o por punción guiado por ecografía
B) Drenaje por punción
C) Suspender la lactancia materna
D) Frío local y paracetamol
E) Amoxicilina más ácido clavulánico vía oral

Respuesta C. Conducta / Tratamiento indicado: Suspender la lactancia materna (opción C). Manejo según Fase al Llegar De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 51 · texto original del banco, sin revisar

Puérpera con fiebre, eritema mamario, calor local y aumento de volumen fluctuante. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Antibiótico oral y continuar lactancia
B) Antibiótico endovenoso y suspender lactancia
C) Antiinflamatorios y masaje local
D) Antibiótico y bromocriptina para suspender lactancia
E) Drenaje quirúrgico y antibióticos

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Drenaje quirúrgico y antibióticos (opción E). Drenaje quirúrgico y antibióticos. La resolución quirúrgica urgente constituye la única medida definitiva capaz de controlar el foco séptico, revertir la isquemia o evitar la muerte materna/fetal frente a este compromiso clínico severo.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 73 · texto original del banco, sin revisar

Paciente puérpera con mama eritematosa con calor local y aumento de volumen fluctuante de 7 cm, además de iniciar atb, se debe; a. Drenaje de absceso mamario,

B) Suspender LM
B) Psoriasis
C) Dermatitis atópica
D) Dermatitis de contacto
E) Liquen plano

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Suspender LM, Psoriasis) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

Pregunta de práctica

Puérpera de 26 años, a las 3 semanas de un parto vaginal, con lactancia materna exclusiva. Consulta por dolor en la mama derecha y fiebre de 38,8 °C. Hace 6 días se diagnosticó mastitis y se indicó cloxacilina oral, que ha cumplido. Al examen hay una zona eritematosa en el cuadrante superoexterno con un área fluctuante de 3 cm, muy dolorosa. La ecografía muestra una colección hipoecogénica de 3 cm. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Solicitar mamografía y biopsia core antes de tratar
B) Cambiar a ciprofloxacino oral y suspender la lactancia
C) Indicar cabergolina para inhibir la lactancia y compresas frías
D) Punción aspirativa ecoguiada del absceso, mantener antibiótico antiestafilocócico y la lactancia
E) Continuar la misma cloxacilina por 14 días más, sin otra intervención

Respuesta D. La masa fluctuante con colección ecográfica tras una mastitis tratada corresponde a un absceso mamario. Debe drenarse (punción ecoguiada en abscesos pequeños; quirúrgico si es grande o multiloculado), manteniendo el antibiótico antiestafilocócico y la lactancia. El antibiótico solo no basta y suspender la lactancia empeora la estasis.

3.01.2.021 Trabajo parto distócico

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **No requiere**

Dónde se enseña: Tema 19.17 Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO)

QUÉ HAY QUE SABER

- Distocia: trabajo de parto que no progresa. Fase activa prolongada: dilatación <1 cm/h; detención: sin progreso de dilatación por ≥2–4 h con buena dinámica (o descenso en expulsivo).
- Evaluar las 3 P: potencia (hipodinamia), pasajero (macrosomía, variedades posteriores, deflexión) y pasaje (desproporción céfalo-pélvica: cabeza no desciende, suturas cabalgadas, caput voluminoso).
- Hipodinamia con condiciones: amniotomía y conducción con oxitocina; DCP o detención en fase activa con buena dinámica → cesárea.
- Distocia de hombros (signo de la tortuga, típica en macrosomía y diabetes): pedir ayuda, McRoberts + presión suprapúbica (resuelve >70%), luego maniobras internas (Rubin, Woods, Jacquemier).
- Nunca Kristeller ni tracción forzada de la cabeza (lesión del plexo braquial); Zavanelli o fractura de clavícula son de último recurso.
- Manejo del médico general: reconocer, monitorizar bienestar fetal, iniciar medidas y derivar; vigilar hemorragia posparto por atonía tras parto prolongado. Seguimiento: no requiere.

PREGUNTAS (5)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 141

Embarazada de 39 semanas en trabajo de parto activo. Lleva 4 horas en fase activa con la dilatación cervical detenida en 5 centímetros, con dinámica uterina regular, de 4 contracciones de 45 segundos cada 10 minutos, y la presentación fetal ya encajada. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Fórceps
B) Conducción con oxitocina
C) Esperar en observación 2 horas más
D) Cesárea de urgencia
E) Vacuum extractor

Respuesta B. Detención de la fase activa por dinámica insuficiente, sin sufrimiento fetal ni desproporción, no es indicación directa de cesárea. Primero se intenta conducir el trabajo de parto con oxitocina, para mejorar la dinámica uterina.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 168

Paciente en trabajo de parto de término. Durante el expulsivo se produce el desprendimiento de la cabeza fetal, pero no ocurre la rotación ni el descenso de los hombros. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Traccionar la cabeza fetal
B) Realizar compresiones suprapúbicas
C) Realizar hiperflexión de las caderas (maniobra de McRoberts)
D) Realizar rotación manual de los hombros hacia anterior (maniobra de Rubin)
E) Realizar extracción del brazo posterior (maniobra de Jacquemier)

Respuesta C. La maniobra de McRoberts es siempre el manejo inicial en la distocia de hombros: resuelve la mayoría de los casos y tiene muy baja morbilidad. Las maniobras internas y la tracción cefálica quedan para después, o están prohibidas.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 105 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 30 años, mul`para de uno, con antecedente de parto vaginal de recién nacido de 4.000 gramos, cursa nuevo embarazo de término con estimación de peso fetal de 3.800 gramos. Ingresa en trabajo de parto en fase latente, recibiendo anestesia peridural a los 4 cm de dilatación. Ha permanecido con 6 cm de dilatación en las últimas 3 horas y se palpa cabeza fetal en el segundo plano de Hodge, en variante occípito-ilíaca izquierda posterior. Presenta cuatro contracciones uterinas de 50 segundos de duración cada 10 minutos. ¿Cuál es la causa de la demora en el avance de su trabajo de parto?

A) Dinámica uterina insuficiente
B) Distocia de posición
C) Desproporción céfalo-pélvica
D) Macrosomía fetal
E) Distocia de presentación

Respuesta B. Tiene buena dinámica (3-5 contracciones cada 10 minutos). Está en presentación cefálica de vértice (punto de referencia es el occipucio), así que no hay distocia de presentación. No Gene criterios de macrosomía fetal (mayor a 4.500 gramos). Tiene posición occipital posterior persistente, lo que es compatible con una distocia de posición. La posición es la rotación del feto en relación a la pelvis

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 33 · texto original del banco, sin revisar

Una mujer de 24 años, primípara, en trabajo de parto, con dilatación completa, membranas rotas y buena dinámica. Cuenta con episiotomía mediolateral. Se produce desprendimiento de la cabeza fetal, sin embargo, el resto del cuerpo no progresa, luego de 5 minutos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Ampliar la epifisiotomía
B) Realizar tracción continua por 5 minutos
C) Realizar flexión de las caderas de la madre y realizar compresión suprapúbica
D) Girar el hombro posterior, en el sentido de las agujas del reloj
E) Poner a la madre en posición genupectoral y realizar suave tracción de la cabeza fetal

Respuesta C. El manejo de la retención de hombros sigue un orden específico: Primero: realizar hiperflexión de la cadera (maniobra de Mc Roberts). Segundo: realizar compresión suprapúbica (maniobra de Manzzanti / Rubbins). Tercero: intentar rotación del tronco u otra maniobra para sacar el hombro. De no funcionar nada se hacen maniobras más invasivas como sinfisiotomía púbica o fractura de la clavícula fetal.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 102 · texto original del banco, sin revisar

Una mujer de 24 años, primípara, en trabajo de parto avanzado. Se produce desprendimiento de la cabeza fetal, sin embargo, no se produce la rotación de la cabeza, ni el descenso de los hombros. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Pivotear la cabeza
B) Realizar compresión de la región suprapúbica (maniobra de Kristeller)
C) Rotar el hombro hacia anterior
D) Realizar hiperflexión de las caderas (maniobra de McRoberts)
E) Realizar fórceps

Respuesta D. El manejo de la retención de hombros es primero la D, luego la B y luego la C, seguido de maniobras más agresivas (fracturar la clavícula del RN, sinfisiotomía púbica).

Conocimientos generales 16 códigos

3.01.3.001 Control prenatal

Dónde se enseña: Tema 19.1 Control Prenatal de Bajo Riesgo: Calendario, Suplementación (Ácido Fólico, Calcio, Fierro) y Exámenes por Trimestre

QUÉ HAY QUE SABER

- Primer control idealmente antes de las 12 semanas (ingreso precoz): anamnesis de riesgo, PA, IMC, examen físico y mamario, y datación por FUM confiable y ecografía precoz.
- Exámenes del 1.er trimestre: grupo, Rh y Coombs indirecto, hemograma, VDRL/RPR, VIH (con consentimiento), glicemia de ayuno, urocultivo, orina completa, PAP si corresponde; hepatitis B y Chagas según norma.
- Segundo y tercer trimestre: PTGO 75 g a las 24–28 semanas; repetir VDRL, VIH y hemograma a las 28–32 semanas; cultivo vaginorrectal de estreptococo grupo B a las 35–37 semanas.
- Suplementación: ácido fólico 0,4–1 mg/día (4–5 mg si alto riesgo de DTN) desde 3 meses antes hasta las 12 semanas; calcio 1.000–1.500 mg/día desde las 12–16; hierro 30–60 mg/día desde las 16–20.

- Ecografías de rutina: 11–14 semanas (datación, translucencia nucal, Doppler uterinas), 20–24 (anatomía y cervicometría) y 30–34 (crecimiento, placenta, líquido).
- Vacunas: influenza en cualquier trimestre, dTpa desde las 28 semanas; derivar a alto riesgo ante HTA, diabetes, RCF, embarazo múltiple u otra patología. Educación en signos de alarma y plan de parto (Chile Crece Contigo).

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 38

Paciente de 25 años, vegana estricta, con antecedente de un parto hace 6 meses de un hijo con mielomeningocele, consulta porque desea planificar un nuevo embarazo. **¿Qué suplemento se le debe indicar de manera prioritaria?**

A) Vitamina B12
B) Ácido fólico
C) Calcio
D) Hierro
E) Ácidos grasos omega-3

Respuesta B. La dieta vegana estricta se asocia sobre todo a déficit de vitamina B12, pero el antecedente de un hijo con defecto del tubo neural manda por sobre eso: se indica ácido fólico en dosis alta (4 mg/día), idealmente desde 3 meses antes del embarazo y hasta la semana 12.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 42 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 35 años, cursando un embarazo de 42 semanas acude a control. No presenta dinámica uterina y la altura uterina es acorde a la edad gestacional. Los latidos cardiofetales son de 125 lpm. Se realiza ecografía obstétrica que estima un peso fetal de 3.600 g, y visualiza un bolsillo mayor de líquido amniótico de 3 cm. El Doppler fetal es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Citar a control en 3 días
B) Citar para inducción del parto en 3 días
C) Inducir el parto en este momento con misoprostol
D) Realizar cesárea
E) Solicitar test de tolerancia a las contracciones

Respuesta C. Desde las 42 semanas se considera un embarazo postérmino, con riesgos asociados (sufrimiento fetal el más importante) y se debe interrumpir. Si está todo bien (como en este caso), la vía de elección es vaginal. De hecho, se recomienda interrumpir desde las 41 semanas y se considera aceptable hacerlo desde las 39 semanas, ya que no se ha visto mayor riesgo en hacerlo. En resumen, 42 semanas: “se de

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 17 · texto original del banco, sin revisar

Glucosuria en embarazo de 24 semanas con HGT normal es indicativo de a. Normal

B) Hallazgo precoz de preeclampsia
C) Hallazgo precoz de daño renal crónico
D) Hallazgo de alteración de tubo proximal (no recuerdo muy bien)
D) Interrupción del embarazo
E) Maduración pulmonar y observación

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Hallazgo precoz de preeclampsia, Hallazgo precoz de daño renal crónico) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación de

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 95 · texto original del banco, sin revisar

¿Como es la suplem nientación con ácido fólico en embarazo según la guía perinatal?: a. 3 meses preconcepcional hasta las 12 semanas de edad gestacional

A) Interrupción del embarazo
B) Maduración pulmonar y observación
C) Cesárea de urgencia
D) Inducción del parto
E) Control prenatal habitual

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Interrupción del embarazo). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Maduración pulmonar y observación, Cesárea de urgencia) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presen

3.01.3.002 Derechos y aspectos legales de la embarazada y su pareja

Dónde se enseña: Tema 19.10 Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030 · Tema 21.14 Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Ley 21.030: despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo solo en 3 causales: riesgo vital materno (sin límite de semanas), inviabilidad fetal letal (dos especialistas concordantes) y violación (hasta 12 semanas; 14 si es menor de 14 años).
- Objeción de conciencia: personal, manifestada previamente por escrito; el objetor debe derivar de inmediato a un médico no objetor y no puede objetar si hay riesgo vital inminente sin otro médico disponible.
- Secreto profesional: la atención de un aborto en curso o complicado nunca se condiciona a denuncia o confesión.
- Protección laboral: fuero maternal desde la concepción hasta 1 año después del posnatal, descanso prenatal de 6 semanas y posnatal de 12 semanas más posnatal parental, derecho a alimentar al hijo (1 hora diaria) hasta los 2 años y sala cuna según tamaño de la empresa.
- Derecho a acompañamiento por una persona de su elección durante el trabajo de parto y parto, a información y a un trato digno; la pareja puede usar parte del posnatal parental y tiene permiso de paternidad.
- Garantías: GES de parto prematuro, VIH, analgesia del parto, entre otros; programa Chile Crece Contigo desde el primer control prenatal.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 118

Paciente de 22 años, con un embarazo de 18 semanas, acude a urgencias solicitando la interrupción voluntaria del embarazo. No presenta ninguna de las tres causales legales vigentes en Chile. **¿Cuál es la conducta médica correcta?**

A) Informar que la interrupción no procede legalmente y derivar a consejería
B) Realizar la interrupción por solicitud de la paciente
C) Derivar de urgencia a matrona
D) Hospitalizar para observación
E) Referir a comité de ética del hospital

Respuesta A. La ley chilena solo permite la interrupción en las tres causales: riesgo vital, inviabilidad fetal letal y violación. Sin ninguna de ellas presente, no procede, y la conducta es informar, orientar y derivar a apoyo psicosocial.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 118

Paciente de 22 años con embarazo de 18 semanas acude a urgencias solicitando la interrupción voluntaria del embarazo. No presenta ninguna de las tres causales legales vigentes en Chile. **¿Cuál es la conducta médica correcta?**

A) Informar que la interrupción no procede legalmente y derivar a consejería
B) Realizar la interrupción por solicitud de la paciente
C) Derivar de urgencia a matrona
D) Hospitalizar para observación
E) Referir al comité de ética del hospital

Respuesta A. La Ley 21.030 permite la interrupción solo dentro de las tres causales taxativas. Sin ninguna de ellas presente, la interrupción no procede aunque la paciente la solicite: el médico debe informar, orientar y derivar a apoyo psicosocial, no ejecutar el procedimiento ni delegarlo sin fundamento legal.

3.01.3.003 Determinación de edad gestacional

Dónde se enseña: Tema 19.1 Control Prenatal de Bajo Riesgo: Calendario, Suplementación (Ácido Fólico, Calcio, Fierro) y Exámenes por Trimestre

QUÉ HAY QUE SABER

- Edad gestacional = semanas desde el 1.er día de la última regla (FUM); fecha probable de parto por regla de Naegele: FUM + 7 días – 3 meses (+1 año).
- La FUM solo es confiable si es segura, con ciclos regulares y sin uso de ACO, lactancia o embarazo reciente en los 3 meses previos.
- Ecografía precoz con longitud céfalo-nalgas (7–14 semanas) es el método más preciso (±3–5 días); si difiere >5–7 días de la FUM, se corrige por ecografía.
- Segundo trimestre: biometría (DBP, CC, fémur) con error ±1–2 semanas; 3.er trimestre poco confiable (±3 semanas), el cerebelo ayuda si hay RCF.

- Altura uterina: el fondo llega al pubis a las 12 semanas, al ombligo a las 20 y entre 20 y 32 semanas mide ~semanas en cm; orienta pero no data.
- La EG correcta es clave para diagnosticar RCF, parto prematuro y embarazo prolongado (≥41 semanas → interrupción).

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 90

Paciente con antecedente de reglas irregulares, que ocurren cada 45 a 60 días, se realiza un test de embarazo que resulta positivo. Refiere una FUR segura hace 6 semanas y se solicitó una hCG plasmática de 25.000 UI/L, que corresponde a una edad gestacional entre 6 y 7 semanas. **¿Cuál es la forma ideal para determinar la edad gestacional en esta paciente?**

A) FUR segura
B) Medición de la altura uterina
C) Determinación de hCG plasmática en 48 horas
D) Medición ecográfica del saco gestacional
E) Medición ecográfica de la longitud cráneo-nalgas

Respuesta E. Con ciclos irregulares la FUR no es confiable, aunque la paciente la recuerde con seguridad. El mejor método es la ecografía precoz, y en el primer trimestre (hasta las 14 semanas) manda la longitud cráneo-nalgas, con error de pocos días. El saco gestacional es menos preciso; la hCG y la altura uterina no sirven para datar el embarazo.

3.01.3.004 Lactancia

Dónde se enseña: Tema 18.4 Lactancia Materna Exclusiva, Alimentación Complementaria & Suplementación (Vitamina D / Fierro)

QUÉ HAY QUE SABER

- Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y complementada hasta los 2 años o más; reduce diarrea, otitis, neumonía y muerte súbita, y en la madre el cáncer de mama y ovario.
- Fomento: apego piel a piel y amamantamiento en la primera hora, alojamiento conjunto, libre demanda, sin chupetes ni relleno en los primeros días; evaluar acople (boca abierta, labio inferior evertido, más areola visible arriba).
- Contraindicaciones maternas: VIH (en Chile se suspende), HTLV-1/2, TBC bacilífera activa no tratada (separar transitoriamente), quimioterapia, drogas ilícitas; del lactante: galactosemia clásica.
- No contraindican: mastitis, hepatitis B (con vacuna + inmunoglobulina al RN), hepatitis C, la mayoría de antibióticos y antihipertensivos.
- Problemas frecuentes: grietas (corregir acople), congestión (vaciamiento, frío/calor), mastitis (cloxacilina sin suspender la lactancia); la lactancia exclusiva con amenorrea es anticonceptiva los primeros 6 meses (MELA).
- Suplemento del lactante: vitamina D 400 UI/día desde el mes hasta los 12 meses; hierro 1 mg/kg/día desde los 4 meses (prematuro 2–3 mg/kg desde los 2 meses).

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 55

Puérpera en su décimo día posparto, con PCR para SARS-CoV-2 positiva y síntomas leves. **¿Cuál es la conducta respecto a la lactancia?**

A) Suspender la lactancia hasta completar 10 días de aislamiento
B) Mantener la lactancia con uso de mascarilla
C) Extraer la leche y pasteurizarla antes de dársela al bebé
D) Suspender la lactancia y cambiar a fórmula
E) Mantener la lactancia sin restricciones

Respuesta B. La COVID-19 materna no contraindica la lactancia: el virus no se transmite por la leche y la lactancia protege al lactante. Se mantiene con medidas para evitar el contagio respiratorio: mascarilla, higiene de manos y de mamas. Suspenderla o pasteurizar la leche no tiene beneficio.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 68 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente es diagnosticada de Covid-19, con inicio de síntomas hace 10 días, mientras cursaba un embarazo de término, manteniendo solo algún grado de tos. Presentó parto vaginal hace dos horas, con recién nacido sano y su puerperio inmediato ha sido normal hasta ahora. ¿Qué recomendación se debe dar acerca del momento en el que se debe iniciar la lactancia materna?

A) Posponerla hasta tener la madre una PCR SARS-Cov2 negativa
B) Posponerla hasta que se hayan cumplido 14 días desde el diagnóstico
C) Posponerla hasta que se hayan cumplido 28 días desde el diagnóstico
D) Iniciarla de inmediato con mascarilla
E) Iniciarla de inmediato sin protección

Respuesta C. La alternativa correcta es la C (Posponerla hasta que se hayan cumplido 28 días desde el diagnóstico). Dopamina inhibe la prolactina → antidopaminérgicos (antipsicóticos) pueden causar galactorrea incluso en no embarazadas. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

3.01.3.005 Manejo de la salud de la mujer climatérica

Dónde se enseña: Tema 20.12 Climaterio, Menopausia y Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH): Ventana de Oportunidad y Riesgos

QUÉ HAY QUE SABER

- Control de salud de la mujer climatérica (desde ~45 años): pesquisar síntomas con escala MRS, factores de riesgo cardiovascular, osteoporosis, cánceres ginecológicos y salud mental.
- Tamizaje: PA, IMC y perímetro de cintura, glicemia y perfil lipídico, mamografía cada 2 años (50–69 GES), PAP o test VPH según programa, densitometría desde los 65 o antes con factores de riesgo.
- Estilo de vida: actividad física regular, dieta con calcio (1.200 mg/día) y vitamina D (800 UI/día), dejar de fumar, alcohol moderado, control de peso.
- TRH indicada para síntomas moderados a severos dentro de la ventana (<60 años o <10 años de menopausia): estrógeno + progestágeno si tiene útero, estrógeno solo si no; vía transdérmica si hay riesgo trombótico.
- Síndrome genitourinario: estrógeno vaginal local y lubricantes, seguros incluso en la mayoría de las pacientes con contraindicación sistémica.
- Revisar anticoncepción hasta 12 meses de amenorrea (>50 años) y reevaluar anualmente riesgos y beneficios de la terapia.

Sin pregunta

3.01.3.006 Métodos naturales para la regulación de la fecundidad

Dónde se enseña: Tema 20.8 Anticoncepción y Planificación Familiar: Criterios Médicos de Elegibilidad OMS y Píldora de Emergencia

QUÉ HAY QUE SABER

- Métodos basados en la abstinencia periódica en el período fértil: calendario (Ogino-Knaus), temperatura basal, moco cervical (Billings) y sintotérmico; requieren ciclos regulares y motivación de la pareja.
- Calendario: período fértil desde el ciclo más corto – 18 hasta el ciclo más largo – 11 (registro de 6–12 ciclos). Temperatura basal: alza de 0,3–0,5 °C tras la ovulación; infértil desde el 3.er día de alza.
- Moco cervical: filante, transparente y elástico (clara de huevo) en el período fértil; abstinencia hasta 4 días después del día cúspide.
- MELA: lactancia exclusiva, amenorrea y <6 meses posparto, con >98% de eficacia mientras se cumplan las tres condiciones.
- Eficacia menor que los métodos modernos (falla con uso típico ~15–25%); no protegen de ITS; poco confiables con ciclos irregulares, posparto, perimenopausia o adolescencia.
- El coito interrumpido no se recomienda como método por su alta tasa de falla; ofrecer consejería sobre métodos más eficaces y anticoncepción de emergencia.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 28 años, con ciclos regulares, que por convicciones personales desea usar un método natural de regulación de la fecundidad. Le explican uno basado en que ella reconozca diariamente los cambios del moco cervical, que se vuelve abundante, transparente y elástico en el período fértil. **¿A qué método corresponde?**

A) Método del calendario (Ogino-Knaus)
B) Coito interrumpido
C) Método de la temperatura basal
D) Método de la lactancia y amenorrea (MELA)
E) Método de la ovulación (Billings)

Respuesta E. El método de Billings identifica el período fértil por la autoobservación del moco cervical, que con el alza estrogénica preovulatoria se vuelve filante y transparente. El calendario usa la duración de ciclos previos y la temperatura basal detecta el alza térmica posovulatoria por progesterona. Todos tienen alta tasa de falla con uso típico.

3.01.3.007 Mortalidad perinatal y materna

Dónde se enseña: Tema 21.7 Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud

QUÉ HAY QUE SABER

- Mortalidad materna: muerte durante el embarazo o hasta 42 días tras su término por causa relacionada o agravada por el embarazo; se expresa por 100.000 nacidos vivos.
- En Chile es baja en el contexto latinoamericano y se debe principalmente a enfermedades concurrentes (preexistentes), síndrome hipertensivo del embarazo, aborto y hemorragias; edad materna avanzada es un factor creciente.
- Mortalidad perinatal: mortinatos (muerte fetal tardía) + muertes neonatales precoces (primeros 7 días) por 1.000 nacimientos; refleja la calidad de la atención obstétrica y neonatal.
- Causas perinatales principales: malformaciones congénitas, prematurez y sus complicaciones, asfixia, insuficiencia placentaria y RCF.
- Estrategias preventivas: control prenatal precoz, atención profesional del parto (>99% institucional en Chile), detección y derivación del alto riesgo, planificación familiar y regionalización perinatal.
- Toda muerte materna se notifica y se audita para identificar causas evitables.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

El equipo de estadísticas de un Servicio de Salud debe calcular la mortalidad materna regional del último año, considerando las muertes de mujeres durante el embarazo o dentro de los 42 días siguientes a su término, por causas relacionadas con este o agravadas por él. **¿Cuál es el denominador utilizado para calcular la razón de mortalidad materna?**

A) Nacidos vivos, expresado por 100.000
B) Mujeres en edad fértil
C) Total de embarazos registrados
D) Total de partos atendidos, por 1.000
E) Población femenina total

Respuesta A. La razón (habitualmente llamada tasa) de mortalidad materna se calcula como muertes maternas dividido por nacidos vivos del mismo período y lugar, por 100.000. Se usa nacidos vivos porque el total de embarazos no se conoce con exactitud. Incluye muertes hasta 42 días posparto por causas obstétricas directas o indirectas.

3.01.3.008 Anticoncepción

Dónde se enseña: Tema 20.8 Anticoncepción y Planificación Familiar: Criterios Médicos de Elegibilidad OMS y Píldora de Emergencia

QUÉ HAY QUE SABER

- Criterios de elegibilidad OMS: categoría 1 sin restricción a 4 riesgo inaceptable. El estrógeno es categoría 4 en fumadora ≥35 años con ≥15 cigarrillos/día, migraña con aura, TVP/TEP actual o previa, trombofilia, HTA severa, cáncer de mama actual, lactancia <6 semanas y hepatopatía activa.
- Métodos reversibles de larga duración (LARC) son los más eficaces: implante de etonogestrel (3 años, el de menor falla), DIU-LNG (5–8 años, reduce sangrado) y DIU de cobre (10–12 años, sin hormonas).
- Solo progestágeno (desogestrel 75 μg continuo, inyectable trimestral, implante, DIU-LNG) es seguro cuando el estrógeno está contraindicado y en lactancia; el inyectable puede retrasar el retorno de la fertilidad.

- Combinados (ACO, parche, anillo, inyectable mensual): inhiben la ovulación; beneficios en dismenorrea, SOP y acné; la vía no cambia las contraindicaciones del estrógeno.
- Anticoncepción de emergencia: levonorgestrel 1,5 mg dosis única dentro de 72 h (no es abortivo); ulipristal hasta 120 h; DIU de cobre hasta 120 h, el más eficaz. Repetir dosis si vomita antes de 2 h.
- Ley 20.418 garantiza información y acceso a métodos, incluida la anticoncepción de emergencia para adolescentes; doble protección con preservativo para prevenir ITS.

PREGUNTAS (11)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 19

Mujer de 22 años, nulípara, con antecedente de migraña a repetición y un episodio de amaurosis fugax, desea iniciar un método anticonceptivo. Su examen físico es normal. **¿Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos indicaría a esta paciente?**

A) Anticonceptivos combinados por vía oral
B) Anticonceptivos combinados por vía transdérmica
C) Salpingoligadura
D) Dispositivo intrauterino con progestágeno
E) Anticonceptivos combinados inyectables

Respuesta D. La migraña con aura, aquí manifestada como amaurosis fugax, es categoría 4 para cualquier método con estrógeno. El DIU con progestágeno es la opción segura, a pesar de que la nuliparidad sea una contraindicación relativa menor del dispositivo.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 172

Mujer de 20 años, nuligesta, tuvo relaciones sexuales sin protección hace 72 horas y consulta por anticoncepción de emergencia. **¿Cuál es la más efectiva?**

A) Levonorgestrel 0,75 mg por una vez
B) Levonorgestrel 0,75 mg ahora y otra dosis en 12 horas
C) Método de Yuzpe
D) Anillo vaginal
E) Dispositivo intrauterino de cobre

Respuesta E. Dentro de las 120 horas postcoito, el DIU de cobre es el método de anticoncepción de emergencia más eficaz que existe, con una eficacia sobre el 99 %, muy superior al levonorgestrel oral.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 45

Paciente con un hijo de 8 meses, aún en lactancia materna exclusiva, consulta por el método anticonceptivo más adecuado. **¿Cuál es el método anticonceptivo más adecuado?**

A) Anticonceptivos orales combinados
B) Dispositivo intrauterino con levonorgestrel
C) Anillo vaginal mensual
D) Parche anticonceptivo transdérmico
E) Implante subdérmico de etonogestrel

Respuesta B. A los 8 meses postparto, ya pasadas las primeras 6 semanas, el DIU con levonorgestrel es una excelente opción de larga duración, sin estrógeno, compatible con la lactancia y sin afectar el volumen de leche.

Pregunta de práctica

Mujer de 37 años, fumadora de 20 cigarrillos al día desde los 18 años, solicita el mismo anticonceptivo combinado de etinilestradiol con drospirenona que usa su amiga. No tiene otros antecedentes y su presión arterial es 125/80. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Indicar el anticonceptivo combinado solicitado
B) Denegar el combinado y ofrecer un método solo progestágeno o DIU de cobre
C) Indicar el mismo combinado, pero en dosis reducida de estrógeno
D) Indicar el combinado por vía transdérmica en parche
E) Indicar el combinado por anillo vaginal

Respuesta B. Ser fumadora de 35 años o más con 15 o más cigarrillos al día es categoría 4 de la OMS para cualquier método con estrógeno, sin importar la vía de administración. Se debe ofrecer un método de solo progestágeno o el DIU de cobre.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 44 · texto original del banco, sin revisar

Paciente que tuvo relaciones sexuales hace 96 horas sin protección, solicita anticoncepción de emergencia. ¿Qué indicar?

A) Mifepristona 200 mg vía oral dosis única
B) DIU de cobre inmediato
C) Ulipristal acetato 30 mg vía oral
D) Levonorgestrel 0,750 mg cada 12 horas vía oral
E) Etinilestradiol 50 mcg + levonorgestrel (Yuzpe)

Respuesta D. La alternativa correcta es la D (Levonorgestrel 0,750 mg cada 12 horas vía oral). Levonorgestrel 0,750 mg cada 12 horas vía oral. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 171 · texto original del banco, sin revisar

Una mujer de 36 años, multípara de 3, con su último parto hace 3 años, tiene antecedente personal de cáncer de mama, que fue adecuadamente tratado hace 1 año. ¿Qué método de planificación familiar debe utilizar?

A) Anticonceptivos orales combinados, con microdosis de estrógeno
B) Anticonceptivos orales con estrógeno solo
C) Progestágeno inyectable
D) Anillo vaginal con progestágeno
E) Dispositivo intrauterino

Respuesta E. Por tener antecedente personal de cáncer de mama tiene absolutamente contraindicados todos los métodos hormonales. El DIU es la indicación.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 10 · texto original del banco, sin revisar

Anticoncepción en mujer con HTA reciente diagnóstico IMC 34 que tomaba ACO combinado hace 10 años:

A) Estrógenos vo
B) Estrógenos intradérmicos c. Progestágenos vo
D) Reducir dosis estrógenos
E) Anillo vaginal SIIII YO PUSE ESO
E) Hemograma y VHS

Respuesta B. Diagnóstico: Estrógenos intradérmicos c. Progestágenos vo (opción B). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 164 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 23 años, usuaria de anticonceptivos orales, desde hace 8 meses, consulta por cefalea intensa premenstrual, de 3 meses de evolución, y que dura hasta el segundo día de la menstruación. Su examen físico y neurológico es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Anticonceptivos combinados orales de ciclo extendido
B) Anticonceptivos combinados con menor dosis de estrógeno
C) Anticonceptivos combinados con menor dosis de progestágeno
D) Indicar anticonceptivos orales de progestágeno solo
E) Indicar anticonceptivos combinados inyectables

Respuesta A. Tiene una cefalea que aparece al suspender los estrógenos (cefalea catamenial), por lo que se debe usar un esquema continuo (sin días de descanso) o bien los ACO de ciclo extendido, que mantienen cierta dosis de estrógeno durante todo el ciclo. Los anticonceptivos inyectables también parecen una opción razonable para ese fin (en especial los trimestrales de progestágeno puro), pero producen aument

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 79 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 30 años, multípara de 2, con antecedente de hipertensión arterial en tratamiento, es usuaria de DIU desde hace 8 años y presenta hipermenorrea y dismenorrea de 8 meses de evolución, por lo que quiere cambiar de método anticonceptivo. ¿Cuál de las siguientes opciones es de elección?

A) DIU medicado con progestágeno
B) Anticonceptivos orales combinados
C) Anillo vaginal combinado
D) Progestágenos inyectables cada 3 meses
E) Estrógeno solo

Respuesta A. El DIU medicado no produce la hipermenorrea y dismenorrea del DIU común. Además, tiene el mejor perfil cardiovascular, en relación a los métodos hormonales.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 171 · texto original del banco, sin revisar

Una mujer de 32 años, con antecedente de parto hace 8 meses, sigue dando lactancia materna a su hijo y se ha mantenido en amenorrea. No quiere embarazarse todavía, por lo que pregunta cuál es el método anticonceptivo de elección:

A) Amenorrea de la lactancia
B) Anticonceptivos orales combinados de etinilestradiol y dienogest
C) Anticonceptivos en parches de norelgestromina y etinilestradiol
D) Anticonceptivos inyectables de medroxiprogesterona y estradiol
E) Dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel

Respuesta E. La alternativa correcta es la E (Dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel). 1. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES). Las opciones alternativas (Amenorrea de la lactancia, Anticonceptivos orales combinados de etiniles) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuer

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 78 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 28 años, con antecedente de IMC: 29 y resistencia a la insulina, usuaria de DIU desde hace 5 años, presenta reglas abundantes y dismenorrea, por lo que solicita cambiar a anticoncepción oral. ¿Cuál de las siguientes opciones es la de elección?

A) Etinilestradio 0,02 mg, más drospirenona 3 mg
B) Etinilestradio 0,03 mg, más gestodeno 75 ug
C) Etinilestradio 0,03 mg, más dienogest 3 mg
D) Estradiol 2 mg, más dienogest 2 mg
E) Gestodeno 75 ug

Respuesta C. [Pregunta disputada] Pregunta muy discutible, pero el ACO que controlar mejor el sangrado, de los que ahí están sería los que tienen etinilestradiol (en lugar de estradiol) con dienogest, que, además, tiene un excelente perfil cardiovascular. Es una pregunta que excede lo que debe saber un médico general

3.01.3.009 Prevención de enfermedad hemolítica perinatal

Dónde se enseña: Tema 19.20 Aloinmunización Rh e Incompatibilidad de Grupo Materno-Fetal: Profilaxis con Inmunoglobulina Anti-D y Manejo de la Gestante Sensibilizada

QUÉ HAY QUE SABER

- Enfermedad hemolítica perinatal: madre Rh(–) expuesta a sangre fetal Rh(+) produce IgG anti-D que en embarazos siguientes cruzan la placenta y hemolizan (anemia, hidrops, ictericia).
- Tamizaje: grupo, Rh y Coombs indirecto a toda embarazada en el 1.er control; en Rh(–) no sensibilizada se repite el Coombs indirecto a las 28 semanas.
- Profilaxis: inmunoglobulina anti-D 300 μg IM a las 28 semanas y otra dosis dentro de 72 h posparto si el RN es Rh(+) (Coombs directo del RN negativo).
- También dentro de 72 h tras aborto, ectópico, mola, metrorragia, trauma abdominal, amniocentesis, biopsia de vellosidades o versión externa.
- Coombs indirecto positivo (ya sensibilizada): la anti-D no sirve; titular anticuerpos (crítico 1/16–1/32) y derivar para Doppler de arteria cerebral media (velocidad alta = anemia) y eventual cordocentesis con transfusión intrauterina.
- Coombs directo en el RN detecta anticuerpos unidos a sus glóbulos rojos.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 74

Primigesta de 13 semanas. Su determinación de grupo sanguíneo se informa como AB, Rh negativo, D-u positivo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Solicitar Doppler de arteria cerebral media fetal
B) Solicitar Coombs indirecto a las 18 semanas
C) Administrar Rhogam a las 28 semanas
D) Determinar grupo y Rh del padre
E) Mantener control habitual del embarazo

Respuesta E. Un D-u positivo indica que la paciente en realidad expresa el antígeno D de forma débil, y se maneja como Rh positivo: no necesita Coombs seriado ni inmunoglobulina anti-D, sino el control habitual del embarazo.

3.01.3.010 Prevención de enfermedades de transmisión sexual

Dónde se enseña: Tema 3.5 Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) II: Uretritis, Úlceras Genitales y VPH

QUÉ HAY QUE SABER

- Prevención combinada: preservativo en todas las relaciones (doble protección junto al anticonceptivo), reducción del número de parejas, educación sexual y consejería.
- Vacunas: VPH nonavalente en escolares de 4.º y 5.º básico (programa nacional) y hepatitis B en el calendario del lactante y grupos de riesgo.
- Testeo: VIH (ELISA o test rápido con consentimiento, confirmación ISP), VDRL/RPR, hepatitis B y C en poblaciones de riesgo y en toda embarazada.
- VIH: TARV como prevención (indetectable = intransmisible), PrEP (tenofovir/emtricitabina) en alto riesgo y PEP dentro de 72 h tras exposición de riesgo (28 días).
- Ante una ITS: tratar a la persona y a sus parejas (gonococo/Chlamydia: contactos de los últimos 60 días), abstinencia 7 días y tamizaje de otras ITS; notificación obligatoria de sífilis, gonorrea y VIH.
- Sífilis congénita: tamizaje con VDRL en el 1.er control, 24–28 semanas y parto, y tratamiento con penicilina benzatina a la madre y la pareja.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Joven de 19 años, que inició actividad sexual hace un año y ha tenido 3 parejas, consulta en el CESFAM porque quiere saber cómo prevenir infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. Usa anticonceptivos orales combinados. **¿Cuál es la medida más eficaz para prevenir la transmisión sexual de estas infecciones?**

A) Mantener los anticonceptivos orales combinados
B) Uso correcto y consistente del preservativo en cada relación
C) Ducha vaginal después de cada relación
D) Antibiótico profiláctico después de cada relación sexual
E) Cambiar a un dispositivo intrauterino de cobre

Respuesta B. El preservativo, usado de forma correcta y en todas las relaciones, es el método de barrera que reduce eficazmente la transmisión del VIH y de la mayoría de las ITS. Los anticonceptivos hormonales y el DIU previenen embarazo, pero no ITS. Se complementa con vacunación contra VPH y hepatitis B y testeo periódico.

3.01.3.011 Pubertad (adolescencia)

Dónde se enseña: Tema 20.1 Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea

QUÉ HAY QUE SABER

- Pubertad femenina normal entre 8 y 13 años; secuencia: telarquia (primer signo) → pubarquia → estirón puberal → menarquia (~2–3 años tras la telarquia, edad media ~12 años).
- Pubertad precoz: caracteres sexuales antes de los 8 años en niñas; central (por GnRH, la mayoría idiopática en niñas) vs periférica; estudiar edad ósea, LH/FSH, estradiol y RM si es central.
- Pubertad retrasada: sin telarquia a los 13 años o sin menarquia a los 15 (o 3 años tras la telarquia); causas: constitucional, hipogonadismo hipogonadotropo (Kallmann, anorexia, deporte) o hipergonadotropo (Turner).
- Los primeros ciclos tras la menarquia suelen ser anovulatorios e irregulares; sangrado abundante en la adolescente obliga a descartar von Willebrand.
- Control de salud adolescente: confidencialidad, evaluación psicosocial (HEADSSS), consejería en sexualidad y anticoncepción, prevención de ITS y embarazo, vacuna VPH.
- Derivar a endocrinología o ginecología infantojuvenil ante pubertad precoz, retrasada o amenorrea primaria.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 32

Una paciente de 14 años aún no ha tenido su menarquia. Presenta desarrollo puberal Tanner 2, mamario y pubiano, con vello axilar. No tiene otras alteraciones en el examen físico. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Solicitar ecografía ginecológica
B) Solicitar cariotipo
C) Solicitar niveles plasmáticos de estradiol, LH y FSH
D) Realizar prueba de progesterona
E) Controlar en un año

Respuesta E. A los 14 años, con desarrollo puberal ya iniciado, todavía no se cumple la definición de amenorrea primaria, que exige ausencia de menarquia a los 15 años cuando hay caracteres sexuales secundarios presentes. La conducta correcta es controlar la evolución, no estudiar.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 89

Paciente de 14 años, con menarquia a los 13 años, presenta ciclos menstruales que varían entre 26 y 35 días. Su examen físico es normal y no refiere otros síntomas. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar anticonceptivos orales
B) Iniciar estrógenos solos por vía oral
C) Iniciar progestágenos solos por vía oral
D) Solicitar niveles plasmáticos de estradiol, progesterona, LH y FSH
E) Controlar ambulatoriamente con calendario menstrual

Respuesta E. En los primeros años tras la menarquia el eje hipotálamo-hipófisis-ovario aún es inmaduro y los ciclos anovulatorios e irregulares son esperables. Ciclos entre 21 y 45 días son normales en adolescentes. Basta educar y controlar con calendario menstrual; no requiere estudio hormonal ni tratamiento.

3.01.3.012 Salud pública perinatal

Dónde se enseña: Tema 21.7 Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud

QUÉ HAY QUE SABER

- Salud pública perinatal en Chile: atención prenatal y del parto casi universal e institucional, con red perinatal regionalizada que deriva el alto riesgo a centros de mayor complejidad.
- Indicadores: mortalidad materna (por 100.000 NV), perinatal, neonatal e infantil (por 1.000 NV), bajo peso al nacer y prematurez; la mortalidad infantil chilena es hoy predominantemente neonatal.
- Programa de Salud de la Mujer y Chile Crece Contigo: ingreso prenatal precoz, evaluación psicosocial (EPsA), visitas domiciliarias, educación prenatal y acompañamiento del desarrollo infantil.
- Garantías GES perinatales: prevención de parto prematuro, analgesia del parto, VIH (prevención de transmisión vertical), hipoacusia y cardiopatías congénitas, retinopatía y displasia del prematuro.
- Prevención: ácido fólico preconcepcional, harina fortificada con ácido fólico, tamizaje de sífilis, VIH, Chagas y hepatitis B, vacunación materna (influenza, dTpa).
- Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC) para embarazadas y nodrizas, y tamizaje neonatal de hipotiroidismo y fenilquetonuria.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

En las últimas décadas Chile redujo drásticamente su mortalidad infantil gracias al control de la desnutrición y de las infecciones, y hoy tiene tasas cercanas a las de países desarrollados. **¿Qué componente concentra actualmente la mayor parte de la mortalidad infantil en Chile?**

A) Mortalidad por enfermedades diarreicas
B) Mortalidad postneonatal (28 días a 11 meses)
C) Mortalidad neonatal (menores de 28 días)
D) Mortalidad por desnutrición
E) Mortalidad por accidentes en el hogar

Respuesta C. En Chile, como en países desarrollados, la mayor parte de la mortalidad infantil es neonatal, asociada a prematurez, malformaciones congénitas y afecciones perinatales. Por eso las estrategias actuales apuntan al período perinatal: control prenatal precoz, atención profesional del parto, regionalización neonatal y Chile Crece Contigo.

3.01.3.013 Screening ginecológico: Papanicolau, mamografía

Dónde se enseña: Tema 20.13 Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía · Tema 20.14 Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna

QUÉ HAY QUE SABER

- Cáncer cervicouterino (GES): PAP cada 3 años en mujeres de 25 a 64 años; test de VPH desde los 30 años cada 5 años si es negativo; vacuna VPH en 4.º y 5.º básico como prevención primaria.
- PAP alterado: ASC-US/LIEBG en ≥30 años → test VPH (16/18 → colposcopía); LIEAG, ASC-H o AGC → colposcopía en <30 días (GES).
- Cáncer de mama (GES): mamografía bilateral cada 2 años de 50 a 69 años; alto riesgo genético (BRCA, familiar de 1.er grado joven, radioterapia torácica) desde los 30–35 años, con RM.
- BI-RADS: 0 incompleto (ecografía o proyecciones), 1–2 control habitual, 3 control en 6 meses, 4–5 biopsia con aguja gruesa, 6 cáncer confirmado.
- El examen físico de mamas no reemplaza a la mamografía; la ecografía mamaria complementa en mamas densas y en mujeres jóvenes.
- Rol del médico general: tomar el PAP, solicitar mamografía, interpretar informes y derivar oportunamente según resultado.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 172

Una mujer de 34 años, con vacunación completa contra el virus papiloma humano, se realiza un PAP, que es informado como muestra satisfactoria sin presencia de atipías celulares, y una prueba de detección de virus papiloma humano que es informada como positiva para VPH de alto riesgo, serotipo 56. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Indicar refuerzo de la vacunación contra el VPH
B) Realizar control de PAP en un año
C) Realizar colposcopía
D) Repetir el PAP en este momento
E) Realizar conización cervical

Respuesta B. A diferencia de los serotipos 16 y 18, que se derivan a colposcopía de manera inmediata por ser los más agresivos, otros genotipos de alto riesgo, como el 56, con un PAP normal, se manejan con observación y control en un año.

3.01.3.014 Sexualidad, género y diversidad

Dónde se enseña: psiq-20

QUÉ HAY QUE SABER

- Conceptos: sexo asignado al nacer, identidad de género (vivencia interna), expresión de género y orientación sexual son dimensiones independientes; la diversidad no es una patología.
- Atención inclusiva: lenguaje neutro, preguntar nombre y pronombres, confidencialidad, historia sexual sin supuestos (prácticas, parejas, protección) y evitar juicios.
- Ley de Identidad de Género (21.120) permite rectificar sexo y nombre registral desde los 14 años (con representante y tribunal en menores de 18); la Ley 20.609 sanciona la discriminación arbitraria.
- Riesgos a pesquisar en población LGBTIQ+: depresión, ansiedad, suicidio, consumo de sustancias, violencia y barreras de acceso; tamizaje de ITS y VIH según prácticas, y PrEP.
- Salud sexual: consejería en anticoncepción y prevención de ITS, pesquisa de disfunciones sexuales (deseo, excitación, orgasmo, dispareunia) y de violencia sexual o de pareja.
- Derivar a programa de acompañamiento de identidad de género, salud mental o especialista según necesidad; mantener el tamizaje ginecológico según los órganos presentes (PAP en hombres trans con cuello uterino).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Adolescente de 16 años, asignada mujer al nacer, consulta en control de salud. Refiere que se identifica como mujer, se siente cómoda con su cuerpo y desde los 13 años siente atracción afectiva y sexual solo hacia otras mujeres. **¿Qué concepto describe la atracción que relata la paciente?**

A) Identidad de género
B) Sexo asignado al nacer
C) Expresión de género
D) Orientación sexual
E) Disforia de género

Respuesta D. La orientación sexual es hacia quién se dirige la atracción afectiva y sexual. La identidad de género es la vivencia interna de ser mujer, hombre u otra; la expresión de género, cómo se manifiesta externamente. Ser lesbiana no es un trastorno; la disforia implica malestar por incongruencia con el sexo asignado, ausente aquí.

3.01.3.015 Síndrome de ovario poliquístico

Dónde se enseña: Tema 20.2 Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP): Criterios de Rotterdam, Resistencia a la Insulina y Manejo

QUÉ HAY QUE SABER

- SOP: endocrinopatía más frecuente de la mujer en edad fértil; mecanismo con aumento de pulsos de GnRH (LH > FSH), andrógenos tecales y resistencia insulínica con caída de SHBG.
- Diagnóstico por criterios de Rotterdam (2 de 3): oligo/anovulación, hiperandrogenismo clínico o bioquímico, morfología poliquística ecográfica; en adolescentes no usar la ecografía como criterio.
- Descartar antes: embarazo, hipotiroidismo (TSH), hiperprolactinemia, hiperplasia suprarrenal no clásica (17-OH-progesterona) y tumores secretores de andrógenos (virilización rápida).
- Riesgos asociados: síndrome metabólico, DM2, dislipidemia, hígado graso, apnea del sueño, infertilidad, hiperplasia y cáncer de endometrio por estrógeno sin oposición.
- Tratamiento: baja de 5–10% de peso; sin deseo de embarazo, ACO con progestágeno antiandrogénico (± espironolactona para hirsutismo), metformina si hay resistencia insulínica.
- Con deseo de embarazo: letrozol como inductor de ovulación de primera línea (clomifeno alternativa). Tamizaje metabólico con PTGO y perfil lipídico periódico.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 157

Mujer de 28 años con amenorrea de 4 meses, hirsutismo, acné y obesidad central. Ecografía: ovarios con múltiples folículos periféricos. Testosterona libre levemente elevada. **¿Cuál es el diagnóstico?**

A) Síndrome de ovario poliquístico
B) Hiperprolactinemia
C) Insuficiencia ovárica prematura
D) Síndrome de Cushing
E) Hiperplasia suprarrenal congénita

Respuesta A. Amenorrea (disfunción ovulatoria) más hiperandrogenismo clínico y bioquímico, más ecografía con morfología poliquística: se cumplen los tres criterios de Rotterdam. Es la causa más frecuente de amenorrea secundaria en mujeres jóvenes.

3.01.3.016 Vínculo y apego

Dónde se enseña: Tema 18.15 Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR

QUÉ HAY QUE SABER

- Apego: vínculo afectivo seguro entre el RN y su cuidador principal, base del desarrollo emocional, cognitivo y social del niño.
- Apego precoz: contacto piel a piel inmediato al nacer en RN de término vigoroso (sin separarlo para procedimientos no urgentes) y amamantamiento en la primera hora; luego alojamiento conjunto.
- Factores protectores: acompañamiento en el parto, lactancia materna, padre o pareja involucrados, red de apoyo; de riesgo: depresión perinatal, embarazo no deseado, adolescencia, violencia, consumo de sustancias.
- Pesquisa: escala de Edimburgo para depresión posparto (en el embarazo y a los 2 y 6 meses) y evaluación psicosocial abreviada (EPsA) en el 1.er control prenatal.

- Chile Crece Contigo: talleres prenatales y de crianza (Nadie es Perfecto), visitas domiciliarias y entrega del ajuar; evaluar la díada madre-hijo en el control del niño sano.
- Ante señales de apego inseguro o negligencia, derivar a salud mental, trabajo social y programas de apoyo psicosocial.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Recién nacido de término, de 3.300 g, nace por parto vaginal, vigoroso, llorando y con buen tono. La madre está estable y desea tenerlo consigo. **¿Qué intervención inmediata favorece más el vínculo y el apego temprano?**

A) Aspirar de rutina las secreciones orofaríngeas y gástricas
B) Bañar al recién nacido antes de entregárselo a la madre
C) Trasladarlo a observación en cuna radiante por 2 horas
D) Administrar fórmula láctea para prevenir hipoglicemia
E) Contacto piel a piel inmediato con su madre e inicio de lactancia en la primera hora

Respuesta E. En el recién nacido vigoroso se recomienda contacto piel a piel inmediato e ininterrumpido y lactancia en la primera hora: favorece el apego, la termorregulación, la estabilidad glicémica y el éxito de la lactancia. Separarlo para baño, observación o aspiración rutinaria no tiene beneficio y lo interrumpe.

Exámenes e imagenología 8 códigos

3.01.4.001 Histerosalpingografía

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 20.7 Infertilidad Conyugal: Estudio Básico Inicial en Cuatro Pilares y Técnicas de Reproducción Asistida

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación: estudio del factor tuboperitoneal en infertilidad (permeabilidad tubaria) y de la cavidad uterina (malformaciones, sinequias, pólipos).
- Se realiza en fase folicular temprana (días 7–11 del ciclo, tras la menstruación y antes de la ovulación) para no irradiar un embarazo inicial.
- Hallazgos: prueba de Cotte positiva (contraste pasa a la cavidad peritoneal) = trompa permeable; hidrosálpinx u obstrucción con Cotte negativa = factor tubario.
- Defectos de llenado orientan a pólipos, miomas submucosos o sinequias (Asherman); imágenes uterinas anómalas a útero septado o bicorne.
- Contraindicaciones: embarazo, PIP activo o infección cervical, metrorragia activa, alergia al contraste yodado.
- Con obstrucción tubaria bilateral, la inseminación no sirve: derivar a fertilización in vitro.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 146

Mujer de 38 años consulta porque lleva 2 años intentando embarazarse. Sus reglas son regulares, su examen físico es normal y múltiples exámenes hormonales confirman ciclos ovulatorios. Su pareja tiene un espermiograma normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada para proseguir el estudio?**

A) Histeroscopía
B) Laparoscopía
C) Histerosalpingografía
D) Niveles plasmáticos de hormona antimülleriana
E) Seguimiento folicular ecográfico

Respuesta C. Con la ovulación confirmada y el espermiograma normal, quedan descartados el factor ovulatorio y el masculino. El siguiente pilar a estudiar es el tuboperitoneal, y el examen de elección es la histerosalpingografía.

3.01.4.002 Mamografía

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 20.14 Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: tamizaje cada 2 años de 50 a 69 años (GES), desde 30–35 en alto riesgo genético, y estudio de nódulo, telorrea hemática o cambios cutáneos en mujeres ≥35–40 años.

- Signos de malignidad: nódulo espiculado o de bordes irregulares, microcalcificaciones finas agrupadas o lineales, distorsión de la arquitectura, asimetría nueva, engrosamiento cutáneo.
- BI-RADS 0: estudio incompleto (complementar con ecografía o proyecciones); 1 negativo y 2 benigno: control habitual.
- BI-RADS 3: probablemente benigno (<2% de riesgo), control en 6 meses; 4 sospechoso y 5 altamente sugerente (>95%): biopsia con aguja gruesa guiada por imagen.
- BI-RADS 6: cáncer ya confirmado por biopsia. En mamas densas y en menores de 35–40 años se prefiere o complementa con ecografía.
- Una mamografía normal no descarta cáncer ante un nódulo palpable sospechoso: igualmente estudiar con ecografía y biopsia.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 166

Una paciente de 47 años acude a control ginecológico, observándose salida de secreción escasa por el pezón a la compresión, que ella no había notado previamente. Se solicita mamografía, que es informada como BI-RADS 2, y ecografía mamaria, que muestra ectasia ductal retroareolar, BI-RADS 2. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Solicitar mamografía con compresión focal
B) Realizar control mamográfico en un año
C) Solicitar resonancia magnética nuclear de mama
D) Indicar mupirocina tópica
E) Resolver mediante resección quirúrgica

Respuesta B. BI-RADS 2 es un hallazgo benigno (aquí, ectasia ductal) y se maneja con control habitual en 1 a 2 años. La compresión focal o la resonancia aclaran estudios incompletos o dudosos; BI-RADS 3 se controla en 6 meses y BI-RADS 4 o 5 exige biopsia.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 113 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 40 años se realiza una mamografía que reporta BIRADS 0 (insuficiente). Posteriormente, se realiza una ecografía mamaria con resultado BIRADS 2. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Repetir la mamografía en 6 meses
B) Repetir la ecotomografía mamaria en 6 meses
C) Solicitar una mamografía con compresión lateralizada
D) Solicitar una resonancia magnética nuclear de mamas
E) Realizar biopsia estereotáxica

Respuesta B. Manejo de Mamografías BIRADS 0: Las mamografías clasificadas como BIRADS 0 requieren estudios adicionales para su evaluación, siendo la ecografía mamaria la técnica de elección. En el caso de las ecografías mamarias BIRADS 2, la lesión es benigna. Sin embargo, se recomienda repetir la ecografía en 6 meses para confirmar su estabilidad. Un ejemplo de lesión BIRADS 2 en la ecografía es el fibroadeno

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 174 · texto original del banco, sin revisar

redondeadas, agrupadas, catalogadas como mamografía Birrads ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar biopsia por punción con aguja gruesa
B) Solicitar nueva mamografía en un año
C) Solicitar nueva mamografía en 6 meses
D) Solicitar ecografía mamaria
E) Realizar biopsia por punción, guiada por rayos X

Respuesta C. Birrads 3 = lesión de bajo riesgo de malignidad = control en 6 meses, pudiendo ser complementado con una ecografía. Recordemos también el Birrads 4 = lesión sospechosa = biopsia histológica (guiada por rayos X si tumor no palpable; o con aguja gruesa o mamótomo directo, si tumor palpable).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 16 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 45 años se realiza una mamografía, que es informada como Birrads 0, por presencia de opacidades nodulares bilaterales, bien delimitadas. La conducta más adecuada es:

A) Control mamográfico en 6 meses
B) Ecografía mamaria
C) Biopsia estereotáxica
D) Biopsia quirúrgica
E) Resonancia magnética nuclear de mama

Respuesta B. Birrads 0 = ecografía; Birrads 1 = control en 1 a 2 años; Birrads 2 = control en 1 a 2 años; Birrads 3 = mamografía en 6 meses (se puede complementar con ecografía); Birrads 4 = biopsia estereotáxica (si no es palpable) o con aguja gruesa (si palpable); Birrads 5 = biopsia quirúrgica.

3.01.4.003 Ecotomografía obstétrica normal

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 19.2 Ecografía Obstétrica: 11-14 Semanas (Aneuploidías y Doppler Uterino) & 20-24 Semanas (Morfológica y Cervicometría)

QUÉ HAY QUE SABER

- Esquema de rutina en bajo riesgo (Guía Perinatal): 11–14 semanas, 20–24 semanas y 30–34 semanas; más ecografías no mejoran resultados.
- 1.er trimestre: confirma embarazo intrauterino, viabilidad (LCF), número de fetos y corionicidad, edad gestacional por LCN; a las 11–14 semanas translucencia nucal, hueso nasal y Doppler de uterinas.
- 20–24 semanas: anatomía fetal completa (cráneo, columna, corazón, pared, riñones, extremidades), localización placentaria, líquido amniótico y cervicometría transvaginal (normal ≥25 mm).
- 30–34 semanas: crecimiento fetal (peso estimado en percentil 10–90), presentación, placenta y líquido amniótico (normal: bolsillo mayor 2–8 cm o ILA 5–25 cm).
- Hallazgos normales sin seguimiento extra: placenta de inserción baja en el 2.º trimestre se reevalúa a las 32 semanas (la mayoría migra).
- No se corrige la edad gestacional con ecografías tardías si ya existe una precoz.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Primigesta de 12 semanas, sana, sin factores de riesgo, con embarazo único intrauterino y edad gestacional confirmada. Consulta en su control prenatal sobre cuándo se le realizarán las ecografías de rutina durante el embarazo. **¿Cuál es el esquema de ecografías de rutina recomendado para un embarazo de bajo riesgo?**

A) Solo una ecografía a las 20 semanas
B) Ecografías a las 11 a 14, 22 a 24 y 30 a 34 semanas
C) Una ecografía mensual hasta el parto
D) Solo ecografía en el tercer trimestre para estimar el peso
E) Ecografías a las 7, 20 y 40 semanas

Respuesta B. Según la Guía Perinatal MINSAL, en el embarazo de bajo riesgo se realizan ecografías de rutina a las 11 a 14 semanas (datación, translucencia nucal, Doppler de uterinas), a las 22 a 24 semanas (anatomía fetal y longitud cervical) y a las 30 a 34 semanas (crecimiento, placenta y líquido amniótico). Más ecografías no mejoran los resultados en bajo riesgo.

3.01.4.004 Ecotomografía obstétrica patológica

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 19.2 Ecografía Obstétrica: 11-14 Semanas (Aneuploidías y Doppler Uterino) & 20-24 Semanas (Morfológica y Cervicometría) · Tema 19.4 Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler

QUÉ HAY QUE SABER

- Translucencia nucal ≥3 mm (o p99) o ausencia de hueso nasal a las 11–14 semanas: riesgo de aneuploidía → consejería y estudio genético (biopsia de vellosidades 11–14 semanas o amniocentesis desde las 15–16).
- Doppler de arterias uterinas con IP >p95 a las 11–14 semanas: riesgo de preeclampsia precoz → aspirina 150 mg nocturna antes de las 16 semanas hasta las 36.

- Cervicometría <25 mm a las 20–24 semanas: riesgo de parto prematuro → progesterona vaginal 200 mg/noche hasta las 36 semanas (cerclaje si además hay antecedente).
- Peso fetal <p10: diferenciar PEG de RCF con Doppler umbilical; >p90: GEG/macrosomía (evaluar diabetes).
- Líquido amniótico: oligoamnios (bolsillo <2 cm, ILA <5) sugiere RPM, insuficiencia placentaria o uropatía; polihidroamnios (bolsillo >8 cm, ILA >25) diabetes, atresia digestiva, gemelar.
- Placenta previa oclusiva confirmada en el 3.er trimestre o malformaciones fetales: derivar a alto riesgo obstétrico/medicina materno-fetal.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 133

Embarazada de 12 semanas, con translucencia nucal aumentada en la ecografía. **¿Cuál es el examen definitivo para confirmar una trisomía 21?**

A) Biopsia de vellosidades coriales (11 a 14 semanas)
B) Amniocentesis (15 a 20 semanas)
C) ADN fetal en sangre materna
D) Fetoscopía
E) Marcadores séricos maternos (triple marcador)

Respuesta A. A las 12 semanas, la biopsia de vellosidades coriales es el examen invasivo de elección para el cariotipo fetal, dentro de su ventana de las 10 a 14 semanas. La amniocentesis se reserva para después de las 15 semanas.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 133

Embarazada de 12 semanas con translucencia nucal aumentada en la ecografía. **¿Cuál es el examen definitivo para confirmar trisomía 21?**

A) Biopsia de vellosidades coriales (11 a 14 semanas)
B) Amniocentesis (15 a 20 semanas)
C) ADN fetal libre en sangre materna (NIPT)
D) Fetoscopía
E) Marcadores séricos maternos (triple marcador)

Respuesta A. Una aneuploidía se confirma solo con cariotipo fetal obtenido por técnica invasiva. A las 12 semanas corresponde la biopsia de vellosidades coriales (ventana de 10 a 14 semanas); la amniocentesis se realiza desde las 15 semanas. El ADN fetal libre es un tamizaje de alta sensibilidad, pero no diagnóstico; los marcadores séricos también son tamizaje.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 50 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 32 años, con un embarazo de 12 semanas, se realiza una ecografía obstétrica que revela una translucencia nucal mayor al percentil 99 y ausencia de hueso nasal. ¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico?

A) Ecogra:a obstétrica de control a las 21 semanas
B) Estudio de ADN libre fetal en sangre materna
C) Amniocentesis con cariograma de sangre fetal
D) Biopsia de vellosidad corial
E) Determinación de niveles de alfa-fetoproteína y hCG

Respuesta D. Actualmente, la mejor forma de evaluar genopatías fetales es con el ADN libre fetal en sangre materna, que es un examen seguro y más sensible y específico que la ecografía, razón por la cual muchas recomendaciones internacionales abogan por indicarlo como examen de primera línea y también como examen de segunda línea, si es que se usó otro, dejando los exámenes invasivos (biopsia de vellosidad cor

3.01.4.005 Ecotomografía ginecológica

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 20.15 Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores

QUÉ HAY QUE SABER

- Vía transvaginal de elección (mejor resolución); transabdominal en vírgenes o masas grandes. Idealmente en fase folicular temprana para evaluar el endometrio en edad fértil.
- Endometrio postmenopáusico: <4–5 mm compatible con atrofia; ≥4–5 mm con sangrado (≥8 mm con TRH; ≥11 mm asintomática) → biopsia endometrial.

- Miomas: nódulos hipoecogénicos bien delimitados (clasificar FIGO); adenomiosis: útero globuloso con miometrio heterogéneo y asimétrico; pólipo: imagen focal hiperecogénica con vaso nutricio.
- Ovario: quiste simple anecoico unilocular (funcional, control en 6–12 semanas); endometrioma en vidrio esmerilado; teratoma con componente graso y calcificaciones; SOP con ≥20 folículos por ovario o volumen >10 mL.
- Signos de malignidad (IOTA): componente sólido, papilas >3 mm, tabiques gruesos, flujo central, ascitis → derivar a ginecología oncológica.
- En urgencia: útero vacío con beta-hCG sobre la zona discriminatoria (ectópico), líquido libre, signo del remolino y ausencia de flujo (torsión).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 28 años, asintomática, con ciclos regulares, se realiza una ecografía transvaginal de control que muestra un quiste en el ovario derecho de 4 cm, unilocular, anecoico, de pared fina, sin tabiques, papilas ni flujo al Doppler. El útero y el ovario izquierdo son normales y el test de embarazo es negativo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Laparoscopía con quistectomía
B) Solicitar CA-125 y resonancia magnética de pelvis
C) Control con ecografía transvaginal en 6 a 8 semanas, en la primera fase del ciclo
D) Punción ecoguiada del quiste
E) Anticonceptivos orales por 6 meses como tratamiento obligatorio

Respuesta C. Un quiste simple (unilocular, anecoico, pared fina, sin papilas ni flujo) menor de 5 cm en edad fértil es casi siempre funcional y se resuelve solo. Se controla con ecografía transvaginal en 6 a 8 semanas, en fase folicular. La cirugía se reserva para persistencia, crecimiento o rasgos sospechosos.

3.01.4.006 Ecotomografía mamaria

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 20.14 Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna

QUÉ HAY QUE SABER

- Primer examen de imagen ante nódulo palpable en mujer <35–40 años, embarazada o en lactancia; complementa a la mamografía en mamas densas o BI-RADS 0.
- Distingue quiste de nódulo sólido: quiste simple (anecoico, pared fina, refuerzo posterior) es benigno y no requiere más estudio.
- Nódulo benigno (fibroadenoma): ovalado, paralelo a la piel (más ancho que alto), bordes circunscritos, homogéneo.
- Signos de sospecha: más alto que ancho, bordes irregulares o espiculados, sombra acústica posterior, hipoecogenicidad marcada, vascularización interna, adenopatías axilares anómalas.
- Se informa con BI-RADS igual que la mamografía (3 control en 6 meses; 4–5 biopsia con aguja gruesa ecoguiada).
- Útil en la mastitis puerperal que no responde para confirmar y guiar el drenaje de un absceso.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 41

Mujer de 45 años con ecografía mamaria informada como BI-RADS 0. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Completar el estudio con mamografía bilateral
B) Biopsia core guiada por ecografía
C) Control en 6 meses
D) Alta y control anual
E) Resonancia magnética mamaria de urgencia

Respuesta A. BI-RADS 0 significa estudio incompleto: no se puede categorizar y se debe complementar con otra imagen. En una mujer de 45 años, la ecografía es complementaria de la mamografía, que es el examen base, por lo que se completa con mamografía bilateral antes de decidir biopsia o seguimiento.

3.01.4.007 Papanicolau

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 20.13 Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía

QUÉ HAY QUE SABER

- Tamizaje de cáncer cervicouterino: cada 3 años en mujeres de 25 a 64 años (GES); se informa con el sistema Bethesda e incluye la calidad de la muestra.
- Muestra insatisfactoria o sin células endocervicales: repetir; negativo para lesión: control habitual; inflamatorio sin atipias: tratar infección si hay clínica y no repetir antes.
- ASC-US o LIE de bajo grado (NIE I): en ≥30 años test de VPH (16/18 → colposcopía; negativo → control); en <25–30 años repetir citología, por alta regresión espontánea.
- ASC-H, LIE de alto grado (NIE II–III), AGC o sospecha de carcinoma: derivación a colposcopía con biopsia en <30 días (GES).
- Un PAP normal no descarta cáncer si hay lesión visible o sinusorragia: biopsiar directamente.
- Coordinar el resultado con la Unidad de Patología Cervical y asegurar que la paciente acuda a la colposcopía.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 31 años, asintomática, se toma su Papanicolau de tamizaje en el CESFAM al cuarto día de su menstruación. El informe dice: muestra insatisfactoria para evaluación, por abundante sangre que oscurece las células. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Colposcopía inmediata
B) Test de VPH y conización si resulta positivo
C) Control en 3 años, como un Papanicolau normal
D) Repetir el Papanicolau fuera de la menstruación, sin relaciones, duchas ni óvulos en las 48 horas previas
E) Biopsia endometrial

Respuesta D. Una muestra insatisfactoria no es normal ni anormal: no permitió evaluar las células. Se repite el Papanicolau, idealmente a mitad de ciclo, sin sangrado y sin relaciones, duchas ni óvulos en las 48 horas previas, tomando exocérvix con espátula y endocérvix con cepillo.

3.01.4.008 HCG cuantitativa

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 19.11 Embarazo Ectópico: Localizaciones, Diagnóstico con β-hCG Cuantitativa, Manejo Médico (Metotrexato) vs Quirúrgico · Tema 19.12 Enfermedad Trofoblástica Gestacional: Mola Completa vs Parcial, Criterios de Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG) y Seguimiento

QUÉ HAY QUE SABER

- La beta-hCG cuantitativa se duplica cada ~48 h en el embarazo intrauterino viable inicial; un alza <35–50% en 48 h o caída sugiere embarazo anormal (ectópico o aborto).
- Zona discriminatoria 1.500–2.000 UI/L: sobre ese valor debe verse saco intrauterino en la ecografía transvaginal; útero vacío = ectópico. Bajo ese valor, repetir hCG en 48 h.
- Metotrexato en ectópico si hCG <5.000 UI/L (con masa <3,5 cm sin latidos); controlar días 4 y 7 (descenso ≥15%) y luego semanal hasta negativizar.
- Valores muy elevados (>100.000) con útero grande sugieren mola; también embarazo múltiple.
- Seguimiento posmola: hCG semanal hasta 3 valores normales seguidos y mensual por 6 meses con anticoncepción; meseta (4 valores en 3 semanas) o alza = neoplasia trofoblástica gestacional.
- Tras un aborto, la hCG puede tardar 2–6 semanas en negativizarse; una cualitativa positiva aislada no confirma restos ni embarazo nuevo.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Mujer de 27 años, con 5 semanas de amenorrea, consulta por spotting sin dolor. Está hemodinámicamente estable y el abdomen es blando. La beta-hCG cuantitativa es 900 UI/L. La ecografía transvaginal muestra útero sin saco gestacional, anexos normales y sin líquido libre. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Metotrexato intramuscular a dosis única
B) Salpingectomía laparoscópica
C) Legrado uterino diagnóstico
D) Repetir la beta-hCG cuantitativa en 48 horas
E) Dar de alta: el útero vacío descarta el embarazo

Respuesta D. Con beta-hCG bajo la zona discriminatoria (1.500 a 2.000 UI/L) es esperable no ver el saco. Se repite a las 48 horas: si se duplica, sugiere embarazo normal; si sube poco, se estanca o hay útero vacío sobre la zona, se sospecha ectópico. Tratar ahora sería prematuro.

Pregunta de práctica

Mujer de 28 años, a quien se le realizó aspiración endouterina por mola hidatiforme completa hace 6 semanas. Está asintomática, usando anticonceptivos orales. Sus controles semanales de beta-hCG cuantitativa en las últimas 3 semanas fueron: 1.250, 1.230, 1.260 y 1.240 UI/L. **¿Cuál es la interpretación y conducta más adecuada?**

A) Descenso normal; continuar controles mensuales
B) Neoplasia trofoblástica gestacional; etapificar e iniciar quimioterapia
C) Nuevo embarazo; ecografía obstétrica
D) Resultado falso positivo; suspender el seguimiento
E) Mola residual; histerectomía inmediata

Respuesta B. Tras evacuar una mola, la beta-hCG debe caer hasta negativizarse. Cuatro valores en meseta durante 3 semanas (o un alza en 2 semanas) definen neoplasia trofoblástica gestacional: se etapifica y se trata con quimioterapia, habitualmente metotrexato. No es descenso normal ni embarazo, porque usa anticoncepción.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos 14 códigos

3.01.5.001 Amniocentesis

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 19.2 Ecografía Obstétrica: 11-14 Semanas (Aneuploidías y Doppler Uterino) & 20-24 Semanas (Morfológica y Cervicometría)

QUÉ HAY QUE SABER

- Procedimiento invasivo diagnóstico desde las 15–16 semanas: punción transabdominal ecoguiada para obtener líquido amniótico (cariotipo, microarray, PCR de infecciones).
- Indicaciones: tamizaje alterado de aneuploidía (translucencia nucal ≥3 mm, ADN fetal libre positivo), malformaciones fetales, antecedente de cromosomopatía, sospecha de infección congénita.
- Antes de las 15 semanas el estudio invasivo de elección es la biopsia de vellosidades coriales (11–14 semanas).
- Riesgo de pérdida fetal ~0,1–0,5%; otras complicaciones: RPM, corioamnionitis e isoinmunización.
- Madre Rh(–) no sensibilizada: inmunoglobulina anti-D dentro de 72 h tras el procedimiento.
- Nivel del médico general: identificar la indicación, dar consejería y derivar a medicina materno-fetal; lo realiza el especialista.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Embarazada de 38 años, Rh positivo, con tamizaje de primer trimestre de alto riesgo para trisomía 21 (translucencia nucal aumentada). Hoy cursa 16 semanas y desea un diagnóstico definitivo. **¿Cuál es el procedimiento más adecuado?**

A) Cordocentesis
B) Biopsia de vellosidades coriales
C) Amniocentesis para estudio genético fetal
D) Repetir la medición de translucencia nucal
E) Ecografía Doppler de arterias uterinas

Respuesta C. El diagnóstico definitivo de aneuploidía requiere estudio invasivo. A las 16 semanas el procedimiento indicado es la amniocentesis, realizable desde las 15 semanas, con riesgo de pérdida cercano a 0,5%. La biopsia de vellosidades se realiza entre las 11 y 14 semanas; la cordocentesis tiene mayor riesgo. En Rh negativas se administra inmunoglobulina anti-D.

3.01.5.002 Cesárea

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 19.13 Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones absolutas: placenta previa oclusiva, desproporción céfalo-pélvica, situación transversa, cesárea corporal o 2 o más cesáreas previas, herpes genital activo, VIH con carga viral >1.000, procidencia de cordón, DPPNI con feto vivo.
- Indicaciones frecuentes: falla de progresión o detención del trabajo de parto, registro fetal categoría III, podálica, RCF con Doppler alterado (etapas II–IV), macrosomía severa.
- Profilaxis: cefazolina 2 g EV 30–60 min antes de la incisión (clindamicina + gentamicina si alergia); tromboprofilaxis según riesgo; anestesia regional de preferencia.
- Complicaciones: hemorragia, infección (endometritis, la principal), lesión vesical o intestinal, tromboembolismo; a largo plazo placenta previa, acretismo y rotura uterina.
- Con 1 cesárea segmentaria previa se puede ofrecer prueba de trabajo de parto en condiciones adecuadas (evitar prostaglandinas).
- Nivel del médico general: reconocer la indicación y derivar oportunamente; la realiza el especialista.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Paciente de 32 años, multípara de 2 partos vaginales, cursando embarazo de 34 semanas, asintomática y sin sangrado. La ecografía muestra una placenta previa oclusiva total. Bienestar fetal normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto a la vía y momento del parto?**

A) Programar cesárea electiva a las 36-37 semanas
B) Programar inducción del parto a las 39 semanas
C) Permitir parto vaginal con monitorización continua
D) Realizar cesárea de urgencia hoy
E) Esperar el inicio espontáneo del trabajo de parto

Respuesta A. La placenta previa oclusiva es indicación absoluta de cesárea, ya que el parto vaginal produciría hemorragia masiva. En la paciente estable y sin sangrado se programa cesárea electiva a las 36-37 semanas, antes de que aparezcan contracciones. No hay indicación de cesárea urgente sin sangrado ni compromiso fetal.

3.01.5.003 Doppler materno-fetal

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 19.2 Ecografía Obstétrica: 11-14 Semanas (Aneuploidías y Doppler Uterino) & 20-24 Semanas (Morfológica y Cervicometría) · Tema 19.4 Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler

QUÉ HAY QUE SABER

- Arteria umbilical: evalúa la resistencia placentaria; es el examen clave para distinguir PEG de RCF y etapificar (IP >p95, diástole ausente, diástole reversa).
- Arteria cerebral media: IP bajo = redistribución (vasodilatación cerebral) en hipoxia; velocidad sistólica máxima elevada (>1,5 MoM) = anemia fetal en isoinmunización.

- Ductus venoso: onda a ausente o reversa indica falla cardíaca fetal e interrupción inmediata.
- Arterias uterinas (materno): IP >p95 a las 11–14 semanas predice preeclampsia precoz y RCF → aspirina antes de las 16 semanas.
- Indicaciones: RCF o feto pequeño, preeclampsia, HTA crónica, diabetes con vasculopatía, embarazo gemelar monocorial, isoinmunización.
- Nivel del médico general: indicar la derivación e interpretar el informe; la realización corresponde al especialista.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 168

Paciente cursando un embarazo de 35 semanas, es diagnosticada de restricción de crecimiento fetal en percentil 3. **¿Cuál de las siguientes alteraciones es indicación de interrupción inmediata del embarazo?**

A) Oligohidramnios
B) Aumento de la resistencia de las arterias umbilicales
C) Dilatación de la arteria cerebral media
D) Relación fémur/abdomen mayor a 0,25
E) Ductus venoso con flujo ausente en diástole

Respuesta E. El Doppler del ductus venoso alterado (flujo ausente o, más grave aún, onda a reversa) es el hallazgo más ominoso de la cascada, y su aparición obliga a la interrupción inmediata del embarazo.

Pregunta de práctica

Embarazada de 34 semanas con feto de peso estimado en percentil 2. Doppler: arteria umbilical con índice de pulsatilidad sobre el percentil 95 con flujo diastólico presente, arteria cerebral media con índice de pulsatilidad bajo el percentil 5, índice cerebro-placentario bajo el percentil 5 y ductus venoso normal. Velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media normal. **¿Qué indica el hallazgo en la arteria cerebral media?**

A) Anemia fetal severa
B) Insuficiencia cardíaca fetal descompensada
C) Hallazgo normal para la edad gestacional
D) Malformación vascular cerebral
E) Vasodilatación cerebral por hipoxemia (redistribución o centralización del flujo)

Respuesta E. En la insuficiencia placentaria la hipoxemia fetal provoca vasodilatación cerebral para proteger el cerebro: baja el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media y cae el índice cerebro-placentario (redistribución de flujo). La anemia fetal se evalúa con la velocidad sistólica máxima de la cerebral media, no con su pulsatilidad. La descompensación cardíaca se refleja en el ductus venoso alterado.

3.01.5.004 Drenaje abceso glándula Bartolino

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 20.10 Patología Vulvar y Glándula de Bartolino: Quiste vs Absceso de Bartolino y Liquen Escleroso

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación: absceso de Bartolino (masa fluctuante, eritematosa y muy dolorosa en el tercio posterior del labio mayor); el quiste asintomático no se drena.
- Técnica de elección: marsupialización (incisión vertical en la cara mucosa vestibular, drenaje y sutura de la pared del quiste a la mucosa con puntos separados), deja un orificio permanente.
- Alternativa: catéter de Word (sonda con balón) que se deja 4 semanas para epitelizar el trayecto.
- La punción o incisión simple tiene recidiva >80%: no es tratamiento definitivo.
- Tomar cultivo del pus; antibióticos si hay celulitis, ITS o inmunosupresión; biopsia en mujeres >40 años o masa sólida.
- Nivel: derivar a especialista para el procedimiento; el médico general hace el diagnóstico, analgesia y derivación.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 168

Mujer de 30 años, con actividad sexual, consulta por dolor vulvar y sensación febril. Al examen físico se aprecia un aumento de volumen eritematoso, de 6 centímetros de diámetro, doloroso, en relación a la zona posterior del labio mayor derecho. **¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada?**

A) Cistectomía de Bartolino
B) Drenaje por punción
C) Drenaje quirúrgico simple
D) Iniciar antibióticos orales y esperar el drenaje espontáneo
E) Bartholinocistostomía

Respuesta E. Absceso de Bartolino de 6 cm: la conducta recomendada es la marsupialización (bartholinocistostomía), que drena la colección y crea un orificio permanente, con menor tasa de recidiva que la punción o el drenaje simple.

3.01.5.005 Evaluación anteparto

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 19.3 Evaluación del Bienestar Fetal: Registro Basal No Estresante (RBNE), Perfil Biofísico (Manning) y Doppler Fetal

QUÉ HAY QUE SABER

- Objetivo: detectar hipoxia fetal anteparto; indicaciones: disminución de movimientos fetales, HTA, diabetes, RCF, embarazo prolongado (≥41 semanas), colestasia, RPM.
- Clínica: percepción de movimientos fetales, altura uterina, maniobras de Leopold y auscultación de LCF (110–160 lpm).
- Registro basal no estresante (RBNE): reactivo = ≥2 aceleraciones de 15 lpm por 15 s en 20 min, basal 110–160, variabilidad 6–25, sin desaceleraciones.
- No reactivo a los 20 minutos: prolongar a 40 minutos con estímulo vibroacústico (ciclo de sueño); si persiste, perfil biofísico o Doppler.
- Perfil biofísico (Manning): 8–10 normal; 8 con oligoamnios o ≤6 sugiere hipoxia → derivar/considerar interrupción; ≤4 interrupción inmediata.
- El médico general realiza la evaluación clínica y el RBNE, y deriva los resultados alterados a alto riesgo obstétrico.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Embarazada de 36 semanas, sin patología, con controles normales y feto con crecimiento adecuado en la ecografía de las 32 semanas. Pregunta cómo debe vigilar el bienestar de su hijo en las semanas que faltan para el parto. **¿Cuál es la indicación más adecuada?**

A) Registro basal no estresante semanal desde ahora hasta el parto
B) Perfil biofísico 2 veces por semana
C) Doppler de arteria umbilical semanal
D) Percepción y registro diario de los movimientos fetales, consultando de inmediato si disminuyen
E) Ecografía de crecimiento cada semana

Respuesta D. En el embarazo de bajo riesgo la vigilancia anteparto se basa en los controles habituales y en la percepción materna de los movimientos fetales: ante su disminución debe consultar de inmediato para evaluación con registro basal no estresante. Las pruebas seriadas (RBNE, perfil biofísico, Doppler) se reservan para embarazos de alto riesgo, como RCF, diabetes, SHE o embarazo prolongado.

3.01.5.006 Evaluación intraparto

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 19.17 Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO)

QUÉ HAY QUE SABER

- Fases: latente hasta 5 cm; activa desde 5 cm con progreso ~1 cm/h; expulsivo desde dilatación completa; alumbramiento <30 min.
- Tacto vaginal: dilatación, borramiento, altura de la presentación (planos de Hodge o De Lee), variedad de posición, estado de membranas y características del líquido amniótico (meconio).
- Partograma para detectar distocias: fase activa <1 cm/h o detención ≥2–4 h con buena dinámica.

- Control de dinámica uterina (3–5 contracciones en 10 min), LCF cada 15–30 min en fase activa y cada 5 min en expulsivo (o monitoreo continuo en alto riesgo); signos vitales maternos.
- Monitoreo: categoría I normal; II vigilar y medidas de reanimación intrauterina; III (sin variabilidad con tardías recurrentes o bradicardia) interrupción urgente.
- Bishop >6 = cuello favorable para inducir con oxitocina; ≤6 madurar antes con misoprostol o balón.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 58

Paciente en fase activa de trabajo de parto de término, con progresión de dos a siete centímetros en dos horas, con buena dinámica uterina y membranas rotas. El registro cardíaco fetal muestra buena frecuencia, buena variabilidad y aceleraciones, sin desaceleraciones. **¿Cuál es el diagnóstico más probable del estado fetal?**

A) Registro tipo I
B) Registro tipo II
C) Registro tipo III
D) Registro reactivo
E) Variabilidad disminuida

Respuesta A. Buena frecuencia basal, buena variabilidad, aceleraciones y sin desaceleraciones: es un trazado seguro, categoría uno. "Registro reactivo" es el término del registro basal no estresante sin contracciones, no el de un monitoreo intraparto como este.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 96

Una mujer de 34 años, cursando su primer embarazo de 36 semanas, refiere salida de abundante líquido por los genitales. A la especuloscopía no se observa salida de líquido por el orificio cervical externo, y al tacto vaginal se palpa un cuello sin dilatación, posterior y duro, sin borramiento. Una ecografía muestra oligoamnios. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Indicar antibióticos profilácticos y mantener conducta expectante
B) Inducir el parto con misoprostol
C) Realizar cesárea
D) Inducir el parto con oxitocina
E) Solicitar un perfil biofísico para tomar la conducta definitiva

Respuesta B. RPM de 36 semanas con cuello posterior, duro y sin dilatación es un Bishop bajo. Con cuello inmaduro, la oxitocina no sirve: se induce con misoprostol para madurar y desencadenar el parto a la vez.

3.01.5.007 Examen ginecológico, especuloscopia y tacto bimanual

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 20.9 Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: control ginecológico, toma de PAP, flujo vaginal, sangrado anormal, dolor pélvico, masa o sospecha de prolapso; explicar, pedir consentimiento y ofrecer acompañante.
- Posición ginecológica con vejiga vacía; inspección vulvar (lesiones, Bartolino, atrofia, liquen) y maniobra de Valsalva para prolapso e incontinencia.
- Especuloscopía: introducir el espéculo oblicuo hacia atrás y rotarlo, visualizar cuello (ectropión, lesiones, secreción por OCE, cuello en fresa) y paredes vaginales; tomar PAP y cultivos.
- Tacto bimanual: dos dedos vaginales y mano abdominal para evaluar cuello (dolor a la movilización = PIP o ectópico), tamaño, posición y movilidad uterina, y anexos (masa, dolor).
- Tacto rectovaginal en sospecha de endometriosis (nódulos en Douglas) o para evaluar parametrios en cáncer cervicouterino.
- Contraindicación relativa: no hacer tacto vaginal en metrorragia del 3.er trimestre hasta descartar placenta previa con ecografía.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 30 años consulta por flujo vaginal anormal. Corresponde además tomar su citología cervical (PAP) de tamizaje. **¿Cuál es la secuencia correcta del examen ginecológico?**

A) Inspección de genitales externos, especuloscopia con toma de muestras y luego tacto bimanual
B) Tacto bimanual, luego especuloscopia y toma de muestras
C) Especuloscopia con abundante lubricante y luego inspección vulvar
D) Tacto rectal, luego especuloscopia y finalmente inspección vulvar
E) Toma de muestras sin especuloscopia y tacto bimanual

Respuesta A. El examen se inicia con la inspección de genitales externos, sigue con la especuloscopia (idealmente lubricando solo con agua o suero) para visualizar el cuello y tomar muestras de flujo y PAP, y termina con el tacto bimanual. Hacer el tacto antes altera las muestras y el lubricante interfiere con la citología.

3.01.5.008 Flujo vaginal (pH)

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 20.9 Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Se mide con tira de pH aplicada en la pared lateral vaginal (no en el cuello ni con sangre o semen, que alcalinizan); pH normal 3,8–4,5.
- pH >4,5: vaginosis bacteriana (flujo gris, test de aminas positivo con KOH, clue cells) o tricomoniasis (flujo espumoso verdoso, protozoos móviles al fresco).
- pH normal (<4,5): candidiasis (flujo en leche cortada, prurito, hifas y levaduras con KOH) o flujo fisiológico.
- Criterios de Amsel para vaginosis (3 de 4): flujo homogéneo, pH >4,5, aminas positivo, clue cells >20%.
- El pH alcalino del líquido amniótico (prueba de nitrazina) apoya el diagnóstico de RPM.
- Secreción purulenta por el OCE con cuello friable indica cervicitis: tomar muestra para gonococo y Chlamydia y tratar dual.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 29 años consulta por flujo vaginal de mal olor de 1 semana. Se toma una muestra con tórula del tercio medio de la pared lateral de la vagina y se aplica sobre una tira de pH, que marca 5,0. Al agregar KOH al 10% a la muestra se libera olor a pescado. **¿Cuál es la interpretación correcta?**

A) pH elevado con test de aminas positivo, compatible con vaginosis bacteriana
B) El pH es normal y descarta una vaginosis bacteriana
C) Es el pH ácido característico de la candidiasis
D) La muestra debe tomarse del endocérvix para ser válida
E) El test de aminas positivo confirma una tricomoniasis

Respuesta A. El pH vaginal normal es 3,8 a 4,5. Medido en la pared lateral de la vagina, sin moco cervical, sangre ni semen, un pH sobre 4,5 con aminas positivas apoya vaginosis bacteriana (criterios de Amsel). El moco cervical es alcalino y falsea el resultado; la candidiasis tiene pH normal.

3.01.5.009 Monitorizacion fetal (estresante y no estresante)

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 19.3 Evaluación del Bienestar Fetal: Registro Basal No Estresante (RBNE), Perfil Biofísico (Manning) y Doppler Fetal · Tema 19.17 Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO)

QUÉ HAY QUE SABER

- Registro basal no estresante (anteparto): reactivo con ≥2 aceleraciones de 15 lpm x 15 s en 20 min; basal 110–160 lpm, variabilidad 6–25 lpm. No reactivo: prolongar a 40 min y estimular.
- Test de tolerancia a las contracciones (estresante): con oxitocina o estimulación del pezón hasta 3 contracciones en 10 min; positivo si hay desaceleraciones tardías en ≥50% de las contracciones (indica interrupción).
- Contraindicaciones del test estresante: placenta previa, cesárea corporal previa, RPM, riesgo de parto prematuro.
- Intraparto: desaceleraciones precoces benignas (compresión cefálica), variables (compresión de cordón, las más frecuentes), tardías (insuficiencia placentaria) y patrón sinusoidal (anemia fetal grave).

- Categorías: I normal; II indeterminada (vigilar, cambio de posición, hidratación, suspender oxitocina); III anormal (sin variabilidad con tardías o variables recurrentes o bradicardia) → interrupción urgente.
- El médico general instala, realiza e interpreta el monitoreo y deriva o interrumpe según la categoría.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 25

Mujer de 28 años, con embarazo de 30 semanas, consulta angustiada por no percibir movimientos fetales, sin otros síntomas. Su examen físico es normal. Se le solicita un registro basal no estresante de veinte minutos. **¿Cuál es la conducta más adecuada en este caso?**

A) Tranquilizar a la paciente e indicar que mantenga sus controles habituales
B) Solicitar perfil biofísico
C) Solicitar ecografía obstétrica
D) Repetir el registro basal no estresante por veinte minutos más
E) Realizar un test de tolerancia a las contracciones uterinas

Respuesta D. El trazado es no reactivo, con mínimas aceleraciones. Antes de subir a un estudio mayor, se prolonga el registro veinte minutos más, cumpliendo así los cuarenta minutos que dan tiempo para superar un eventual ciclo de sueño fetal.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 25

Una mujer de 28 años, con embarazo de 30 semanas, consulta angustiada por no percibir movimientos fetales, sin otros síntomas. Su examen físico es normal. Se solicita un registro basal no estresante de 20 minutos, que muestra frecuencia basal normal, solo dos pequeñas desaceleraciones y aceleraciones mínimas, sin ninguna de 15 latidos por 15 segundos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Tranquilizar a la paciente e indicar que mantenga controles habituales
B) Solicitar perfil biofísico
C) Solicitar ecografía obstétrica
D) Repetir registro basal no estresante por 20 minutos más
E) Realizar test de tolerancia a las contracciones uterinas

Respuesta D. El registro no es reactivo: para serlo requiere 2 aceleraciones de 15 latidos por minuto y 15 segundos en 20 minutos. Lo primero es prolongarlo 20 minutos más, porque el feto puede estar en sueño fisiológico. Si persiste no reactivo, recién ahí se pide perfil biofísico.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 58 · texto original del banco, sin revisar

Disminución de los movimientos fetales de 12 horas de evolución con LCF (+) conducta: a. RBNE

B) Test de tolerancia a las contracciones
B) Interrupción del embarazo
C) Maduración pulmonar y observación
D) Cesárea de urgencia
E) Inducción del parto

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: (opción A). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención. Las opciones alternativas (Test de tolerancia a las contracciones, Interrupción del embarazo) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la

3.01.5.010 Parto normal

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 19.16 Trabajo de Parto Normal, Mecanismos del Parto en Cefálica, Score de Bishop y Manejo Activo del Alumbramiento

QUÉ HAY QUE SABER

- Fases: dilatación (latente hasta 5 cm, activa desde 5 cm), expulsivo, alumbramiento (<30 min) y cuarto período (vigilancia estricta 2 h por riesgo de hemorragia).
- Mecanismo: encajamiento y descenso, flexión, rotación interna a occipito-púbica, desprendimiento por deflexión, rotación externa (restitución) y salida de hombros (anterior primero).
- Durante el expulsivo: protección del periné, episiotomía solo selectiva, LCF cada 5 min; pujo dirigido con dilatación completa.
- Manejo activo del alumbramiento obligatorio: oxitocina 10 UI IM/EV tras salida del hombro anterior, tracción controlada del cordón con contratracción suprapúbica y masaje uterino; reduce >60% la hemorragia posparto.

- Revisar placenta completa y canal del parto (desgarros), pinzamiento tardío del cordón (1–3 min) y apego piel a piel en RN vigoroso.
- Hemorragia posparto (>1.000 mL o hipovolemia): 4 T (tono 70%, trauma, tejido, trombina); masaje bimanual, oxitocina, ácido tranexámico 1 g EV; ergometrina contraindicada en hipertensas.

PREGUNTAS (1)

Pregunta del libro · Tema 19.16

Una mujer de 41 semanas de gestación ingresa para inducción de parto por embarazo en vías de prolongación. Al tacto vaginal se encuentra un cuello uterino en posición posterior, consistencia firme, borramiento del 20%, orificio cervical cerrado (0 cm) y cabeza fetal flotante en plano -3 de Lee. ¿Cuál es la conducta de elección para iniciar la inducción del parto?

A) Inducción directa con infusión endovenosa continua de Oxitocina a dosis crecientes
B) Maduración cervical previa con Misoprostol vaginal (25-50 mcg) o métodos mecánicos transcervicales
C) Realizar amniotomía precoz inmediata antes de cualquier medicación
D) Cesárea electiva inmediata sin permitir prueba de maduración cervical
E) Administración de tocolíticos orales y control en 1 semana

Respuesta B. A) Incorrecta. Inducir con oxitocina un cuello con Bishop muy bajo (6), se inicia la oxitocina. C) Incorrecta. La rotura artificial de membranas con feto flotante en -3 conlleva un gravísimo riesgo de prolapso de cordón umbilical. D) Incorrecta. El Bishop desfavorable no es indicación de cesárea primaria si no hay contraindicación de parto vaginal. E) Incorrecta. A las 41 semanas el embarazo no debe prolongarse sin inducir.

3.01.5.011 Perfil biofisico fetal

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 19.3 Evaluación del Bienestar Fetal: Registro Basal No Estresante (RBNE), Perfil Biofísico (Manning) y Doppler Fetal

QUÉ HAY QUE SABER

- Evaluación ecográfica más monitoreo de 5 variables, 0 o 2 puntos cada una: RBNE reactivo, movimientos respiratorios (≥1 episodio de 30 s), movimientos corporales (≥3), tono (extensión y flexión) y líquido amniótico (bolsillo ≥2 cm).
- Interpretación: 10/10 u 8/10 con líquido normal = feto sano; 8/10 con oligoamnios = hipoxia crónica, considerar interrupción.
- 6/10: dudoso, repetir en 24 h o interrumpir si es término; ≤4/10: asfixia probable, interrupción inmediata.
- Indicaciones: RBNE no reactivo, RCF, HTA, diabetes, embarazo prolongado, disminución de movimientos fetales.
- Los primeros parámetros en alterarse con la hipoxia aguda son la reactividad y los movimientos respiratorios; el líquido amniótico refleja hipoxia crónica.
- Nivel del médico general: derivar a especialista para su realización e interpretar el informe.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 83

Mujer de 30 años, cursando un embarazo de 40 semanas, consulta por ausencia de movimientos fetales. Se le realiza un perfil biofísico, que resulta 8/10, con oligoamnios. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Dejar a evolución espontánea
B) Interrumpir el embarazo ahora, por cesárea
C) Inducir el parto en este momento
D) Realizar cesárea al inicio del trabajo de parto
E) Inducir el parto a las 41 semanas

Respuesta C. Un perfil biofísico de 8/10 con oligoamnios, en un embarazo ya de término, es indicación de interrumpir por el riesgo de hipoxia progresiva. La cesárea no es obligatoria: al ser un puntaje 8 y no uno crítico, se puede intentar la inducción del parto.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 24 · texto original del banco, sin revisar

Embarazo a término, 39 semanas con PBF 6/8 con LA 0/2 conducta

A) Inducir b. Cesárea

C) Eco doppler seriado Según entiendo, era un OHA idiopático, lo que no es malo, pero hay que hacerle eco doppler para ver si hay insuficiencia placentaria, era muy similar a una de un ensayo.. si pero como estaba de termino mejor la interrumpes…, se suelen interrumpir a las 40, tenia 37

C) Interrupción del embarazo

D) Maduración pulmonar y observación

E) Cesárea de urgencia

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Inducir b. Cesárea (opción A). La resolución quirúrgica urgente constituye la única medida definitiva capaz de controlar el foco séptico, revertir la isquemia o evitar la muerte materna/fetal frente a este compromiso clínico severo.

3.01.5.012 Prueba de trabajo de parto

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 19.17 Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO)

QUÉ HAY QUE SABER

- Prueba de trabajo de parto: conducción en fase activa con buena dinámica (oxitocina si es necesario) para evaluar si hay progreso ante sospecha de desproporción céfalo-pélvica relativa o en cesárea anterior.
- Requisitos: presentación cefálica, fase activa, membranas rotas (amniotomía), dinámica adecuada (3–5 en 10 min), monitoreo fetal continuo y posibilidad de cesárea inmediata.
- Se evalúa la dilatación y el descenso a las 2–4 h: progreso = continuar parto vaginal; sin progreso o con signos de DCP (suturas cabalgadas, caput, sin descenso) = cesárea.
- En 1 cesárea segmentaria previa: candidata si no hay otra indicación de cesárea; evitar prostaglandinas (misoprostol) y vigilar signos de rotura uterina (dolor, bradicardia fetal, ascenso de la presentación).
- Contraindicaciones: cesárea corporal o 2 o más previas, rotura uterina previa, placenta previa, presentación anómala, DCP absoluta.
- Suspender ante registro fetal categoría III o sospecha de rotura uterina.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 109

Paciente de 31 años entra en trabajo de parto a las 38 semanas. Al examinarla se constatan 3 contracciones uterinas en 10 minutos y el tacto vaginal muestra 5 cm de dilatación, membranas íntegras y presentación cefálica en espinas -1. El registro de frecuencia cardiaca fetal es normal. Se reevalúa a las 3 horas, sin cambios obstétricos. **¿Cuál es la conducta de elección?**

A) Mantener una conducta expectante por 1 hora y reevaluar

B) Administrar misoprostol

C) Realizar cesárea

D) Realizar rotura artificial de membranas y administrar anestesia epidural

E) Administrar oxitocina endovenosa en goteo

Respuesta D. Fase activa sin progreso con membranas íntegras: antes de diagnosticar distocia se realiza una prueba de trabajo de parto, optimizando las condiciones con rotura artificial de membranas y analgesia epidural, y luego oxitocina si la dinámica es insuficiente. Si no progresa tras la prueba, se indica cesárea.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 159 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 31 años, entra en trabajo de parto a las 37+6 semanas y al exami- narla se constatan 3 contracciones uterinas en 10 minutos y su tacto vaginal myestra 5 cm de dilatación cervical, membranas íntegras y presentación cefálica, en espinas -1. El registro de la frecuencia cardiaca fetal está dentro de rangos normales. Se la evalúa a las 3 horas, manteniéndose sin cambios obstétricos. La conducta de elección es:

A) Mantener una conducta expectante por 1 hora y reevaluar
B) Realizar fórceps
C) Realizar cesárea
D) Realizar rotura artificial de membranas y administrar anestesia epidural
E) Administrar oxitocina endovenosa en goteo

Respuesta D. Tienen una fase activa lenta, que requiere de una prueba de trabajo de parto (romper membranas, anestesia y goteo oxitócico si las contracciones son menores a 3 en 10 min: no es el caso).

3.01.5.013 Taponaje vaginal

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 20.13 Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación: hemorragia genital aguda por cáncer cervicouterino (cervicorragia), sangrado de lesiones vaginales o desgarros, como medida hemostática transitoria.
- Técnica: posición ginecológica, espéculo y visualización del sitio de sangrado; rellenar el fondo de saco vaginal con compresa o gasa larga (idealmente húmeda o con agente hemostático) en forma ordenada y compresiva.
- Instalar sonda Foley vesical (el taponaje comprime la uretra), registrar el número de compresas y retirarlo en 24–48 h.
- Asociar estabilización hemodinámica (vías gruesas, cristaloides, transfusión si es necesario) y ácido tranexámico.
- Complicaciones: infección (considerar antibiótico profiláctico), retención urinaria, olvido de material.
- Tras el taponaje, derivar urgente a ginecología oncológica para radioterapia hemostática o manejo definitivo.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Mujer de 48 años, con cáncer cervicouterino etapa IIIB en espera de radioterapia, consulta por metrorragia abundante. Tras volemización está hemodinámicamente estable, pero el sangrado desde el tumor cervical persiste pese a ácido tranexámico endovenoso. **¿Cuál es la medida inmediata más adecuada para controlar el sangrado?**

A) Alta con anticonceptivos orales combinados
B) Histerectomía radical de urgencia
C) Legrado uterino
D) Conización cervical
E) Taponamiento vaginal compresivo con gasa

Respuesta E. El sangrado de un cáncer cervicouterino avanzado se controla de inmediato con taponamiento vaginal compresivo, habitualmente con sonda Foley, que se retira o recambia en 24 a 48 horas, mientras se coordina radioterapia hemostática o embolización. La cirugía no está indicada en etapa IIIB y el legrado o la conización aumentan el sangrado.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 38 · texto original del banco, sin revisar

Ca cu con sangrado activo q no responde a ac tranexámico: a. Taponamiento vaginal (REPETIDA DE AÑO ANTERIOR)

B) Ligar arterias cervicales
B) Ninguna de las anteriores es correcta
C) Todas las anteriores son correctas
D) No se dispone de información suficiente
E) Otra alternativa no descrita

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Ligar arterias cervicales, Ninguna de las anteriores es correcta) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paci

3.01.5.014 Toma de Papanicolau (incluye hacer el frotis)

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 20.13 Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía

QUÉ HAY QUE SABER

- Tamizaje cada 3 años en mujeres de 25 a 64 años; idealmente fuera de la menstruación, sin duchas vaginales, óvulos ni relaciones sexuales 48 h antes.
- Especuloscopía sin lubricante (o mínimo con agua) para visualizar el cuello y la zona de transformación.
- Toma exocervical con espátula de Ayre girando 360° y endocervical con cepillo (citobrush) girando 180–360°; en la embarazada el cepillo se usa con suavidad o se prefiere solo la espátula.
- Extender en el portaobjetos en capa delgada y uniforme (exocérvix y endocérvix), fijar inmediatamente (alcohol o spray fijador) para evitar artefactos de secado; rotular con datos de la paciente.
- Si se ve una lesión sospechosa no basta el PAP: derivar a colposcopía con biopsia.
- Registrar y asegurar la entrega del resultado; no tomar PAP con metrorragia activa ni infección florida (tratar y luego tomar).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 35 años acude al CESFAM para su citología cervical de tamizaje. No está menstruando y no ha tenido relaciones sexuales ni usado óvulos en las últimas 48 horas. **¿Cuál es la técnica correcta para tomar el PAP?**

A) Muestra solo del fondo de saco vaginal posterior con tórula
B) Muestra de exocérvix con espátula de Ayre y de endocérvix con cepillo, extendido delgado en el portaobjetos y fijación inmediata
C) Tomar la muestra después del tacto bimanual, usando abundante lubricante
D) Extender la muestra y dejarla secar al aire 10 minutos antes de fijarla
E) Extender la muestra en capa gruesa para aumentar la celularidad

Respuesta B. El PAP debe incluir la zona de transformación: exocérvix con espátula de Ayre y endocérvix con cepillo. Se extiende en capa delgada y uniforme y se fija de inmediato, en menos de 10 segundos, para evitar artefactos por desecación. El lubricante, la sangre y el tacto previo alteran la muestra.